



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

ANGÉLICA XAVIER DA SILVA

**AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADES AMIGAS DA
PRIMEIRA INFÂNCIA EM RECIFE-PE A PARTIR DA FRAMEWORK RE-AIM**

Recife

2025

ANGÉLICA XAVIER DA SILVA

**AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADES AMIGAS DA
PRIMEIRA INFÂNCIA EM RECIFE-PE A PARTIR DA FRAMEWORK RE-AIM**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente.

Área de Concentração: Saúde da Criança e do Adolescente

Linha de Pesquisa: Avaliação das condições de saúde nas políticas, programas e serviços.

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Wanderleya de Lavor Coriolano-Marinus

Coorientadora: Prof^a Dra. Sílvia Wanick Sarinho

Recife

2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Catálogo de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Silva, Angélica Xavier da.

Avaliação da implementação da iniciativa unidades amigas da primeira infância em Recife-PE a partir da Framework RE-AIM / Angélica Xavier da Silva. - Recife, 2025.

199f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Médicas, Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, 2025.

Orientação: Maria Wanderleya de Lavor Coriolano-Marinus.

Coorientação: Sílvia Wanick Sarinho.

Inclui Referências, Apêndices e Anexos.

1. Saúde da Criança; 2. Ciência da Implementação; 3. Avaliação de Programas e Projetos de Saúde. I. Coriolano-Marinus, Maria Wanderleya de Lavor. II. Sarinho, Sílvia Wanick. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADES AMIGAS DA
PRIMEIRA INFÂNCIA EM RECIFE-PE A PARTIR DA FRAMEWORK RE-AIM

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente do Centro de Ciências Médicas da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente.
Área de Concentração: Saúde da Criança e do Adolescente.

Aprovada em: 18/12/2025

Prof.^a Dra. Silvia Wanick Sarinho (Examinadora Interna)
Universidade Federal de Pernambuco- UFPE

Prof.^a Dra. Débora Farias Batista Leite (Examinadora Interna)
Universidade Federal de Pernambuco- UFPE

Prof.^a Dra. Ana Coelho de Albuquerque (Examinadora Externa)
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- IMIP

Prof.^a Dra. Suzana Lins da Silva (Examinadora Externa)
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- IMIP

Prof.^a Dra. Weslla Karla Albuquerque Silva de Paula (Examinadora Externa)
Universidade Federal de Pernambuco- UFPE

Dedico esta tese à minha filha, Maria Júlia Xavier Valentim, esse ser humano empático, sorridente, inteligente e amorosa. A cada raiar do dia, no qual me lembro do seu brilhante sorriso, que me impulsiona a seguir a jornada. Ao meu amor, minha flor, minha sempre menina.

*Nada a temer senão o correr da luta
Nada a fazer senão esquecer o medo*

*(...) Longe se vai
Sonhando demais
Mas onde se chega assim
Vou descobrir o que me faz sentir
Eu, caçador de mim*

Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá (1981)

Intérprete: Milton Nascimento

AGRADECIMENTOS

Gratidão!

Agradecer é um dos maiores prazeres na minha existência! E, nessa travessia, há muitos...

Agradeço a Deus, dono do tempo, esse, que é implacável.

A Jesus Cristo, que foi certamente o ser mais político que por aqui passou. Pois o verbo se tornou carne, e habitou entre nós.

Agradeço a minha filha, Maria Júlia, que em dias de escuridão é lâmpada no caminho, ela me ensina sobre o amor, e também o quanto é difícil e grandiosa a responsabilidade do maternar... Te peço desculpas pela ausência durante esses anos dedicados aos estudos e trabalhos. Te amo tanto, que chega a doer.

Aos meus pais, José Maria e Maria do Carmo, por todo o suporte, educação, valores e princípios tão valiosos que me ensinaram. Obrigado, infinitamente... Obrigado.

Às minhas irmãs, Erika e Angela, que formam comigo o tripé do amor. Agradeço o acolhimento, abraços e apoio em várias camadas da minha vida. Com vocês o mundo é mais bonito.

Ao meu sobrinho Raphael Patrick, pelas palavras de incentivo, e por me olhar com os olhos do amor, suas palavras de afirmação são muitos presentes na minha memória.

Ao meu companheiro, Thiago Rafael, sou profundamente grata pelo tempo dedicado, o silêncio que tantas vezes é o mais precioso gesto de cuidado, e por ser o melhor parceiro nas viagens, shows, cinemas e teatros. Agradeço pela presença constante, palavras de apoio e zelo.

À minha tão querida e presente orientadora, Prof.^a Wanderleya Marinus, por todo o apoio, paciência e por ter acreditado no processo durante essa caminhada. Pela escuta atenta, contribuições que ampliaram meu olhar e pela sensibilidade com que conduziu cada etapa, sempre com sabedoria, compromisso e generosidade.

À minha coorientadora, Prof^ª Silvia Sarinho, sempre acessível, atenta e presente durante esses mais de quatro anos, obrigada.

Ao meu querido Professor Dr. Paulo Goes, por ter me apresentado ao PPGSCA, quando fui residente, e também pela atenção e cuidado.

Às minhas amigas e companheiras do IMIP nessa jornada: Carmina Santos, Joane Mota e o meu mais jovem amigo, Diógenes Passos. Sem o apoio de vocês a conclusão desse trabalho não seria possível.

À minha preciosa Professora Tereza Bezerra, por todo seu apoio em tantas camadas da minha vida, pelos olhares de certeza, confiança e carinho. Jamais esquecerei tudo o que a senhora fez por mim.

À minha amiga Andreia Soares, a quem chamo de herança da UPE. Agradeço o carinho tão orgânico de sempre.

Às minhas amigas e parceiras da Faculdade Pernambucana de Saúde: Tatiana Montenegro, Renata Lopes e Vita Mongiovi, elas que tanto me ensinam todos os dias. Agradeço o apoio, carinho e *feedbacks*.

À Caline Helen, e Matheus Simplicio sempre solícitos, e como sempre refiro..., mais aprendo do que ensino com os estudantes, eles que me tornam quem sou. Obrigada.

Ao meu querido professor Arquimedes Monteiro de Melo (In memoriam), pelo incentivo nos dias nebulosos na Universidade, com suas palavras assertivas e carinhosas. Deixou muitas saudades na sua tão breve passagem terrena.

A Rafael Gomes, por ter me ensinado a ver meu corpo/templo como força motriz, e transcender vários traumas que os tempos insistiam em manter. Pela escuta ativa, e incentivo durante os nossos treinos matinais. Obrigado, coração!

Ao meu orientador de mestrado, Prof. Sérgio Campello por ter me ensinado a ser docente, através de suas atitudes éticas e proximidade dos seus orientandos. Tenho muito orgulho de usar para sempre o vocativo: meu orientador.

RESUMO

Objetivo: Avaliar a implementação da Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI), em duas Unidades de Saúde da Família do município do Recife, Pernambuco, a partir do modelo RE-AIM. **Método:** Pesquisa avaliativa, orientada pelo referencial da Ciência da Implementação e pelo modelo RE-AIM, que adotou o estudo de caso comparativo como abordagem metodológica, a partir de dados qualitativos e quantitativos, analisados de forma integrada, envolvendo duas Unidades de Saúde da Família, denominadas Caso 1 e Caso 2. Os dados qualitativos foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas a partir de um roteiro previamente elaborado e fundamentado das dimensões do framework RE-AIM (alcance, efetividade, adoção, implementação e manutenção), com 19 participantes, sendo profissionais das unidades e gestores da iniciativa. Esses dados foram analisados por meio da análise temática, orientada pelas dimensões do modelo RE-AIM. Já os dados quantitativos, indicadores de saúde monitorados pela iniciativa UAPI, foram analisados de forma descritiva e inferencial, comparando os resultados entre as duas unidades nos quadrimestres dos ciclos avaliativos. **Resultados:** A análise dos resultados revelou um cenário de contrastes, o alcance das ações foi positivo, facilitado por visitas domiciliares e pela busca ativa, e a adoção da iniciativa foi impulsionada pela motivação profissional. Em contrapartida, a implementação surgiu como a dimensão mais desafiadora, com barreiras como sobrecarga de trabalho, infraestrutura precária, falhas nos sistemas de informação e uma percepção dos profissionais quanto ao desalinhamento entre a teoria da capacitação e a prática cotidiana. Adicionalmente, a efetividade foi limitada por determinantes sociais, e a manutenção das práticas mostrou-se frágil pela ausência de monitoramento contínuo. Esses desafios se refletem nos resultados dos indicadores analisados. Embora o acompanhamento pré-natal e o peso infantil tenham demonstrado uma tendência geral de melhoria ao longo do tempo, a evolução foi marcada por oscilações e desempenhos desiguais entre os casos estudados. Tal inconsistência foi mais evidente em indicadores que exigem maior articulação do cuidado, como saúde bucal e puericultura, confirmando as dificuldades de implementação e sustentabilidade apontadas pelos profissionais. **Considerações Finais:** O estudo evidenciou que a iniciativa fortaleceu o cuidado à criança na Atenção Primária, mas revelou desafios que exigem respostas no campo das políticas públicas. Recomenda-se o fortalecimento de mecanismos institucionais que assegurem continuidade às ações, com apoio técnico permanente, valorização das equipes e gestão intersetorial articulada. Políticas públicas sensíveis ao território e orientadas por processos de monitoramento e participação social são fundamentais para consolidar práticas sustentáveis que promovam o desenvolvimento integral das crianças.

Palavras chave: Saúde da Criança. Atenção Primária à Saúde. Ciência da Implementação Avaliação em Saúde. Avaliação de Programas e Projetos de Saúde.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the implementation of the Early Childhood Friendly Unit (ECU) Initiative in two Family Health Units in the municipality of Recife, Pernambuco, using the RE-AIM model. **Method:** Evaluative research, guided by the Implementation Science framework and the RE-AIM model, which adopted a comparative case study as a methodological approach, based on qualitative and quantitative data, analyzed in an integrated manner, involving two Family Health Units, named Case 1 and Case 2. Qualitative data were collected through semi-structured interviews, conducted using a previously prepared and grounded script based on the dimensions of the RE-AIM framework (reach, effectiveness, adoption, implementation, and maintenance), with 19 participants, including professionals from the units and managers of the initiative. These data were analyzed using thematic analysis, guided by the dimensions of the RE-AIM model. Quantitative data, health indicators monitored by the UAPI initiative, were analyzed descriptively and inferentially, comparing the results between the two units in the four-month periods of the evaluation cycles. **Results:** The analysis of the results revealed a scenario of contrasts; the reach of the actions was positive, facilitated by home visits and active outreach, and the adoption of the initiative was driven by professional motivation. Conversely, implementation emerged as the most challenging dimension, with barriers such as work overload, precarious infrastructure, failures in information systems, and a perception among professionals regarding the misalignment between training theory and daily practice. Additionally, effectiveness was limited by social determinants, and the maintenance of practices proved fragile due to the absence of continuous monitoring. These challenges are reflected in the results of the analyzed indicators. Although prenatal care and infant weight showed a general trend of improvement over time, the evolution was marked by fluctuations and unequal performance among the cases studied. This inconsistency was most evident in indicators that require greater coordination of care, such as oral health and childcare, confirming the implementation and sustainability difficulties pointed out by professionals. **Final Considerations:** The study showed that the initiative strengthened child care in Primary Care, but revealed challenges that require responses in the field of public policies. It is recommended to strengthen institutional mechanisms that ensure continuity of actions, with permanent technical support, appreciation of the teams and articulated intersectoral management. Public policies sensitive to the territory and guided by monitoring processes and social participation are fundamental to consolidating sustainable practices that promote the integral development of children.

Keywords: Child Health. Primary Health Care. Implementation Science. Health Evaluation. Evaluation of Health Programs and Projects.

Figura 1. Marcos normativos e programáticos voltados à primeira infância no Brasil	27
Figura 2. Ciclo Avaliativo da UAPI	36
Figura 3. Dimensões da <i>framework</i> RE-AIM	40
Figura 4. Dimensões do RE-AIM adaptadas para a avaliação da iniciativa UAPI	41
Figura 5. Etapas da análise dos dados de acordo com Braun e Clarke	50
Figura 6. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal	111
Figura 7. Proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV	111
Figura 8. Proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até 6 meses	113
Figura 9. Percentual de crianças menores de 5 anos com peso adequado para a idade	115
Figura 10. Proporção de crianças até 01 ano, 11 meses e 29 dias com 1 ou mais consultas odontológicas programáticas	117
Figura 11. Proporção de crianças com 2 anos completos que tiveram 9 ou mais consultas de Puericultura	119

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Elementos facilitadores da dimensão de alcance do Caso 1, Caso 2 e Gestão	58
Quadro 2. Elementos de barreira na dimensão de alcance do Caso 1 e Caso 2	62
Quadro 3. Elementos facilitadores na dimensão de efetividade do Caso 1, Caso 2 e Gestão	63
Quadro 4. Elementos de barreiras na dimensão de efetividade do Caso 1, Caso 2 e Gestão	66
Quadro 5. Elementos facilitadores na dimensão de adoção do Caso 1, Caso 2 e Gestão	68
Quadro 6. Elementos de barreira na dimensão de adoção do Caso 1, Caso 2 e Gestão	70
Quadro 7. Elementos facilitadores na dimensão de implementação do Caso 1, Caso 2 e Gestão	72
Quadro 8. Elementos de barreira na dimensão de implementação do Caso 1, Caso 2 e Gestão	74
Quadro 9. Elementos facilitadores na dimensão de manutenção do Caso 1, Caso 2 e Gestão	81
Quadro 10. Elementos de barreira na dimensão de manutenção do Caso 1, Caso 2 e Gestão	84
Quadro 11. Facilitadores e barreiras por dimensão Caso 1, 2 e Gestão	86

Tabela 1. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal no período de quatro meses	107
Tabela 2. Proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV	110
Tabela 3. Proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até 6 meses	112
Tabela 4. Percentual de crianças menores de 5 anos com peso adequado para a idade	114
Tabela 5. Proporção de crianças até 01 ano, 11 meses e 29 dias com 1 ou mais consultas odontológicas programáticas.	116
Tabela 6. Proporção de crianças com 2 anos completos que tiveram 9 ou mais consultas de Puericultura	118

LISTA DE SIGLAS E ABBREVIACÕES

AIDPI	Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância
APS	Atenção Primária à Saúde
CI	Ciência da Implementação
CSC	Caderneta de Saúde da Criança
DNCr	Departamento Nacional da Criança
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente
ESF	Estratégia Saúde da Família
FNC	<i>Framework Nurturing Care</i>
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IHAC	Iniciativa Hospital Amigo da Criança
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OMS	Organização Mundial da Saúde
PAISC	Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança
PNAISC	Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
PNI	Programa Nacional de Imunizações
PNIAM	Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno
PNIPi	Política Nacional Integrada da Primeira Infância
PSF	Programa Saúde da Família
RNPI	Rede Nacional Primeira Infância
SUS	Sistema Único de Saúde
UAPI	Unidade Amiga da Primeira Infância
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	18
2 REFERENCIAL TEÓRICO	26
2.1 HISTÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS NO BRASIL.....	26
2.1.1 RECORTE TEMPORAL NO MUNICÍPIO DO RECIFE.....	32
2.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (DPI).....	33
2.3 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	36
2.4 METODOLOGIA UAPI	40
2.5 CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO (CI) e A <i>FRAMEWORK RE-AIM</i>	43
3 PERCURSO METODOLÓGICO	50
3.1 TIPO DO ESTUDO	50
3.2 CONTEXTO DA PESQUISA	50
3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO.....	54
3.4 PROCEDIMENTOS NA COLETA DE DADOS.....	54
3.5 ANÁLISE DOS DADOS	56
3.5.1 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS.....	56
3.5.2 ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS.....	57
4 ASPECTOS ÉTICOS.....	60
5 RESULTADOS.....	61
5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES	61
5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	61
5.2.1 CASO 1	61
5.2.2 CASO 2.....	62
5.3 AVALIAÇÃO COM BASE NAS DIMENSÕES DO MODELO RE-AIM, DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA INICIATIVA UAPI NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	63

5.3.1 ELEMENTOS FACILITADORES DA DIMENSÃO DE ALCANCE DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	63
5.3.2 ELEMENTOS DE BARREIRA DA DIMENSÃO DE ALCANCE DO CASO 1 E CASO 2.....	67
5.3.3 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE EFETIVIDADE DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	69
5.3.4 ELEMENTOS DE BARREIRAS NA DIMENSÃO DE EFETIVIDADE DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	71
5.3.5 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE ADOÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	73
5.3.6 ELEMENTOS DE BARREIRA NA DIMENSÃO DE ADOÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	76
5.3.7 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.	77
5.3.8 ELEMENTOS DE BARREIRA NA DIMENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	79
5.3.9 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE MANUTENÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO	85
5.3.10 ELEMENTOS DE BARREIRAS NA DIMENSÃO DE MANUTENÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.....	88
5.4 COMPARAÇÃO DE ELEMENTOS ENTRE OS CASOS 1, 2 E GESTÃO	91
5.4.1 COMPARAÇÕES DOS CASOS A PARTIR DAS DIMENSÕES DO RE-AIM	96
5.5 PERCEPÇÕES, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS SOBRE O CICLO DE CAPACITAÇÃO DO CASO 1	108
5.5.1 RELAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA INICIATIVA UAPI DO CASO 1.....	109
5.5.2 PERCEPÇÕES, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS SOBRE O CICLO DE CAPACITAÇÃO DO CASO 2	109
5.5.3 RELAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA INICIATIVA UAPI DO CASO 2.....	110

5.6 ANÁLISE QUANTITATIVA.....	111
5.6.1 PROPORÇÃO DE GESTANTES COM 6 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO PERÍODO DE 4 MESES	112
5.6.2 PROPORÇÃO DE GESTANTES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV	114
5.6.3 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ 6 MESES.....	117
5.6.4 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS COM PESO ADEQUADO PARA A IDADE.....	119
5.6.5 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS ATÉ 1 ANO, 11 MESES E 29 DIAS COM 1 OU MAIS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMÁTICAS.....	121
5.6.6 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM 2 ANOS COMPLETOS QUE TIVERAM 9 OU MAIS CONSULTAS DE PUERICULTURA.....	123
6 DISCUSSÃO.....	125
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	139
REFERÊNCIAS	141
APÊNDICES.....	157
ANEXOS	194

1 INTRODUÇÃO

A primeira infância é o período que compreende de 0 a 6 anos, e se caracteriza como o momento de profundas e intensas modificações biológicas e psicossociais, que promovem importantes aquisições nos domínios motor, afetivo, social e de desenvolvimento (LIKHAR; BAGHEL; PATIL, 2022). As experiências sensoriais, estimulação e a aquisição de linguagem durante os primeiros anos influenciam a formação das sinapses, mielinização e conectividade neuronal, influenciando o desenvolvimento da criança (CRESPI; FERREIRA; OLIVEIRA, 2020; NOBRE et al, 2021).

Evidências da neurociência e da psicologia mostram que as experiências na primeira infância são decisivas para o desenvolvimento integral. Ambientes de estímulo e vínculos afetivos favorecem competências cognitivas, sociais e emocionais, enquanto situações de privação ampliam desigualdades e geram impactos negativos duradouros (ESLINGE et al., 2021; JIANG et al., 2024; CACHIA; MANGIN; DUBOIS, 2025). Nesse período, consolidam-se as bases que influenciam o desempenho escolar, a inserção no trabalho, a saúde e a participação social. Assim, investir na primeira infância constitui medida de equidade e estratégia com retornos sociais e econômicos significativos (UNESCO, 2024; BAEK et al., 2025).

Entretanto, o reconhecimento da relevância desse período não tem sido suficiente para assegurar a efetiva implementação de práticas integradas e sustentáveis nos territórios por meio de políticas públicas integradas. Apesar dos avanços normativos e das iniciativas intersetoriais voltadas à primeira infância, ainda são vivenciados desafios significativos na consolidação de práticas efetivas de cuidado e promoção do desenvolvimento infantil no cotidiano dos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS). A implementação de estratégias demanda a atuação articulada de gestores e profissionais, o fortalecimento da intersetorialidade e a incorporação de práticas baseadas em evidências (SOUZA et al, 2023).

Diante desse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco Mundial, por meio de documentos e agendas globais, reforçam a importância de investimentos intersetoriais constantes para a primeira infância (HECKMAN, 2006; ENGLE et al, 2011; WHO, 2023; BAEK, 2025). Com 350 milhões de crianças sem acesso a serviços essenciais de cuidados na primeira infância em todo o mundo (WORLD BANK, 2021), os benefícios do investimento vão além do desenvolvimento infantil, incluindo a participação das mulheres na força de trabalho e o crescimento econômico.

Os investimentos na primeira infância superam a esfera individual e configuram-se como estratégias estruturantes para o desenvolvimento humano e social. Evidências científicas demonstram que políticas e programas voltados a essa etapa geram ganhos duradouros em capital humano e contribuem para o desenvolvimento sustentável (DRAPER et al., 2024). O cuidado integral e a promoção de oportunidades equitativas reduzem desigualdades, melhoram indicadores de saúde e favorecem a formação de cidadãos mais saudáveis e produtivos, impacta comunidades e promove sociedades mais justas e resilientes (GEEHOLED, 2020; BLACK; TRUDE; KOWALSKI, 2021).

No contexto brasileiro, observa-se um processo gradual de institucionalização de políticas públicas voltadas ao cuidado integral das crianças, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC, 2015), (BRASIL, 2018), o Marco Legal da Primeira Infância, (BRASIL, 2017) e mais atualmente, a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (BRASIL, 2025): reconhecem que o desenvolvimento infantil depende não somente de ações setoriais isoladas, mas da articulação entre saúde, educação, assistência social e outros campos. Esse processo reafirma o compromisso do Estado brasileiro em consolidar estratégias intersetoriais que assegurem a efetividade dos direitos da criança (CRESPI; NORO; NÓBILE, 2023).

Apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas com a ampliação das políticas públicas de saúde e educação, persistem desigualdades sociais, econômicas e regionais que impactam o acesso das crianças e suas famílias a serviços essenciais (VIEIRA & HONORATO, 2023). Essas disparidades se refletem em diferenças nos indicadores de mortalidade infantil, no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e nas oportunidades de aprendizagem nos primeiros anos de vida. O resultado é um cenário em que parte significativa dessa população enfrenta barreiras para acessar cuidados integrais e equânimes (MARINHO et al, 2020).

De acordo com o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, as crianças de 0 a 6 anos representam 8,92% da população total, o que corresponde a 18.117.158 pessoas, e no estado de Pernambuco, 9,29%, o que equivale a 841.894 (IBGE, 2022). Dessas, 54,99% (462.978) são pardas e 615.354 estão cadastradas no Programa Bolsa Família. Apesar de o estado ter apresentado uma redução expressiva na taxa de mortalidade infantil, de aproximadamente 42 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para cerca de 12,9 em 2023, esses índices ainda superam a média nacional e concentram-se em regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.

A permanência dessas desigualdades evidencia a necessidade de fortalecer a atuação da APS, instância fundamental para garantir o acesso equânime e o cuidado integral às crianças e suas famílias. (MENEZES; SANTOS; GAVAZZA, 2021). Nesse cenário, é necessário que os profissionais de saúde desenvolvam competências que lhes permitam atuar de forma resolutiva, e também a capacidade de estabelecer vínculos, apoiar o exercício da parentalidade e fortalecer a autonomia das famílias na promoção do desenvolvimento infantil (RETICENA; GOMES; FRACOLLI, 2022).

Como resposta às demandas identificadas na atenção primária, a UNICEF e a Prefeitura da Cidade do Recife pactuaram a implementação da Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI). A proposta constitui uma estratégia de fortalecimento das práticas de cuidado e de promoção do desenvolvimento infantil, alinhada aos princípios de integralidade e intersetorialidade do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa busca qualificar o trabalho das equipes de saúde, estimulando o acolhimento, o vínculo e o apoio à parentalidade, além de promover ambientes mais responsivos às necessidades da criança e da família. No Recife, a iniciativa foi desenvolvida em dois ciclos, o primeiro iniciado no terceiro quadrimestre de 2021 até o último quadrimestre de 2024.

Ela contempla um modelo que articula ações intersetoriais, práticas educativas e assistenciais, com foco na integralidade do cuidado e na participação ativa das famílias, envolvendo prioritariamente as áreas de saúde e educação e, mais recentemente, a assistência social. Iniciada em Fortaleza em 2020 e implantada em 2021, tem como objetivo incentivar pais e profissionais da APS a utilizarem a Caderneta de Saúde da Criança (CSC) como instrumento de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento infantil, e também com o propósito de consolidar práticas sustentáveis e integrar o cuidado centrado na criança à rotina dos serviços de saúde.

Alinhada aos eixos do *Framework Nurturing Care* (FNC) — saúde, nutrição, cuidado responsivo, segurança e proteção, e oportunidades para aprendizagem precoce — (JEONG et al., 2023), a iniciativa UAPI busca qualificar a atuação dos profissionais e promover cuidados mais oportunos e resolutivos para crianças de zero a seis anos. A iniciativa estimula a corresponsabilidade entre gestores, profissionais e famílias, fortalecendo a rede de apoio à primeira infância e constituindo uma estratégia de assistência técnica, capacitação e monitoramento contínuo voltada à institucionalização de práticas baseadas em evidências e à certificação de melhorias nos serviços (UNICEF, 2019).

Considerando que a implementação das UAPI envolve diferentes atores, contextos e etapas, é necessário compreender os processos que possibilitam sua adoção, execução e manutenção. Nesse sentido, a Ciência da Implementação (CI) oferece abordagens teóricas e metodológicas que permitem avaliar, de maneira integrada, os resultados alcançados e a viabilidade de sustentabilidade das ações ao longo do tempo, favorecendo o aprimoramento das práticas. Tal esforço conjunto contribui para qualificar a gestão e a organização do cuidado, além de ampliar o alcance de intervenções precoces capazes de promover o desenvolvimento pleno das crianças (KANNO et al., 2023; RAMANADHAN et al., 2023).

Entre os referenciais disponíveis nesse campo, destaca-se a *framework* RE-AIM (*Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance*) amplamente utilizada na avaliação de programas e intervenções em saúde. Essa abordagem contempla cinco dimensões inter-relacionadas: alcance (*Reach*), que analisa a extensão e o perfil da população participante; efetividade (*Effectiveness*), voltada aos resultados e impactos obtidos; adoção (*Adoption*), referente ao engajamento de organizações e profissionais; implementação (*Implementation*), que avalia a qualidade e a fidelidade das ações; e manutenção (*Maintenance*), que considera a sustentabilidade e a continuidade das iniciativas ao longo do tempo (BROWN; ROMAN, 2020; RACEY et al., 2025; GANCE-CLEVELAND, 2024).

Nesse sentido, esta tese dialoga com políticas públicas voltadas à primeira infância e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os relacionados à saúde, educação de qualidade, redução das desigualdades e trabalho decente. As evidências produzidas alinham-se ao fortalecimento de políticas públicas intersetoriais já implementadas, a exemplo da UAPI. E justifica-se para o tema proposto por estar alicerçada na necessidade de se compreender as percepções e as ações dos profissionais de saúde no que diz respeito às mudanças implementadas nos seus conhecimentos (a partir do ciclo de capacitação), além de ações práticas no processo de trabalho em equipe e na relação direta com cuidadores/famílias.

Para isso, a seguinte pergunta de pesquisa orientou o presente estudo: Como as percepções, conhecimentos e práticas de profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) envolvidos na Iniciativa UAPI em Recife-PE revelam os alcances, desafios e perspectivas da implementação da estratégia, a partir da análise pela *framework* RE-AIM? Essa pergunta buscou relacionar os efeitos da formação e ciclo de capacitação da UAPI com a prática cotidiana do cuidado, evidenciando aspectos que favorecem e que dificultam a consolidação da iniciativa UAPI.

A partir dessa questão norteadora, delineou-se como objetivo geral avaliar a implementação da Iniciativa UAPI, em Unidades de Saúde da Família do município do Recife, tomando como referência analítica o modelo RE-AIM, amplamente utilizado na ciência da implementação. Para alcançar esse propósito, buscou-se caracterizar as unidades participantes quanto a seus aspectos estruturais, organizacionais e contextuais, identificando fatores que influenciam o desenvolvimento das ações voltadas à primeira infância.

Além disso, procurou-se compreender as percepções, conhecimentos e práticas dos profissionais da ESF em relação ao ciclo de capacitação promovido pela iniciativa e sua repercussão na incorporação das ações ao cotidiano do serviço. Por fim, foram analisadas as dimensões centrais do modelo RE-AIM, com o propósito de compreender, de forma integrada, os processos e resultados da Iniciativa UAPI, identificando fatores que contribuem para o fortalecimento e a continuidade das práticas voltadas à promoção do desenvolvimento integral na primeira infância.

Esta tese insere-se na linha de pesquisa “Avaliação das condições de saúde nas políticas, programas e serviços”, na área de concentração “Saúde da Criança e do Adolescente”, e está estruturada da seguinte forma: no Capítulo 1, na Introdução, estão descritas a contextualização do tema, a questão norteadora e os objetivos do estudo, e as lacunas do conhecimento, as quais justificam a realização do estudo. O Capítulo 2 aborda os marcos legais e as políticas voltadas à primeira infância, o desenvolvimento infantil, a Estratégia Saúde da Família e as práticas dos profissionais, além de apresentar a metodologia que integra a UAPI, a Ciência da Implementação e a *framework* RE-AIM. O Capítulo 3 descreve o percurso metodológico, contemplando o tipo de estudo, o contexto da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e os métodos de análise. No Capítulo 4, são discutidos os aspectos éticos da pesquisa. O Capítulo 5 apresenta os resultados, incluindo a caracterização dos participantes, das Unidades de Saúde da Família e os achados qualitativos e quantitativos. O Capítulo 6 traz a discussão dos resultados, seguido do Capítulo 7, que apresenta as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo aborda os marcos históricos das políticas para crianças, principais aspectos sobre o desenvolvimento na primeira infância, a iniciativa UAPI, a Ciência da Implementação e a *framework* RE-AIM, e as práticas dos profissionais das Unidades de Saúde da Família (USF).

2.1 HISTÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS NO BRASIL

Historicamente, as políticas públicas voltadas à saúde da criança têm como pilares a promoção, a proteção e, mais recentemente, a recuperação da saúde, buscando assegurar melhor qualidade de vida. Entre as décadas de 1930 e 1940, tiveram início no Brasil os programas voltados à proteção da maternidade, da infância e da adolescência, estruturados sob a coordenação do Departamento Nacional da Criança (DNCr). Em 1940, foi idealizado o primeiro programa de saúde pública direcionado à alimentação infantil no Brasil, desenvolvido pelo Departamento Nacional da Criança do Ministério da Educação e Saúde, o Programa Nacional de Alimentação Infantil (NERO; GARCIA; ALMASSY, 2022).

Essa iniciativa marcou o início da institucionalização das ações de cuidado infantil no país e inspirou a criação de políticas voltadas à redução da mortalidade e à melhoria das condições de nutrição e desenvolvimento das crianças (GUBERT et al, 2021). No final da década de 1960, esse modelo institucional passou por reconfigurações importantes, destacando-se a destituição do DNCr, em 1969, e a criação, em 1970, da Coordenação de Proteção Materno-Infantil. Essa nova instância tinha como atribuições o planejamento, a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização das ações voltadas à saúde materno-infantil.

Na década de 1970, foi instituído o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materna e infantil; contudo, sua implementação ocorreu sob um modelo centralizador, pouco sensível às diversidades regionais e às necessidades locais. Esse formato evidenciava limites importantes na organização das ações, sobretudo diante das desigualdades sociais e territoriais que marcavam o cenário da saúde no país (ARAÚJO et al, 2014).

Nesse contexto, emergem iniciativas que passam a incorporar estratégias mais efetivas de cuidado, como a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em 1973. Objetivando a promoção do cuidado às crianças, esse programa constituiu uma mudança de paradigma, pois

a partir da oferta de vacinas para essa faixa etária, para prevenir doenças como o sarampo, poliomielite, difteria, proporcionou com o passar dos anos, a diminuição da mortalidade infantil, que à época estava em torno de 60,8 óbitos a cada 1000 nascimentos, e no Nordeste essa situação era ainda mais difícil, em torno de 87,3 a cada mil nascidos vivos (DOMINGUES et al, 2020).

A partir de 1980, com os movimentos políticos para a redemocratização do Brasil, em que novas políticas foram implantadas, de maneira progressiva, destacaram-se: o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno; o Alojamento Conjunto; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); o Método Canguru; e também a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) (SOUZA, 2020). Tais iniciativas representaram marcos sobre a infância, ampliando a atenção para a importância da proteção e do cuidado integral nos primeiros anos de vida.

O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), instituído em 1981, teve como objetivos promover, apoiar e proteger a amamentação, reconhecendo o aleitamento materno como prática essencial para a redução da mortalidade infantil e para a melhoria das condições de saúde. A partir de articulações intersetoriais, o programa reforçou as ações de promoção da saúde, segurança alimentar e fortalecimento do vínculo mãe-bebê, consolidando-se como uma iniciativa estratégica para a proteção integral da infância e a qualificação das práticas de cuidado (BOCCOLINI et al., 2016; FERREIRA et al., 2018).

Na sequência das ações voltadas à promoção da saúde infantil, o Ministério da Saúde instituiu, em 1984, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC). Veio no bojo das ações anteriores para a vacinação e aleitamento materno, com um olhar mais ampliado. Destacam-se ações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, prevenção e manejo das doenças prevalentes na primeira infância, - diarreia e infecções respiratórias, e prevenção de deficiências nutricionais (ARAÚJO et al, 2014; ASSUNÇÃO et al, 2025)

Para fortalecer as ações voltadas à infância, foi criado, em 1990, o ECA, que reconheceu crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e cidadãos com necessidades específicas em seu processo de desenvolvimento (BRASIL, 1990). A partir desse marco, a infância deixou de ser compreendida apenas como uma fase de vulnerabilidade, passando a ser tratada como prioridade nas políticas públicas (KRAMER; NUNES; PENA, 2020). Correlacionando ao campo da saúde, o Estatuto fortaleceu a articulação de ações voltadas à promoção, prevenção e

assistência, contribuindo na estruturação de estratégias para garantias a essas faixas etárias (GONÇALVES et al., 2020).

Nesse decurso, foi instituído no ano de 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) (MACINKO & MENDONÇA, 2018), originando a atual Estratégia de Saúde da Família, em 2006, que tem papel estratégico como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, e por meio do vínculo estabelecido com a comunidade e com as famílias, ampliou as práticas de promoção, prevenção e acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento na primeira infância (HILÁRIO et al, 2022). No território, as ações são consolidadas e possibilitam maior resolutividade às necessidades específicas dessa faixa etária, contemplando a diversidade social, cultural e epidemiológica que caracteriza a infância em diferentes contextos.

Relacionada às ações de cuidado para as crianças, dentro do cenário hospitalar, emergiu a IHAC, no ano de 1995, em consonância com recomendações internacionais, constitui uma estratégia voltada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no ambiente hospitalar. Fundamentada nos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”. Objetivando qualificar as práticas assistenciais desde o pré-natal até o pós-parto imediato, incentivando o contato precoce entre mãe e recém-nascido e a amamentação na primeira hora de vida (MAROJA; SILVA; CARVALHO, 2014).

No ano de 1996, a estratégia denominada Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), proposta pela OMS e UNICEF com o objetivo de reduzir a morbimortalidade infantil por meio de uma abordagem integrada do cuidado à criança. Articulando ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças que acometem a infância, como infecções respiratórias, diarreias e desnutrição, considerando também aspectos relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil, e baseando-se na qualificação dos profissionais de saúde, na organização dos serviços e no fortalecimento das práticas de cuidado no âmbito da atenção primária (SANTOS; GAIVA; SALGE, 2018).

Destacam-se também, os movimentos da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), constituída em 2007 por uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, governo, setor privado, outras redes pela promoção, defesa, garantia e efetivação dos direitos, e o lançamento do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), em 2010, e amplamente discutido por políticos, pesquisadores, técnicos especialistas da infância e pessoas da sociedade civil, pertencentes à Rede Nacional. Esse documento expressa a intenção em cumprir acordos

internacionais firmados pelo Brasil, colocando em evidência as necessidades das crianças (BRASIL, 2010).

Com os desdobramentos dos avanços normativos e institucionais, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), com o propósito de organizar e orientar ações voltadas à promoção, proteção e atenção integral à saúde de crianças de zero a nove anos. Ela consolidou-se como um marco na articulação das iniciativas existentes e na implementação de novas estratégias, tendo a APS como coordenadora do cuidado em conjunto com as Redes de Atenção à Saúde (RAS), e através da ESF, que pela sua capilaridade, amplia o acesso aos cuidados desde o pré-natal, utilizando instrumentos como a Caderneta da Criança (BRASIL, 2015; DAMASCENO et al., 2016; AMORIM et al., 2018; SOUZA et al., 2019).

Essa política traz em seu Eixo Estratégico III, a Promoção e Acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento Integral, que é um eixo histórico nas ações e programas voltados para as crianças, desde os anos 80. E que atualmente apresenta a importância para os cuidados para um pleno Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI), utilizado em vários países, amplia o escopo de ações e traz através da produção de conhecimento científico, o quanto mais precoces forem agregados estímulos, ambientes facilitadores à vida, estreitamento de vínculos, fortalecimento das redes de cuidado e proteção social para as crianças a realidade dessa plenitude chega ao seu máximo (BRASIL, 2018).

Nessa mesma direção, e considerando as estratégias voltadas à superação da extrema pobreza e à promoção da equidade entre as famílias com crianças na primeira infância, no ano de 2012, foi implementado o Programa Brasil Carinhoso, articulando ações voltadas para a ampliação do acesso às creches, e à saúde e nutrição, por meio da suplementação de vitamina A, ferro e acompanhamento das crianças, e reforçou o compromisso governamental com a proteção social na primeira infância, associando o suporte financeiro, com o reajuste do benefício do Programa Bolsa Família, consolidando uma agenda intersetorial (BRASIL, 2012; DA COSTA et al, 2021).

Diante da necessidade de políticas intersetoriais e de caráter permanente, ocorreu o fortalecimento do debate político e institucional sobre a primeira infância, e a criação de instrumentos normativos específicos, como o Marco Legal da Primeira Infância que foi instituído pela Lei nº 13.257 de 2016. Ele regulamenta dispositivos do Estatuto da Criança e do

Adolescente e estabelece princípios e diretrizes para políticas públicas integradas, envolvendo áreas como saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, de modo a garantir ações articuladas em prol do desenvolvimento integral da criança. Como destaca o texto da lei em seu artigo 8º:

O pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância constitui objetivo comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e legais, a ser alcançado em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Parágrafo único. A União buscará a adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à abordagem multi e intersetorial no atendimento dos direitos da criança na primeira infância e oferecerá assistência técnica na elaboração de planos estaduais, distrital e municipais para a primeira infância que articulem os diferentes setores (BRASIL, 2016).

A partir desse movimento de ampliação e consolidação das políticas voltadas à primeira infância, e para o fortalecimento da intersetorialidade integrando ações de saúde, educação e cultura e direitos humanos, foi criado o Programa Criança Feliz, em 2016, direcionado para gestantes e crianças na primeira infância, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento infantil, por meio de visitas domiciliares, utilizando o modelo *Care for Child Development* (CCD). Desenvolvido pela UNICEF e Organização Mundial da Saúde e Organização Panamericana de Saúde (OMS/OPAS), com foco no fortalecimento das habilidades dos pais/cuidadores primários (BRASIL, 2016; GIRADE, 2018; SANTOS et al., 2023).

E, mais atualmente, a fim de assegurar o desenvolvimento integral, a proteção e o pleno exercício dos direitos das crianças de zero a seis anos através do Decreto nº 12.574/2025, foi instituída a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI), que traz em seus eixos estruturantes:

I - viver com direitos - garantia da proteção e da defesa dos direitos das crianças contra o abuso, o racismo e as diversas formas de discriminação e violência, sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

II - viver com educação - garantia de acesso e permanência na educação infantil de qualidade com aprendizagem e desenvolvimento integral, sob a coordenação do Ministério da Educação;

III - viver com saúde - garantia ao cuidado integral à saúde, sob a coordenação do Ministério da Saúde;

IV - viver com dignidade - garantia ao cuidado, à proteção e à assistência social, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e

V - integração de informações e comunicação com as famílias - criação de condições para a oferta de serviços públicos integrados e de comunicação do Poder Público com famílias e responsáveis legais, sob a coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (BRASIL, 2025).

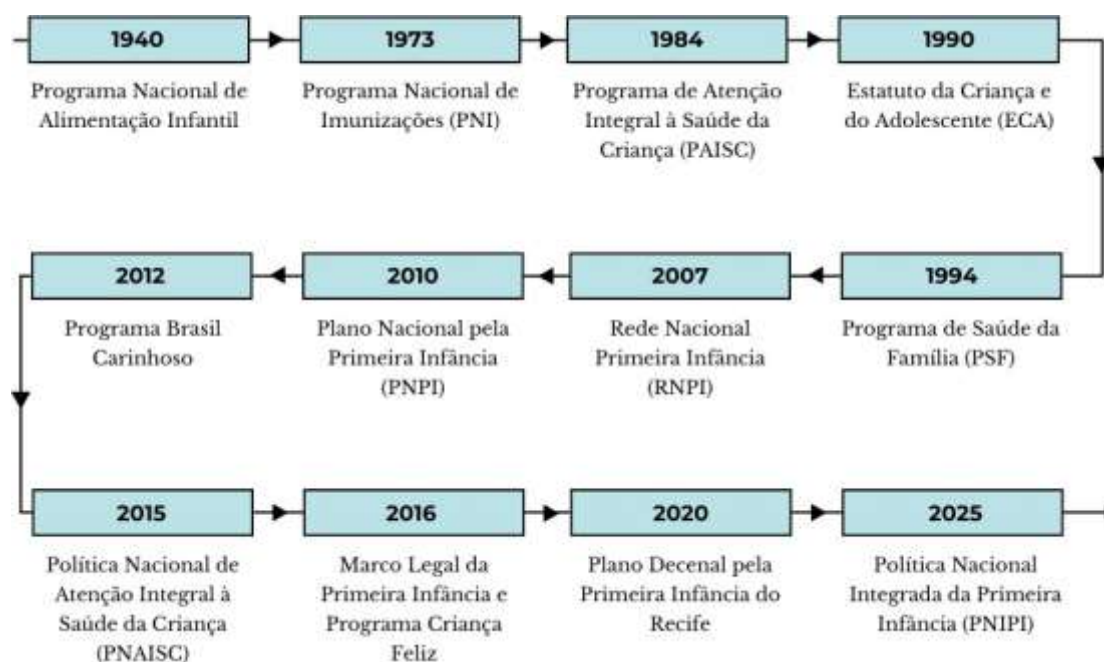
O mesmo decreto instituiu também a Estratégia de Monitoramento e Avaliação da PNIP, com o propósito de acompanhar o desempenho e os resultados da política em cada um de seus eixos estruturantes, assegurando que as ações planejadas sejam efetivamente executadas. Os avanços serão medidos por indicadores específicos de avaliação do desenvolvimento integral das crianças, permitindo identificar lacunas, promover ajustes e fortalecer a gestão baseada em evidências. Essa estratégia configura-se como um importante instrumento para qualificar o cuidado na primeira infância, aprimorar a transparência das ações governamentais e garantir que cada criança tenha acesso às condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento (BRASIL, 2025).

No entanto, a efetividade dessas políticas e estratégias depende do reconhecimento de que o desenvolvimento infantil ocorre em contextos concretos, especialmente no ambiente familiar, onde pais, familiares e outros cuidadores, de forma individual ou compartilhada, exercem funções essenciais de cuidado. Nessa perspectiva, torna-se indispensável a presença de políticas públicas que reconheçam e apoiem essas dinâmicas, uma vez que o Estado deve assumir responsabilidades de proteção e provisão material, garantindo condições de vida adequadas a todos os membros da família e favorecendo, em especial às crianças, a vivência de uma infância plena (EGRY; APOSTOLICO; MORAIS, 2018; SILVA; ALVES, 2019).

A seguir, apresenta-se uma linha do tempo que sintetiza os principais marcos normativos e programáticos voltados à primeira infância no Brasil, representando a progressiva institucionalização do tema nas agendas públicas. A figura destaca a trajetória das políticas desde a criação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, em 1981, até PNIP, de 2025, ilustrando a consolidação de um arcabouço legal e intersetorial voltado à promoção do desenvolvimento integral da criança. Essa representação visual permite compreender, de forma cronológica, a articulação entre programas, planos e legislações, bem

como o fortalecimento da intersetorialidade e da integralidade do cuidado como princípios orientadores das ações públicas.

Figura 1: Marcos normativos e programáticos voltados à primeira infância no Brasil.



Fonte: elaborado pela autora (2025)

A análise da história das políticas públicas para crianças no Brasil apresenta avanços na construção de uma agenda voltada ao reconhecimento da criança como sujeito de direitos e à promoção do desenvolvimento integral. A partir dessa trajetória, é importante compreender o desenvolvimento infantil na primeira infância, considerando suas dimensões biopsicossociais e a influência dos contextos familiares, sociais e institucionais na formação das bases que sustentam uma infância plena e saudável.

2.1.1 RECORTE TEMPORAL NO MUNICÍPIO DO RECIFE

Nessa mesma perspectiva de integração e fortalecimento das políticas voltadas à infância, em 2020, a Prefeitura do Recife instituiu o Plano Decenal pela Primeira Infância do

Recife, alinhado às políticas nacionais e internacionais e voltado à promoção do desenvolvimento infantil, reafirmando a intersetorialidade como princípio norteador ((BRITO, 2020; BRASIL, 2020).O plano define metas e estratégias para reduzir desigualdades territoriais, ampliar o acesso aos serviços essenciais e fortalecer as redes de proteção e cuidado que envolvem saúde, educação e assistência social, consolidando o compromisso do município com a garantia dos direitos e o desenvolvimento integral das crianças, definindo que:

Este plano encontra âncora na abordagem sócio histórica e cultural da Primeira Infância, período que abrange os primeiros seis anos completos ou 72 meses de vida da criança, conforme estabelece a Lei Municipal 18.491/2018, compreendendo-a como um ciclo de vida fundamental na trajetória do desenvolvimento humano, considerando os cuidados singulares exigidos pelas próprias condições de sua existência e os contextos sociais onde são estabelecidas suas redes de relações sociais, fatores determinantes para que meninas e meninos tenham oportunidades iguais para o alcance de seu potencial máximo (BRASIL, 2020).

Em consequente, tem-se mais um marco no ano de 2021, quando foi instituída a Frente Parlamentar da Primeira Infância da Câmara Municipal do Recife, a partir de audiência pública. Seu projeto estabelece quatro objetivos principais: propor, discutir e fiscalizar políticas públicas para a infância no município; colaborar com entidades representativas no encaminhamento de propostas e estudos; monitorar a execução de planos e projetos municipais; e promover a interlocução entre o Legislativo, conselhos, fóruns e organizações da sociedade civil que atuam em defesa da primeira infância (RECIFE, 2021).

2.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (DPI)

As modificações biológicas que propiciam importantes aprendizados nos domínios motor, afetivo-social e cognitivo acontecem na infância. É nos primeiros seis anos de vida que o cérebro está em constante transformação, principalmente no que tange a organização e quantidade de sinapses, que têm seu apogeu atingido nos primeiros 24 meses de vida, influenciando diretamente na aprendizagem (BLACK et al, 2017; VICTORA et al, 2020; CAPIO et al, 2024). Sendo na primeira infância onde se deve possibilitar à criança espaço para liberdade de movimentos, brincadeira, disponibilidade de brinquedos, vínculos afetivos

saudáveis, entre tantos outros fatores (NIJHOF et al, 2018; YOGMAN et al, 2018; SCHIPPERIJN et al, 2024).

Os primeiros 1000 dias são considerados os mais importantes, pois as crianças respondem mais rapidamente às intervenções do que em qualquer outra fase. Por isso, esse período é visto como uma janela de oportunidades para potencializar o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional, prevenir agravos futuros e reduzir desigualdades que podem se perpetuar ao longo da vida (BLACK et al., 2017). Estudos trazem dados sobre alguns riscos associados à limitação do desenvolvimento nessa fase, como o estresse tóxico, a violência, a insegurança alimentar e a pobreza (MILLÁN et al., 2022; MISHRA; SHRIVASTAVA; KOLANDAISAMY, 2023; PARADA e PARADA, 2024; CRISTOVAM et al., 2024).

Nesse contexto, é importante destacar que o DPI abrange diversas dimensões interligadas — físico e motor, cognitivo, linguístico, social e emocional —, e que seu pleno avanço depende de um ambiente estável, seguro e estimulante. No entanto, esse desenvolvimento não ocorre de forma isolada: a presença simultânea de fatores de risco ambientais, biológicos e sociais, como deficiências nutricionais, estimulação inadequada, maus-tratos, depressão materna, baixa escolaridade dos cuidadores, violência no entorno e doenças infecciosas, pode comprometer seriamente esse processo (HONE; MACINKO; MILLETT, 2018).

Esses fatores de risco, por sua vez, estão fortemente relacionados às múltiplas dimensões da pobreza, que ultrapassam as vulnerabilidades específicas da infância. A ausência de renda, a baixa escolaridade da mãe ou cuidador, a precariedade das moradias, a insegurança alimentar e o limitado acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, constituem um ambiente adverso ao pleno desenvolvimento infantil. Esses contextos comprometem a oferta de estímulos adequados e aumentam a exposição a situações de estresse tóxico e negligência, dificultando o desenvolvimento integral e perpetuando ciclos de desigualdade (SCHWARZENBERG et al., 2018; SCHMIDT et al., 2018; INDRIIO et al., 2022).

Sob a perspectiva das desigualdades sociais persistentes, observa-se que a fragilidade na compreensão coletiva sobre a relevância da primeira infância tende a reforçar as barreiras históricas que limitam o desenvolvimento integral das crianças. De acordo com o Panorama da Primeira Infância do Instituto Maria Cecília Souto Vidigal (2025), apenas 2% da população souberam definir corretamente o termo “primeira infância”, enquanto 42% declararam não

conhecê-lo. Essa falta de entendimento social compromete o reconhecimento público da importância desse período e fragiliza o engajamento cidadão na defesa e acompanhamento das políticas voltadas à primeira infância.

Nesse sentido, a superação dessas fragilidades demanda uma atuação intersetorial, na qual educação e saúde ocupam papel central nas políticas para a primeira infância. A educação deve estar cada vez mais presente nas intervenções voltadas à primeira infância, em articulação com a saúde, pois ambos os eixos dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — Saúde e Bem-Estar e Educação de Qualidade. Essas metas buscam promover o desenvolvimento integral das crianças e reduzir, até 2030, a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos (EBRAHIMI et al., 2023; CHEN et al., 2024; LOPES et al., 2025).

Para que as mudanças sejam realizadas, e mantidas, a família precisa estar engajada, admitindo-se que o início dos processos de socialização ocorre nesses ambientes, identificados como espaços de proteção e educação. No entanto, a realidade nem sempre se conforma nesse modelo, uma vez que os arranjos familiares são os mais diversos, e podem coexistir com situações de vulnerabilidade, fragilização de vínculos e pobreza. Nessas condições, por meio da oferta de apoio social, serviços de saúde, educação e proteção que se pode reduzir desigualdades e assegurar que todas as crianças tenham acesso a um desenvolvimento pleno e digno (JUNIOR et al., 2018; MACHADO; ANDRES, 2021)

Nesse contexto, a parentalidade positiva representa uma estratégia para o fortalecimento dos vínculos familiares e a promoção de relações de cuidado saudáveis. Baseia-se no afeto, no diálogo e no reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos, entendendo que quanto maior o envolvimento familiar, o acolhimento e a comunicação, melhores serão as competências socioemocionais desenvolvidas. Ao estimular interações expressões emocionais positivas e atitudes protetoras, sem recorrer a práticas punitivas ou violentas, cria-se um ambiente mais seguro e propício ao desenvolvimento integral (CAVALCANTE et al., 2020; MOURA et al., 2021; MUNIZ et al., 2025)

Para que isso seja viável, a intersetorialidade é fundamental, especialmente entre saúde e educação. Quando esses setores atuam de forma integrada, favorecem o crescimento e o desenvolvimento saudável das crianças, desde o pré-natal nas Unidades de Saúde até o início

do percurso escolar Essa articulação possibilita a construção de redes de cuidado contínuas, que acompanham a criança e sua família ao longo das etapas da vida e fortalecem o papel da comunidade na corresponsabilidade pelo desenvolvimento infantil, ampliando o alcance e a efetividade das políticas públicas (MENDONÇA; LANZA, 2020; SILVA et al., 2024).

2.3 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

No ano de 1994, foi implementado o Programa de Saúde da Família (PSF), voltado à reorganização da Atenção Básica, com foco na família e no território. A partir de 2006, com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a qual passou a ser denominada Estratégia de Saúde da Família. Embora não se restrinja ao cuidado à saúde das crianças, essa estratégia nacional de saúde tem papel comprovado na redução da mortalidade materna e infantil (DA SILVA et al., 2019). Alicerçada nos princípios organizativos e doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), a ESF estrutura-se de modo a garantir o direito de todos ao acesso universal aos serviços de saúde (PINTO; GIOVANELLA, 2018).

No cenário da ESF, o atendimento aos usuários envolve um processo de trabalho complexo e dinâmico, uma vez que o território em que atua é vivo e em constante transformação. Para sua efetivação, são utilizadas principalmente tecnologias leves, expressas no acolhimento, na escuta e no diálogo (NUCIARONI et al., 2020). Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde, marcada por suas complexidades, pelo uso dessas tecnologias e pelas altas demandas, conta com diretrizes que orientam gestores no desenvolvimento e no monitoramento dos indicadores de saúde, os quais subsidiam as tomadas de decisão nas diferentes instâncias de gestão (SOUSA; SHIMIZU, 2021).

No que tange à primeira infância, as ações na ESF são relacionadas às políticas e programas que vêm sendo instituídos ao longo dos anos, com vistas à garantia de direitos e à integralidade do cuidado. O acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança inicia-se nas consultas de pré-natal e acontece na Atenção Primária à Saúde (APS), mediante consultas de rotina, conforme o calendário de puericultura previsto na Caderneta de Saúde da Criança. Esse acompanhamento pressupõe ações de promoção da saúde, de proteção, de detecção precoce de agravos, bem como atendimento oportuno e reabilitação de alterações que possam repercutir em sua vida futura (SOUZA et al., 2021).

Durante as consultas de puericultura, espera-se a garantia dos atributos da APS, tais como, a longitudinalidade, a integralidade do cuidado, bem como a orientação familiar e comunitária e a competência cultural. Nesse contexto, a família também se insere como sujeito do cuidado, exigindo a abordagem das múltiplas dimensões que envolvem o processo saúde-doença, incluindo os aspectos ecobiopsicossociais da criança, do cuidador e de seu núcleo familiar. A efetividade dessas ações está diretamente relacionada à escuta qualificada e ao acolhimento, elementos fundamentais para a consolidação do cuidado integral (STALIN; ANDRÉ; GOZI, 2019).

Nesse acompanhamento, essa consulta, realizada pelo profissional enfermeiro, representa o momento no qual é oportunizada a promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde da criança na primeira infância (SIEGA et al, 2020). Os dois primeiros anos são considerados os mais importantes e críticos, devido ao desenvolvimento da atividade cerebral, que intensifica processos como a linguagem, habilidades cognitivas, competências socioemocionais e respostas adaptativas. Essa fase requer estímulos adequados e cuidados contínuos, capazes de potencializar o crescimento e o desenvolvimento em seus múltiplos aspectos. (BRITTO et al, 2017; VIEIRA et al, 2021)

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, os dados das crianças atendidas nas consultas de puericultura deverão ser registrados na Caderneta de Saúde da Criança (CSC), a qual é considerada o Passaporte da Cidadania, e engloba as informações que perpassam a saúde, educação e assistência social desde o nascimento, ou seja, há o compartilhamento de dados com a famílias e setores, promovendo ampliações das ações sociais para os usuários. Na caderneta são registrados os marcos do desenvolvimento infantil, possibilitando o acompanhamento das aquisições motoras, cognitivas e socioemocionais e favorecendo intervenções oportunas (BRASIL, 2021).

A utilização desse instrumento deve articular-se a outras estratégias de acompanhamento, como as visitas domiciliares, que ampliam a compreensão do contexto familiar e fortalecem o vínculo entre equipe e comunidade. As visitas permitem o acesso dos usuários em seu território, promovendo ações coordenadas e pautadas no princípio da integralidade do cuidado, sendo um dispositivo estratégico para que os profissionais conheçam a realidade dos comunitários adscritos e realizem rastreios, intervenções e ações de promoção da saúde, cuidados neonatais, vacinação e incentivo ao aleitamento materno (FERNANDES; SOUZA; RODRIGUES, 2019).

No âmbito da visita domiciliar, o acompanhamento da criança e de sua família torna-se mais próximo e contextualizado, possibilitando a identificação precoce de fatores de risco e o fortalecimento de práticas de cuidado no ambiente familiar. O monitoramento do desenvolvimento infantil e a articulação com outros serviços da rede reforçam o papel da Atenção Primária à Saúde como espaço estratégico de apoio à parentalidade e promoção do desenvolvimento integral nos primeiros anos de vida. Nesse processo de acompanhamento contínuo, destaca-se a imunização como componente essencial da proteção e da promoção da saúde infantil (COUTINHO et al., 2020; CAVALHEIRO; SILVA; VERÍSSIMO, 2021).

A sensibilização de mães e cuidadores sobre a importância das vacinas constitui uma prática importante das equipes de saúde, considerando a maior vulnerabilidade das crianças às infecções. A imunização representa um importante mecanismo coletivo de prevenção e controle de doenças, contribuindo para a redução da morbimortalidade infantil (ALMEIDA et al., 2025). Na ESF, o acompanhamento vacinal integra-se às consultas de puericultura e visitas domiciliares, favorecendo a orientação, a identificação de esquemas incompletos e o estímulo à adesão, consolidando as ações de promoção e vigilância em saúde como pilares do cuidado integral nos primeiros anos de vida (NEVES et al., 2023; RUELA et al., 2025).

Na continuidade desse cuidado, destaca-se nas rotinas das Unidades de Saúde da Família a promoção do aleitamento materno, reconhecida como prática essencial à saúde infantil e ao fortalecimento do vínculo mãe-filho. Essa ação compreende orientações individuais e coletivas, bem como grupos educativos com gestantes e puérperas, nos quais são abordados os benefícios, as técnicas adequadas e os principais desafios da amamentação. Além dos benefícios nutricionais e imunológicos, o aleitamento materno favorece o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, configurando-se como indicador da qualidade da atenção oferecida (CHRISTOFFEL et al., 2021).

Apesar de seu reconhecido impacto sobre a saúde e o desenvolvimento infantil, a manutenção do aleitamento materno ainda enfrenta desafios no cotidiano dos serviços de atenção primária. Entre os principais obstáculos, destacam-se fatores socioculturais que favorecem o uso precoce de fórmulas e outros alimentos, o retorno antecipado das mães ao trabalho sem suporte adequado e as dificuldades técnicas nem sempre manejadas pelas equipes de saúde. Esses aspectos, aliados à fragilidade das redes de apoio e à descontinuidade das ações educativas, evidenciam a necessidade de estratégias intersetoriais e de processos formativos

contínuos que qualifiquem o cuidado e garantam suporte efetivo às famílias (FARIA; SILVA; PASSBERG, 2023; ZIWERT et al., 2024).

Nesse cenário, as práticas dos profissionais da ESF, orientadas pela PNAB, assumem papel importante na consolidação dessas ações. Contudo, esses trabalhadores frequentemente relatam acúmulo de responsabilidades e necessidade constante de atualização diante das transformações nas condutas clínicas, nos protocolos assistenciais e nas interações com os usuários. Tais dinâmicas expõem as equipes a vulnerabilidades, mas também configuram oportunidades de aprimoramento técnico e fortalecimento das competências profissionais. Nesse contexto, a sobrecarga de trabalho se destaca como um fator que influencia diretamente a qualidade do cuidado e o bem-estar dos trabalhadores (FERNANDES; SANTOS, 2020).

Ademais, essa sobrecarga de demandas nas Unidades de Saúde da Família frequentemente limita o tempo destinado às orientações individualizadas e ao acompanhamento longitudinal das famílias, comprometendo a continuidade e a qualidade do cuidado prestado. Essa limitação reflete a complexidade das atribuições das equipes e a necessidade de reorganização dos processos de trabalho para garantir uma atenção integral e resolutiva. Nesse sentido, evidencia-se a importância de políticas públicas mais eficazes e de processos permanentes de capacitação profissional, capazes de fortalecer as práticas e promover melhores condições para o desempenho das atividades assistenciais (ZANLORENZI et al., 2022; AMARAL; SPADOTTO; GOMES, 2024).

Essa conjuntura de sobrecarga e múltiplas responsabilidades repercute na forma como os profissionais se relacionam com os usuários e compreendem o cuidado. Para que a Atenção Primária à Saúde alcance sua finalidade de atenção integral, é necessário que os trabalhadores desenvolvam uma sensibilidade voltada à compreensão do indivíduo em sua totalidade, considerando também fatores culturais, sociais e ambientais que influenciam o processo saúde-doença. Assim, o princípio da integralidade deve ser incorporado aos processos de formação e educação permanente, estimulando a reflexão sobre a prática e o fortalecimento de um cuidado humanizado (DA ROSA TOLAZZI; GRENDENE; VINHOLES, 2022).

Os profissionais de saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, assumem a responsabilidade pelo cuidado integral, priorizando ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. No cotidiano dos serviços, essas responsabilidades se expressam nas práticas de acolhimento, acompanhamento familiar, vigilância em saúde, manejo clínico e

desenvolvimento de atividades educativas voltadas à comunidade. Esse nível de atenção abrange desde agravos mais comuns até situações de maior complexidade, articulando-se com outros pontos da rede de atenção quando a resolução das demandas requer intervenções especializadas (MENDES et al., 2023).

Diante dessa amplitude de responsabilidades, os trabalhadores enfrentam desafios significativos na organização e execução do processo de trabalho. Entre eles, destacam-se as demandas relacionadas à educação permanente, à capacitação profissional e à gestão, que envolvem planejamento, tomada de decisão e comunicação efetiva entre usuários e equipes de saúde, promovendo os princípios do Sistema Único de Saúde. Assim, o cotidiano da Atenção Primária à Saúde configura-se como um espaço dinâmico, sustentado por ações coordenadas entre profissionais, indivíduos, famílias e comunidade, voltadas à consolidação da integralidade do cuidado (VIEIRA-MEYER, 2020).

Frente às limitações observadas na rotina dos serviços e à necessidade de aprimorar o cuidado à primeira infância, emergem oportunidades para o desenvolvimento de metodologias que integrem ações e qualifiquem as práticas na Atenção Primária à Saúde. A incorporação de abordagens intersetoriais e baseadas em evidências representa um avanço na consolidação do cuidado integral, criando condições para a adoção de estratégias voltadas à promoção do desenvolvimento infantil, entre as quais se insere a Iniciativa UAPI.

2.4 METODOLOGIA UAPI

Com o propósito de promover ações integradas e articuladas para o desenvolvimento da primeira infância, contemplando o fortalecimento das redes de apoio, a Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI) configura-se como uma estratégia de reorientação das práticas profissionais intersetoriais nos setores de saúde e educação. Entre as ações preconizadas, destaca-se a valorização da consulta de puericultura como espaço privilegiado para aplicação de seus princípios, orientando os profissionais para uma atuação centrada no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, com ênfase na qualidade do cuidado, na escuta qualificada e na participação ativa das famílias (UNICEF, 2019).

A partir de agosto de 2021, o Recife iniciou a sua participação na iniciativa, fruto da parceria com a UNICEF, tendo como propósito o avanço do cuidado integrado com a saúde,

educação, assistência social, fortalecimento do conhecimento dos profissionais acerca do desenvolvimento na primeira infância e a participação das famílias. Para a implementação na cidade do Recife, os profissionais que atuam nas unidades participantes são convidados a atuar na iniciativa UAPI, e caso aceitem, que a adesão seja formalizada por eles, como assinantes da adesão ou integrantes dos grupos de trabalho que venham a ser formados no processo de implementação da iniciativa (SILVA, 2022).

A proposta de implementação da estrutura metodológica da Iniciativa UAPI, incorporada pelo UNICEF, tem como finalidade qualificar as ações desenvolvidas por profissionais das áreas de saúde e educação, promovendo cuidados mais oportunos e resolutivos para crianças de zero a seis anos. Fundamenta-se nos eixos do FNC, que orienta práticas voltadas à saúde, nutrição, segurança, aprendizado precoce e cuidados responsivos. Nessa perspectiva, a iniciativa se configura como uma estratégia de suporte técnico e pedagógico, voltada à capacitação, ao monitoramento e à certificação de unidades que demonstram avanços na integração de serviços e no fortalecimento do diálogo entre profissionais e famílias sobre o desenvolvimento infantil (UNICEF, 2019).

Além da formação das equipes, a metodologia da UAPI compreende etapas de autoavaliação, certificação e monitoramento contínuo, que permitem identificar o grau de adesão das unidades aos critérios da iniciativa. A certificação é concedida às unidades que incorporam de forma efetiva os princípios da atenção integral e intersetorial à primeira infância, traduzindo-os em práticas cotidianas de cuidado e apoio às famílias. Essa estrutura metodológica, ao integrar educação permanente, gestão do cuidado e engajamento comunitário, favorece a institucionalização de práticas sustentáveis e a consolidação da primeira infância como prioridade na agenda local de saúde (UNICEF, 2025).

Em sua estrutura metodológica, prevê-se um período inicial de três meses destinado à adesão e preparação das equipes, seguido por 12 meses de implementação das ações. A avaliação do processo ocorre de forma contínua, com análises quadrimestrais dos indicadores quantitativos e qualitativos, permitindo o acompanhamento dos resultados e o aperfeiçoamento progressivo das práticas adotadas. Na figura abaixo está representado o ciclo avaliativo da iniciativa:

Figura 2: Ciclo Avaliativo da UAPI



Fonte: <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/iniciativa-unidade-amiga-da-primeira-infancia>

Os indicadores utilizados para o monitoramento contemplam dimensões essenciais do cuidado materno-infantil na APS. Entre eles estão: gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal, iniciadas até a 12ª semana de gestação; crianças em aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade; crianças de um ano com esquema vacinal completo para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, *Haemophilus influenzae* tipo b, e poliomielite inativada; crianças até um ano e onze meses com uma ou mais consultas odontológicas programáticas; e crianças de dois anos com nove ou mais consultas de puericultura realizadas (SANTOS et al, 2021).

É calculada a média de cada indicador para todas as Unidades do município. A partir da média, os indicadores de cada Unidade são pontuados conforme abaixo: 1) Resultado insuficiente (pontuação igual a 0): quando o indicador está entre 1 e 2 desvios padrão abaixo da média. 2) Resultado regular (pontuação igual a 1): quando o indicador está até 1 desvio padrão abaixo da média. 3) Resultado bom (pontuação igual a 2): quando o indicador está até 1 desvio padrão acima da média. 4) Resultado excelente (pontuação igual a 3): quando o indicador está entre 1 e 2 desvios padrão acima da média (UNICEF, 2025).

No primeiro ciclo (2021-2023), 13 unidades participaram da etapa piloto, sendo 9 certificadas. Já no segundo ciclo, em 2024, Recife avançou ainda mais, com a participação de 10 unidades de educação, 14 de saúde e uma de assistência social, alcançando 20 certificações.

2.5 CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO (CI) e A *FRAMEWORK RE-AIM*

A Ciência da Implementação pode ser definida como a área de pesquisa focada em compreender e promover métodos que promovam a adoção, o uso consistente e a sustentabilidade de práticas, programas e políticas baseadas em evidências em contextos reais. Seu foco central está em “como” as intervenções são integradas aos serviços e sistemas e no “porquê” algumas estratégias são mais efetivas do que outras em diferentes cenários (PROCTOR et al., 2011). Ela investiga os processos, os determinantes contextuais e as estratégias necessárias para que as evidências científicas ultrapassem a lacuna entre a produção acadêmica e a prática cotidiana em saúde, educação e políticas sociais (WANG et al, 2023).

Esse campo envolve a colaboração entre pesquisadores e profissionais de diversas áreas, além da participação dos usuários dos sistemas de saúde, com o objetivo de garantir a aplicação de intervenções que sejam tanto tecnicamente eficazes quanto culturalmente relevantes. A reflexão é importante para desenvolver um saber prático que atenda às necessidades das pessoas, pois, sob essa ótica, a racionalidade científica produz conhecimento que possui valor social e pode ser utilizado no cotidiano (SOUZA et al, 2024). É uma área de estudo que utiliza modelos, métodos e estruturas para facilitar a integração sistemática dos resultados de pesquisas e outras evidências na prática cotidiana dos cuidados de saúde, visando a melhoria na qualidade e na eficácia dos serviços (KHADJESAR et al, 2020).

A incorporação da CI neste estudo fundamenta-se na necessidade de compreender não apenas se uma intervenção funciona, mas também como, em que condições e para quem ela gera resultados. Essa ciência dedica-se ao estudo de métodos e estratégias que favorecem a integração de intervenções baseadas em evidências –à prática e às políticas em sistemas de saúde (BUENO, 2021; WILLIAMS; VICKREY, 2021; ESHRIQUI et al., 2023; REDDY, 2024). Ao reduzir a lacuna entre o conhecimento e sua aplicação, a CI analisa a incorporação de intervenções e políticas, identifica facilitadores e barreiras e promove a adoção e sustentabilidade dessas práticas no contexto real dos serviços (KANNO et al., 2022).

Nessa perspectiva, a CI busca compreender os processos que transformam evidências em ações efetivas, reconhecendo que a adoção de uma prática depende não apenas da qualidade da intervenção, mas também do contexto em que é aplicada e das estratégias que garantam sua viabilidade. Inclui a análise de fatores organizacionais, comportamentais e contextuais que influenciam a mudança nas práticas profissionais, valorizando o engajamento dos atores locais e a adaptação das intervenções às realidades específicas. Também fornece bases teóricas e metodológicas que fortalecem a capacidade dos serviços de saúde de implementar políticas mais eficazes e sustentáveis (HOAGWOOD et al., 2020; OELKE, 2024).

Entre seus principais componentes destacam-se: a intervenção, compreendida como o programa, prática ou política a ser implementada; o contexto, que reúne fatores culturais, organizacionais, políticos e econômicos que influenciam sua adoção; as estratégias de implementação, que envolvem ações planejadas — como capacitações, supervisão e engajamento de lideranças — voltadas à integração da intervenção na rotina dos serviços; e os resultados, que incluem aceitabilidade, adoção, adequação, fidelidade, custo, cobertura e sustentabilidade. A articulação desses elementos possibilita avaliar como as intervenções em saúde são aplicadas e identificar os fatores que determinam seu sucesso ou fracasso (PHILLIPS et al., 2023; PURTLE et al., 2023).

Nesse sentido, a utilização da CI nas políticas públicas permite não apenas compreender os elementos que influenciam o sucesso ou a vulnerabilidade das iniciativas, mas também orientar a formulação de estratégias que ampliem sua eficácia em diferentes contextos. Ao integrar evidências científicas ao processo decisório, essa área do conhecimento favorece a adaptação das intervenções às realidades locais, reconhecendo a influência de fatores organizacionais, humanos e contextuais sobre os resultados alcançados. Assim, a CI fortalece a capacidade dos sistemas de saúde em planejar, implementar e sustentar ações que produzam efeitos concretos, duradouros e socialmente relevantes (KANNO et al., 2023).

Ao considerar essa estrutura analítica, é possível verificar que o campo da CI tem ganhado relevância no cenário nacional, sendo progressivamente incorporado em políticas públicas e estratégias voltadas à promoção da saúde. No Brasil, a CI tem se mostrado um referencial promissor para o aprimoramento de programas, sobretudo nas áreas de saúde e alimentação. Um exemplo é a análise da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), que aplicou o modelo *Program Impact Pathways (PIP)* para identificar fatores que impactam sua

execução, destacando a importância da coordenação, do monitoramento e da capacitação para a sustentabilidade da intervenção (MELO; VENÂNCIO, 2023).

De modo semelhante, a aplicação da CI também se evidencia em pesquisa sobre a expansão do Programa Criança Feliz (PCF), voltado à promoção do desenvolvimento infantil em famílias vulneráveis. Nesse caso, permitiu compreender como dimensões como alcance, eficácia, adoção, implementação e manutenção influenciaram a consolidação do programa nos municípios brasileiros. Essa abordagem demonstra que a efetividade do PCF não depende apenas da estrutura técnica das ações, mas da interação entre fatores políticos, institucionais e operacionais que sustentam sua execução em larga escala, evidenciando a necessidade de instrumentos analíticos capazes de sistematizar esses múltiplos elementos do processo de implementação (BUCCINI et al., 2021).

Considerando tais complexidades, a incorporação de *frameworks* na Ciência da Implementação representa um avanço metodológico importante, pois oferece uma estrutura teórico-prática capaz de orientar a compreensão das dinâmicas que permeiam a adoção, a execução e a sustentabilidade de programas e políticas públicas. Esses referenciais funcionam como guias analíticos que permitem planejar e avaliar intervenções de forma mais sistemática, promovendo clareza e rigor nos processos avaliativos. Ao utilizá-los, pesquisadores e gestores conseguem identificar barreiras, facilitadores e componentes críticos para o sucesso das ações, reduzindo a subjetividade e ampliando o potencial de sustentabilidade em diferentes contextos (NIELSEN, 2015).

Dentre os modelos teóricos desenvolvidos para orientar esse tipo de análise, destaca-se a *framework* RE-AIM (*Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance*), amplamente utilizado na CI para avaliar programas e intervenções em saúde. Criado para aprimorar a qualidade dos relatos e fortalecer a validade interna e externa das pesquisas, o RE-AIM permite examinar de forma integrada o alcance, a efetividade, a adoção, a implementação e a manutenção das ações, favorecendo uma compreensão mais ampla do impacto das intervenções e subsidiando decisões voltadas à melhoria das práticas em saúde pública (GLASGOW; VOGT; BOLLER, 1999; GLASGOW et al, 2019).

No Brasil, o uso do *framework* RE-AIM foi ampliada a partir de sua tradução e adaptação transcultural para o português, em 2013, o que permitiu sua aplicação em pesquisas e programas de saúde voltados à realidade local. Esse processo buscou manter a coerência

conceitual do modelo original, ao mesmo tempo em que ajustou termos e significados às especificidades culturais e institucionais do país. Com essa versão adaptada, pesquisadores e gestores passaram a dispor de uma ferramenta mais acessível e contextualizada, favorecendo análises consistentes e o aprimoramento das práticas de implementação em diferentes cenários (ALMEIDA; BRITO; ESTABROOKS, 2023). A seguir, apresenta-se a Figura 3, que sintetiza as dimensões do modelo RE-AIM:

Figura 3: Dimensões do *framework* RE-AIM



Fonte: <https://dissemination-implementation.org/models/re-aim-1-0-framework/> (Adaptada)

Pesquisadores apontam que as políticas públicas podem ser analisadas como elementos a serem adotados, processos a serem conduzidos ou abordagens transformadoras em si (LANE et al., 2020; CHEN et al., 2021; PHILLIPS et al., 2022). Nessa perspectiva, a *framework* RE-AIM tem se destacado por favorecer a análise da adoção e do impacto de políticas e programas em contextos reais (HODGSON et al., 2023). Organizada em cinco dimensões — alcance, efetividade, adoção, implementação e sustentabilidade — o modelo permite compreender resultados e fatores que influenciam a efetividade e a continuidade das intervenções (CHOMA et al., 2023).

A dimensão alcance (*Reach*) avalia a proporção e o perfil das pessoas que realmente se beneficiaram; a efetividade (*Effectiveness*) analisa os resultados alcançados e seus efeitos na saúde e no bem-estar; a adoção (*Adoption*) diz respeito ao envolvimento de gestores e profissionais na integração das iniciativas; a implementação (*Implementation*) observa a qualidade e a continuidade do processo de execução, considerando ajustes e recursos utilizados; e a sustentabilidade (*Maintenance*) verifica a durabilidade das práticas ao longo do tempo. Assim, a RE-AIM proporciona uma abordagem que conecta dimensões individuais e organizacionais, apresentando a compreensão sobre a eficácia de políticas públicas na área da saúde (RACEY et al, 2022; ALVES et al, 2025).

Para o estudo aqui apresentado, a framework RE-AIM foi utilizada para orientar a coleta, organização e análise dos dados, articulado a referenciais teóricos da ciência da implementação para interpretação dos achados. Essa estrutura permitiu identificar lacunas no processo de implementação, propor estratégias de aprimoramento e formular recomendações práticas voltadas à sustentabilidade das UAPI. Além disso, contribuiu para evidenciar fatores contextuais e institucionais que influenciam a efetividade das ações, integrando análise empírica e reflexão crítica sobre os processos de implementação. A seguir, são apresentadas as formas como cada dimensão foi aplicada.

Figura 4: Dimensões do RE-AIM adaptadas para a avaliação da iniciativa UAPI.



Fonte: a autora

Nesse contexto, cada uma das dimensões foi adaptada da seguinte maneira: O primeiro domínio, Alcance, focaliza a proporção e as características do público que de fato acessa a intervenção. No contexto da UAPI, esse componente é importante para analisar se as ações formativas e assistenciais conseguiram atingir os profissionais previstos e se esses profissionais representam adequadamente a diversidade das equipes da ESF. A ênfase no nível individual lembra que desigualdades internas às unidades — como carga de trabalho, ausência por

demandas assistenciais e rotatividade — podem influenciar quem participa e, portanto, quem é exposto aos potenciais benefícios do programa.

A dimensão da Efetividade aparece vinculada aos impactos positivos e negativos produzidos sob condições ideais. Esse domínio permite refletir sobre o que a iniciativa pode alcançar em termos de mudança de conhecimentos e práticas, considerando o potencial teórico da intervenção, e avaliar a efetividade da capacitação nas mudanças de práticas cotidianas para a promoção do desenvolvimento infantil. Para a tese, isso dialoga diretamente com a pergunta sobre se os ciclos formativos da UAPI promoveram maior capacidade técnica para apoiar o desenvolvimento infantil e melhorar indicadores de cuidado — incluindo os efeitos percebidos pelos profissionais nos atendimentos cotidianos.

O domínio Adoção, situado no nível organizacional, apresenta a decisão institucional de incorporar a intervenção e as práticas que emergem a partir dela. Ele oferece um olhar sobre o comportamento das unidades de saúde enquanto coletivos: como os gestores acolhem a iniciativa, como redistribuir tarefas, quais rotinas são revistas e que elementos se institucionalizam. No caso da UAPI, a adoção envolve compreender se as unidades reorganizaram fluxos e passaram a valorizar ações e articulação com serviços intersetoriais.

A dimensão seguinte, Implementação, destaca a consistência e fidelidade da intervenção quando aplicada em condições reais. Essa perspectiva é particularmente relevante no cotidiano da APS, onde limitações de tempo, sobrecarga, insuficiência de infraestrutura e as recomendações da UAPI são efetivamente operacionalizadas. Avaliar essa dimensão permite identificar adaptações necessárias, pontos de fragilidade e elementos que facilitam a integração da iniciativa ao trabalho já existente.

Sobre a Manutenção, aborda a sustentabilidade dos resultados ao longo do tempo, considerando tanto o nível individual quanto o organizacional. Esse componente é importante para intervenções que visam mudanças culturais e práticas duradouras, como é o caso da UAPI, que depende de continuidade política, estabilidade das equipes, rotinas institucionalizadas e monitoramento constante dos indicadores.

Dessa forma, o referencial teórico apresentado fornece a base conceitual que sustenta a análise proposta neste estudo, articulando os princípios da Ciência da Implementação e da

framework RE-AIM à compreensão das ações desenvolvidas nas Unidades Amigas da Primeira Infância.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DO ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, orientada pelo referencial da Ciência da Implementação (WANG et al, 2023) e utilizou-se a *framework* RE-AIM foi utilizada para orientar a coleta, organização e análise dos dados (CHOMA et al., 2023). Adotou-se a abordagem de estudo de caso comparativo (YIN, 2015), a partir de dados qualitativos e quantitativos, analisados de forma integrada, envolvendo duas USF com diferentes desfechos em relação à certificação da iniciativa UAPI.

Essa escolha metodológica justifica-se pela necessidade de analisar dois contextos distintos, ainda que inter-relacionados, o que permite identificar semelhanças, diferenças e fatores contextuais que influenciam a implementação de políticas, programas ou práticas sociais. A combinação das abordagens qualitativa e quantitativa possibilita uma compreensão mais abrangente do fenômeno estudado, ao integrar a exploração dos significados e percepções dos participantes com a análise de dados empíricos que expressam dimensões mensuráveis do contexto investigado (CRESWELL; CLARK, 2018).

O estudo de caso, conforme proposto por Yin (2015), é uma abordagem metodológica que possibilita examinar processos, práticas e percepções em profundidade, especialmente em situações em que os limites entre o fenômeno estudado e o contexto não estão claramente definidos. Parte-se do reconhecimento de que a realidade social é complexa, dinâmica e interdependente, exigindo uma análise que preserve a riqueza do contexto e as interações entre seus diferentes elementos.

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA

Recife, capital do estado de Pernambuco, possui área territorial de aproximadamente 218 km² e população estimada em 1,5 milhão de habitantes, sendo o centro político, econômico e cultural do estado. O território apresenta elevada densidade demográfica e marcantes desigualdades socioespaciais, refletidas em contrastes entre bairros com altos indicadores socioeconômicos e áreas de vulnerabilidade social, especialmente nas periferias e zonas de

morro. Essa heterogeneidade territorial impõe desafios significativos à gestão em saúde, demandando políticas públicas que articulem equidade, intersetorialidade e territorialização das ações (IBGE, 2022).

No âmbito da APS, o Recife foi um dos municípios pioneiros na expansão da ESF no Nordeste, consolidando-a como eixo estruturante da Rede de Atenção à Saúde. A Secretaria de Saúde Municipal adota o modelo de gestão distrital, dividido em oito Distritos Sanitários (DS), responsáveis pela organização das ações e serviços no território. De acordo com Relatório Detalhado de 2024, a cobertura da ESF no Recife, alcançou 75,8% no primeiro quadrimestre de 2024, com mais de 130 Unidades de Saúde da Família distribuídas nos diferentes distritos, e desenvolvem ações voltadas à vigilância em saúde, atenção materno-infantil, imunização, promoção do desenvolvimento infantil e acompanhamento de condições crônicas (RECIFE, 2024).

Para isso, as USF assumem papel central na coordenação do cuidado e na articulação intersetorial com creches, escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e demais equipamentos sociais, reafirmando o compromisso do município com a promoção do desenvolvimento infantil integral e com a consolidação dos princípios do SUS. Para a pesquisa, duas USF foram contempladas, uma delas, Chão de Estrelas, no bairro da Campina do Barreto, Recife-PE, fazendo parte do DS 2, com uma população de cerca de 9.000 pessoas.

Para esse estudo, que foi realizado em duas Unidades de Saúde da Família (USF) certificadas no primeiro ciclo da Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI). Considerou-se como unidade de análise, a própria unidade, uma vez que o reconhecimento é institucional, ainda que o processo envolva diretamente o engajamento das equipes da ESF. No período da coleta, uma das unidades permanecia certificada, enquanto a outra perdeu a certificação após reavaliação municipal, mantendo parte das ações preconizadas. Essa distinção permitiu comparar diferentes estágios de implementação da UAPI e compreender fatores que influenciaram a continuidade das práticas no território.

Para melhor contextualizar esse processo, é importante compreender o significado e os critérios que sustentam a certificação no âmbito da iniciativa. A certificação UAPI representa o reconhecimento institucional das USF que incorporaram em suas práticas ações voltadas à promoção do desenvolvimento integral da criança, considerando indicadores de saúde e o processo de trabalho das equipes. O processo é conduzido de forma intersetorial e envolve a

análise de critérios estabelecidos em ciclos avaliativos, com foco na qualidade e continuidade das ações de cuidado à gestante, ao bebê e à família. Essa avaliação busca não apenas mensurar resultados, mas também verificar a consolidação de rotinas e estratégias que assegurem o acompanhamento integral durante a primeira infância (DAELMANS; MANJI; RAINA, 2021).

Os indicadores utilizados para a certificação contemplam dimensões essenciais do cuidado infantil e materno, como o número de consultas de pré-natal realizadas, o início precoce do acompanhamento da gestante, aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, o esquema vacinal atualizado e a realização das consultas de puericultura. Além disso, incluem o acompanhamento odontológico das crianças menores de dois anos, as ações de promoção do desenvolvimento e as práticas educativas voltadas ao fortalecimento do vínculo entre a família e os serviços de saúde. Esses indicadores refletem o compromisso das equipes com a integralidade do cuidado e a articulação das ações no território (SILVA; FERNANDES; ALVES, 2020).

A perda da certificação ocorre quando a unidade deixa de atender a algum dos critérios obrigatórios da iniciativa, especialmente nos casos em que um ou mais indicadores permanecem zerados. Essa situação indica a ausência de registros ou de execução de determinadas ações consideradas essenciais para a atenção à primeira infância. Em alguns contextos, fatores estruturais, limitações na oferta de serviços e descontinuidade de práticas programáticas contribuíram para o não alcance das metas estabelecidas. A perda do selo, portanto, não representa apenas uma falha administrativa, mas evidencia desafios na sustentabilidade das ações e na manutenção do engajamento das equipes diante de condições adversas.

A Unidade possui quatro eSF compostas por médico, enfermeiro, cinco ACS, cirurgião-dentista e técnico em Saúde Bucal. As equipes atuam em sistema de turnos, com um contraturno semanal voltado a ações programadas conforme a agenda local, e seu funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, para ampliação da cobertura assistencial no território. A unidade conta com Equipe Multidisciplinar (E-Multi) formada por assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista, o que fortalece o cuidado integral. No mesmo prédio funciona um ponto de apoio do Projeto Mãe Coruja Pernambucana, ampliando a articulação intersetorial e o acompanhamento de gestantes e crianças.

A Unidade de Saúde da Família Byron Sarinho localiza-se no bairro de Água Fria, no município do Recife-PE, e integra o DS VI. Ela dispõe de três Equipes de Saúde da Família

(eSF), compostas por médico, enfermeiro, cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS), cirurgião-dentista e técnico em Saúde Bucal. As equipes organizam-se em sistema de turnos, com um contraturno semanal para a ampliação dos atendimentos, e seu funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Ela possui uma população em torno de 6.100 usuários.

Ambas USF estavam vivenciando a ampliação da APS, em 2023 o Ministério da Saúde apresentou uma nova diretriz, com o propósito de assegurar acesso qualificado e universal. A proposta incluiu a reestruturação dos horários de funcionamento das equipes da ESF, a redução do número de pessoas acompanhadas por equipe, além da criação de estratégias para composição completa das equipes e aprimoramento dos processos de trabalho. Antes da execução do plano, o Recife apresentava cobertura de 59,6% da ESF e 39% da Saúde Bucal, com 283 equipes de Saúde da Família (eSF) e 193 equipes de Saúde Bucal (eSB) distribuídas em USF nos oito Distritos Sanitários (RECIFE, 2023).

A nova proposta foi estruturada em dois eixos centrais: o primeiro voltado à adequação dos parâmetros de trabalho, contemplando aspectos estruturais e quantitativos das unidades; e o segundo, ao processo de trabalho, com foco na qualificação profissional, fortalecimento dos vínculos com a comunidade e retomada das ações de promoção e prevenção em saúde. Nesse contexto, em novembro de 2023, teve início o processo de reterritorialização da Atenção Básica, com contagem populacional voltada ao diagnóstico rápido do território, subsidiando a ampliação das equipes e a reorganização das áreas adscritas das USF (BRASIL, 2023).

Com o objetivo de qualificar o processo de trabalho, iniciou-se uma revisão coletiva das agendas das equipes, buscando ampliar o acesso da população, resgatar atividades típicas da ESF e incentivar a educação permanente e as discussões multiprofissionais sobre manejo terapêutico e práticas de cuidado. Em paralelo, foi instituído o acolhimento unificado nas USF, como estratégia de ampliação do acesso e de oferta de escuta qualificada e resolutiva, alinhada aos princípios da integralidade e da humanização da Atenção Básica (BRASIL, 2023).

Por se tratar de uma proposta abrangente e inovadora, foram criados colegiados semanais e fortalecidas as articulações intra e intersetoriais para o monitoramento e alinhamento das ações do plano de expansão. A execução foi organizada em quatro etapas, sendo a primeira iniciada em novembro de 2023 e a segunda em fevereiro de 2024, resultando, até o momento, na implantação de 79 novas eSF e 34 novas eSB em 49 USF+. Com essas ampliações, a

cobertura municipal alcançou 75,8% da ESF e 50,45% da eSB, conforme o novo parâmetro populacional do IBGE (RECIFE, 2023).

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO

Foram incluídos neste estudo os profissionais de saúde vinculados às USF e que participaram direta ou indiretamente da implementação das ações da Iniciativa UAPI. Consideraram-se elegíveis os trabalhadores que atuavam nas equipes da ESF há pelo menos um ano, e Equipe Multiprofissional (E-Multi), além de profissionais da gestão municipal e da Iniciativa, que acompanharam o processo de certificação e monitoramento da iniciativa, após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E foram excluídos os profissionais afastados por licença médica, férias, transferência de unidade ou desligamento no período da coleta.

3.4 PROCEDIMENTOS NA COLETA DE DADOS

A coleta de dados deste estudo foi realizada em diferentes etapas, contemplando desde a inserção da pesquisadora no contexto da Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI) até a sistematização dos dados qualitativos.

No ano de 2022, a pesquisadora entrou em contato com as gestoras dos níveis distrital e municipal da Política de Atenção à Saúde da Criança do município de Recife, e posteriormente participou das reuniões do Comitê Científico da UAPI, um espaço destinado à discussão técnica e ao acompanhamento do processo de certificação das unidades de saúde. Durante essa participação, conseguiu-se uma compreensão aprofundada do funcionamento da iniciativa, dos critérios de certificação e das estratégias de capacitação e monitoramento utilizadas. Ao longo dos ciclos avaliativos, a pesquisadora participou das reuniões do Comitê Científico, fez o curso on-line e acompanhou os indicadores de saúde avaliados através dos dados acessados em contato com a gestão municipal.

A coleta de dados foi planejada para ocorrer no segundo semestre de 2023, após a conclusão das etapas preparatórias. Nessa fase, a pesquisadora buscou o acesso aos campos previamente selecionados, com o objetivo de realizar entrevistas, observações e registros de campo junto às equipes. Entretanto, a coleta não pôde ser efetivada naquele período devido a dificuldades de acesso ao campo de pesquisa, relacionadas a limitações administrativas e

operacionais que restringiram a entrada da pesquisadora nas unidades de saúde. Essas barreiras incluíram mudanças de gestão, poucas respostas aos formulários enviados *online* e reorganização interna das equipes.

No ano de 2024, em reunião com a gestora do nível municipal, após a segunda certificação, foi definido, para responder à proposta da pesquisa, que seriam dois casos a serem investigados: uma unidade certificada e outra que havia deixado de ser certificada em razão de ter zerado um dos indicadores estabelecidos no processo avaliativo. A seleção desses dois cenários buscou contemplar experiências dentro da própria implementação da UAPI, permitindo identificar avanços, obstáculos e fatores determinantes para a manutenção dos padrões de qualidade propostos pela iniciativa.

Após esse momento, aconteceu a familiarização com o campo, etapa na qual a pesquisadora direcionou-se para as Unidades de Saúde da Família, em contato prévio com os gestores locais, apresentando a proposta da pesquisa e dialogando sobre a coleta de dados. A entrada formal no campo aconteceu mediante autorização institucional e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

Para a coleta de dados também foi utilizado um diário de campo (FREITAS; PEREIRA, 2018), como instrumento complementar de registro. Nele foram anotadas observações referentes ao contexto das entrevistas, às interações entre os participantes, às condições institucionais das Unidades de Saúde da Família. Esse recurso possibilitou a sistematização de elementos não captados nos áudios, como expressões não verbais, e dinâmica do espaço de coleta, contribuindo para a reflexividade, após o registro das impressões, dúvidas e ajustes necessários ao longo do trabalho de campo. Tais anotações, posteriormente, auxiliaram na interpretação dos achados e com as demais evidências produzidas.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde e gestores atuantes nos contextos selecionados para o estudo, guiadas pelas dimensões da *framework* RE-AIM, (Apêndice 1). As entrevistas foram realizadas em ambiente reservado, mediante assinatura do TCLE, e gravadas com o uso de um telefone celular modelo Motorola Moto G84, que possibilitou registro de áudio digital com boa qualidade sonora. Para o processo de transcrição, utilizou-se o software Transkriptor, ferramenta de reconhecimento automático de voz que converte gravações em texto de forma rápida e fidedigna, garantindo maior precisão

na transcrição literal das falas dos participantes e preservando a integridade do conteúdo para análise.

A amostra deste estudo foi definida por exaustão, contemplando todos os profissionais elegíveis que estavam presentes e disponíveis no período da coleta de dados. A opção pelo esgotamento total do universo ocorreu devido à indisponibilidade frequente dos trabalhadores, marcada por ausências, demandas assistenciais imprevisíveis e sobrecarga típica do cotidiano da Atenção Primária. Diante desse contexto, tornou-se inviável trabalhar com outro tipo de delineamento amostral. Assim, todos os profissionais que atendiam aos critérios de inclusão e que estiveram acessíveis durante o campo foram convidados a participar, compondo a totalidade da amostra possível nas unidades estudadas.

Além das entrevistas, foram consultados documentos institucionais e registros administrativos relacionados ao processo de certificação e acompanhamento da UAPI, visando complementar as informações obtidas e possibilitar uma análise mais abrangente. Isso, configurou o acesso aos dados quantitativos da pesquisa, que são os indicadores contemplados na Iniciativa, na periodização de quadrimestres, disponibilizados pela gestão municipal da Política de Atenção à Saúde da Criança, tabulados em Excel, os quais foram analisados.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

3.5.1 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS

Para a análise dos dados qualitativos, foi utilizada a análise temática, de forma dedutiva, de acordo com Braun e Clarke (2015), realizada em cinco fases interdependentes. A partir dos dados coletados, essa abordagem possibilitou identificar, organizar e interpretar padrões de sentidos, no caso, os temas, o que permite uma compreensão aprofundada do fenômeno investigado. As fases desenvolvidas foram:

- i) Familiarização com os dados: leitura e releitura minuciosa das transcrições das entrevistas e dos registros de campo, com anotações iniciais para apreensão das ideias centrais e impressões preliminares.
- ii) Geração de códigos iniciais: identificação e codificação de trechos relevantes do material, de modo sistemático, considerando aspectos relacionados ao objeto de estudo e às dimensões analíticas previamente definidas.

- iii) Busca por temas: agrupamento dos códigos em categorias mais amplas, de forma a estruturar potenciais temas que refletissem padrões recorrentes ou elementos significativos para a compreensão da implementação da política estudada.
- iv) Revisão dos temas: análise crítica dos agrupamentos construídos, verificando sua consistência interna e relação com o conjunto dos dados, com ajustes e reorganizações quando necessário.
- v) Definição e nomeação dos temas: refinamento final dos temas, com elaboração de descrições claras, abrangentes e coerentes, que serviram de base para a etapa interpretativa e discussão dos resultados.

A análise foi conduzida de forma estruturada, assegurando clareza em todas as etapas do processo e preservando a transparência dos procedimentos, desde a organização inicial dos dados até a elaboração das categorias e sínteses interpretativas. Nesse sentido, teve-se como propósito a correspondência entre o material empírico e a interpretação realizada do material coletado em campo, mantendo o rigor científico, apresentado na figura abaixo:

Figura 5: Etapas da análise dos dados de acordo com Braun e Clarke



Fonte: a autora

3.5.2 ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS

A análise quantitativa foi conduzida em duas etapas complementares. Na primeira, de caráter descritivo, buscou-se caracterizar as variáveis do estudo por meio da apresentação de frequências absolutas e relativas (percentuais), possibilitando uma visão inicial do comportamento dos indicadores em cada unidade de saúde e ao longo dos quadrimestres analisados. Em seguida, os resultados foram interpretados em articulação com a etapa qualitativa, o que permitiu relacionar os padrões observados aos fatores contextuais

identificados nos discursos dos participantes, aprofundando a compreensão do fenômeno investigado (GARCIA; SANTOS, 2022).

As variáveis selecionadas refletem indicadores sensíveis à atuação da Atenção Primária à Saúde, em consonância com as ações preconizadas pela UAPI. Foram considerados os seguintes indicadores: proporção de gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal no período de quatro meses; gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; crianças em aleitamento materno exclusivo até seis meses; crianças menores de cinco anos com peso adequado para a idade; crianças de até um ano, onze meses e vinte e nove dias com pelo menos uma consulta odontológica programática; e crianças com dois anos completos que realizaram nove ou mais consultas de puericultura (GUBERT et al, 2021).

Esses indicadores representam dimensões essenciais do cuidado integral à gestante, à criança e à família, conforme os fundamentos da *Nurturing Care Framework* (FNC), orientando o conjunto de ações prioritárias da Estratégia Saúde da Família. No contexto da UAPI, funcionam como parâmetros para o monitoramento da qualidade das práticas de atenção, da continuidade do cuidado e da efetividade das iniciativas intersetoriais voltadas à promoção do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida. Além disso, possibilitam reconhecer avanços e fragilidades na consolidação de uma rede de atenção que favoreça o desenvolvimento pleno da criança (BORGES; SANTOS; SIMÕES, 2020).

A análise quantitativa desses dados buscou identificar tendências e variações no desempenho das unidades de saúde, oferecendo subsídios à compreensão das condições de implementação da iniciativa. O acompanhamento sistemático dos indicadores apoia o planejamento das ações locais e fortalece o vínculo entre equipes e famílias, ao favorecer práticas baseadas em evidências e alinhadas aos princípios da universalidade, integralidade e longitudinalidade da APS. Além de subsidiar processos avaliativos, essa análise pode contribuir para a tomada de decisão em nível gerencial, permitindo ajustar estratégias e otimizar recursos de acordo com as necessidades do território (CASTANHEIRA et al, 2024).

Com base nessas informações descritivas, procedeu-se à etapa inferencial, voltada à análise comparativa e à identificação de padrões de comportamento entre os contextos estudados. Nessa fase, foram realizadas duas análises distintas: a primeira comparou as proporções observadas entre as Unidades Caso 1 e Caso 2 em quadrimestres, permitindo identificar possíveis diferenças no desempenho entre os cenários; a segunda examinou a

variação temporal dessas proporções dentro de cada unidade, de modo a verificar tendências ou mudanças ao longo do tempo.

Para alcançar tais objetivos, utilizou-se o teste do Qui-quadrado, adequado para comparações de proporções entre grupos independentes, e o teste Q de Cochran, recomendado para avaliar diferenças em medidas repetidas de variáveis categóricas. Em ambas as análises, adotou-se um nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$), interpretando-se valores de p inferiores a esse limiar como evidências estatisticamente significativas de diferença entre grupos ou períodos avaliados. A escolha desses testes estatísticos fundamentou-se na natureza das variáveis e no objetivo de verificar a consistência das tendências observadas entre os dois contextos analisados.

A manipulação e o processamento dos dados foram realizados a partir de planilhas em Excel, organizadas por quadrimestres e contendo os indicadores sistêmicos definidos no estudo. As análises estatísticas foram conduzidas com o apoio dos softwares RStudio (versão 2024.04.2 Build 764) e Jamovi (versão 2.6.44). Esse procedimento assegurou maior rigor e transparência ao tratamento dos dados, permitindo a reprodutibilidade dos resultados e a integração coerente das análises.

4 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo atendeu integralmente às diretrizes éticas estabelecidas pela Resolução nº 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 68618123.8.0000.5208, sob parecer nº 6.150.202.

Todos os participantes foram informados acerca dos objetivos, procedimentos, potenciais riscos e benefícios da pesquisa, e somente após o esclarecimento de eventuais dúvidas foi solicitado o consentimento para participação, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Garantiu-se o direito de desistência a qualquer momento, sem prejuízos ou ônus para os participantes, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações coletadas.

Os dados obtidos foram utilizados exclusivamente para fins científicos, assegurando-se a preservação da identidade dos participantes e o cumprimento das normas éticas nacionais e internacionais que regem a pesquisa em saúde.

5 RESULTADOS

Os resultados deste estudo são apresentados de forma integrada, articulando evidências qualitativas e quantitativas à luz do modelo RE-AIM, que orientou a análise das dimensões de alcance, efetividade, adoção, implementação e manutenção da Iniciativa UAPI. Essa abordagem possibilitou apreender tanto os aspectos mensuráveis do desempenho das unidades de saúde, quanto às percepções e experiências dos profissionais e gestores envolvidos no processo. A análise comparativa entre os Casos 1 e 2, complementada pela visão da Gestão, permitiu identificar padrões, contrastes e fatores contextuais que influenciam a consolidação da iniciativa no território.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

A amostra foi composta por 19 participantes, com predominância do sexo feminino (n=17) e participação masculina minoritária (n=2), refletindo a predominância de mulheres nas profissões investigadas no campo da saúde. Quanto à categoria profissional, observou-se maior representatividade dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), totalizando 10 participantes, seguidos por enfermeiras (n=3), gestoras (n=3), além de uma médica, uma assistente social e uma fonoaudióloga. Em relação à vinculação institucional, três participantes atuavam na gestão, enquanto os demais estavam distribuídos entre duas Unidades de Saúde da Família (USF).

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

5.2.1 CASO 1

Durante a coleta de dados na Unidade Caso 1, constatou-se uma rotina organizada, com fluxos definidos para o atendimento e boa comunicação entre os profissionais. As ações voltadas à primeira infância são incorporadas às práticas cotidianas, especialmente nas consultas de puericultura e pré-natal, conduzidas de forma sistemática. No mesmo espaço, funciona um ponto de apoio do Programa Mãe Coruja Pernambucana (PMCP), favorecendo a integração das ações voltadas ao acompanhamento das gestantes e das crianças. Foi possível

observar também uma boa articulação entre os diferentes setores da unidade, o que contribuía para a continuidade das ações e o acompanhamento longitudinal das famílias.

Durante o trabalho de campo, as observações permitiram identificar que a equipe mantinha uma comunicação cooperativa, o que favorecia a troca de informações e a resolução das demandas cotidianas. As reuniões de equipe ocorriam de forma regular, uma vez por semana, e se configuravam como espaços de planejamento e avaliação das ações desenvolvidas. Nessas ocasiões, eram discutidas estratégias para aprimorar o alcance das metas, e reorganizar o processo de trabalho diante das necessidades do território. A coordenação mantinha-se presente no cotidiano da unidade, promovendo o diálogo entre os profissionais e estimulando o engajamento coletivo nas ações.

A boa infraestrutura da unidade favorecia o desenvolvimento das atividades, pela qualidade e funcionalidade dos espaços. O prédio conta com auditório amplo para atividades coletivas e educativas, consultórios organizados, área de recepção adequada e ambiente climatizado. Essa infraestrutura permitia o desenvolvimento das ações, criava um ambiente de trabalho mais acolhedor e contribuía para a organização dos fluxos internos, o que se refletia na execução eficiente das atividades planejadas e na satisfação da equipe e dos usuários.

Nessa unidade, constatou-se que as ações foram incorporadas com regularidade à rotina de trabalho. Os profissionais demonstraram empenho em manter as atividades voltadas à primeira infância, mesmo diante das limitações de tempo e por vezes de estrutura. As práticas são conduzidas de forma contínua, nas consultas de puericultura e nas ações educativas, o que tem contribuído para a manutenção da certificação. Apesar das dificuldades cotidianas, a equipe mantém um compromisso coletivo que sustenta a continuidade das ações e reforça o vínculo com as famílias acompanhadas.

5.2.2 CASO 2

A USF denominada Caso 2 é composta por três equipes, cada uma formada por um profissional médico, uma enfermeira, cinco Agentes Comunitários de Saúde, um dentista e uma auxiliar de saúde bucal. No período da coleta de dados, a unidade iniciava a transição para o novo modelo de funcionamento proposto pela prefeitura, das 07:00hs às 19:00hs, e a inclusão do serviço de telessaúde. Essa reestruturação exigia ajustes na dinâmica de trabalho,

especialmente na definição de turnos e na reorganização das agendas de atendimento, gerando expectativas e incertezas entre os profissionais quanto à adaptação às novas rotinas.

Durante a coleta, observou-se limitações estruturais na unidade, como infiltrações, mobiliário danificado e problemas na climatização, impactando o conforto e a permanência de usuários e profissionais. Também foram identificadas restrições de espaço para o desenvolvimento de atividades coletivas, dificultando a execução de ações educativas e intersectoriais voltadas à primeira infância. Foi recorrente o relato sobre o volume excessivo de demandas assistenciais, que se sobrepõem às atividades programáticas e dificultam a organização do processo de trabalho.

Nos relatos também foi trazido sobre as mudanças recorrentes de gestor da unidade, apontadas como um fator que alterou a dinâmica interna e o fluxo de comunicação entre os membros da equipe. Essas transições, segundo eles, trouxeram incertezas quanto à continuidade das ações, especialmente pela ausência de reuniões regulares e pela dificuldade em retomar o planejamento coletivo. Alguns profissionais mencionaram que cada nova gestão tende a redefinir prioridades e modos de organização, modificando rotinas já consolidadas e exigindo readaptações constantes da equipe. Essa sucessão de ajustes interfere na estabilidade do trabalho e na construção de estratégias conjuntas entre os diferentes profissionais.

Nesse contexto, a Caso 2 foi descredenciada após o primeiro ciclo em razão do não cumprimento de uma das exigências da UAPI, que determina que nenhum dos indicadores estabelecidos esteja zerado. Nesse caso, verificou-se valor nulo para o indicador referente à proporção de crianças de até 1 ano, 11 meses e 29 dias com uma ou mais consultas odontológicas programáticas.

5.3 AVALIAÇÃO COM BASE NAS DIMENSÕES DO MODELO RE-AIM, DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA INICIATIVA UAPI NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

5.3.1 ELEMENTOS FACILITADORES DA DIMENSÃO DE ALCANCE DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO

Em cada USF, foram identificados elementos facilitadores (F), para o desenvolvimento da iniciativa, e elementos de barreira (B), que dificultaram às ações conjuntas realizadas pela UAPI. Esses códigos foram elencados junto aos seus respectivos temas dentro das dimensões

da RE-AIM, que funcionaram como categorias (alcance, efetividade, adoção, implementação e manutenção). O quadro 2 descreve a dimensão alcance, que, segundo o modelo RE-AIM, expressa o envolvimento das famílias pelas ações da iniciativa.

No Caso 1, destacou-se a capilaridade das visitas domiciliares qualificadas, o acolhimento às gestantes e cuidadores e a busca ativa de crianças para a vacinação. A parceria com o programa Mãe Coruja ampliou o contato com famílias em maior vulnerabilidade, fortalecendo o vínculo e a continuidade do cuidado. No Caso 2, ele foi garantido principalmente por meio de visitas domiciliares, ações coletivas e estratégias simples de engajamento, como convites e lanches, que favoreceram a aproximação com a comunidade. Mesmo diante de limitações estruturais, a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde manteve o elo entre a unidade e as famílias, assegurando a presença da UAPI no território. Na Gestão, foi impulsionado pela integração entre saúde, educação e assistência social, pelo olhar territorial e pela escuta de famílias e crianças. E também as ações de mobilização, esforço de institucionalização da iniciativa e o reconhecimento do papel estratégico da gestão para consolidar o cuidado integral na primeira infância.

Quadro 1. Elementos facilitadores da dimensão de alcance do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Orientações nas visitas	Visita domiciliar qualificada e orientações precoces	“Começamos a abordar sobre a leitura, a música, na preparação para a chegada do bebezinho, aleitamento, vacinas...” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Acolhimento nas visitas	Acolhimento e vínculo com a família	“A mãe se sentia totalmente acolhida... ela tinha segurança quando a gente fazia a visita... tirava as suas dúvidas sobre como cuidar do bebê...” (ACS - Participante 4)

Caso 1	Busca ativa de vacinação	Busca ativa e mobilização para imunização	“A coordenadora... mandava... fazer essas buscas ativas... procurar os casos, colocar as vacinas em dias” (Enfermeira - Participante 6)
Caso 1	Busca ativa de vacinação	Busca ativa e mobilização para imunização	“Na vacinação... a gente fica em cima... faz busca ativa, vai nas casas, conversa com as mães.” (ACS - Participante 7)
Caso 1	Parceria Mãe Coruja para mobilização	Parcerias intersetoriais (Mãe Coruja/CRAS/NASF)	“Mãe Coruja... consegue trazer muito o público... As mães vem, pois ele ajuda, fornece kit para o bebê... banheira, roupinhas...” (Assistente social - Participante 9)
Caso 2	Repasse de conhecimento às famílias do aprendizado no curso	Educação em saúde nas visitas/ações	“Todos os cursos que chegam para a gente, repassam, e vamos passar o conhecimento para as famílias...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Busca ativa de vacinação	Busca ativa e mobilização para imunização	“Na imunização, a gente vai, corre atrás e traz mesmo... pega o cartão, vê quais tão faltando...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Busca ativa de vacinação	Busca ativa e mobilização para imunização	“A gente vai na comunidade, sempre faz essa busca ativa... conversa com a mãe, diz que ele pode ficar doente sério se não

			tomar a vacina” (ACS - Participante 12)
Caso 2	Orientações nas visitas	Visita domiciliar qualificada	“Tudo termina mesmo nas nossas visitas. É onde a gente vê a própria realidade... entra na casa da família, tenta ajudar de algum jeito...” (ACS - Participante 13)
Caso 2	Convites e lanches em ações	Estratégias de engajamento comunitário	“...a gente faz convite para as mães, e aí a gente sempre faz lanche...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Ações coletivas (palestras/salas de espera)	Ações coletivas e salas de espera	“Palestra é muito importante... os usuários gostam, perguntam sobre o assunto...” (ACS - Participante 19)
Gestão	Integração intersetorial (saúde/educação/assistência)	Integração intersetorial	“Mesmo sendo uma iniciativa da saúde, desde o início a proposta era trabalhar a integração entre saúde, educação e assistência...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Olhar para o território	Territorialização	“Um dos pontos que a UAPI traz é: vamos olhar primeiro para o nosso território.” (Gestão - Participante 1)

Gestão	Escuta de famílias e crianças	Participação social/escuta	“...ouvir essas crianças através de desenhos... pensar em novas maneiras para acesar essa faixa etária...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Organização com ACS e famílias	Engajamento e mobilização territorial	“...nos organizávamos em equipe para fazer contato com os ACSs e as famílias.” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Ações coletivas (palestras/salas de espera)	Ações coletivas e reuniões comunitárias	“Precisamos realizar reuniões comunitárias e salas de espera... conversamos sobre a importância das atividades” (Gestão Caso 1- Participante 3)
Gestão	Ampliação de unidades (escala)	Escala e expansão	“...ampliação importante... sete unidades do distrito 2 e sete do distrito 8, para melhor atender à população...” (Gestão - Participante 2)

5.3.2 ELEMENTOS DE BARREIRA DA DIMENSÃO DE ALCANCE DO CASO 1 E CASO 2.

No Caso 1, a principal barreira identificada foi a baixa adesão da comunidade às atividades coletivas promovidas pela equipe, o que restringiu o alcance das ações para além das visitas domiciliares. Embora as iniciativas educativas, como as campanhas e eventos temáticos, buscassem fortalecer o vínculo com as famílias, a participação reduzida comprometeu a visibilidade da proposta no território e limitou a troca de experiências entre cuidadores.

No Caso 2, as barreiras estavam relacionadas à cobertura limitada das ações e ao condicionamento da vacinação à manutenção de benefícios do programa Bolsa Família, o que pode reduzir a autonomia e o engajamento espontâneo das famílias. Além disso, os profissionais

relataram dificuldades na comunicação com a gestão, especialmente pela ausência de devolutivas e espaços de diálogo sobre as práticas desenvolvidas.

Quadro 2. Elementos de barreira na dimensão de alcance do Caso 1 e Caso 2.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Alcance limitado/baixa adesão	Baixa participação comunitária nas ações coletivas	“A gente já fez Agosto Dourado e vem pouquíssima gente.” (Assistente social - Participante 9)
Caso 2	Alcance limitado/sem acesso	Cobertura/alcance insuficiente	“Sendo bem sincera, não tiveram acesso.” (ACS - Participante 16)
Caso 2	Vacinação condicionada ao Bolsa Família	Condicionalismo por programas sociais	“Hoje em dia é tudo relacionado à bolsa-família.” (ACS - Participante 14)
Caso 2	Vacinação condicionada ao Bolsa Família	Condicionalismo por programas sociais	“...sempre tem que botar o Bolsa Família no meio, é triste.” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Comunicação deficiente/sem devolutiva	Falta de devolutiva/comunicação com gestão	“Estão discutindo entre eles, já estão vindo com o discurso pronto...” (ACS - Participante 12)
Caso 2	Comunicação deficiente/sem devolutiva	Falta de devolutiva/comunicação com gestão	“A gente responde, participa, mas depois não tem retorno.” (ACS - Participante 17)

5.3.3 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE EFETIVIDADE DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão efetividade, observou-se, no Caso 1, a percepção concreta de resultados nas crianças acompanhadas e nas práticas da equipe. Os profissionais relataram avanços visíveis no comportamento e desenvolvimento infantil, atribuídos à intensificação das visitas e à ampliação das orientações às famílias. Também foram mencionadas melhorias em indicadores de saúde e a consolidação de uma postura mais vigilante e sensível ao cuidado infantil, expressa na noção de “sentinela” entre os membros da equipe. As ações educativas voltadas ao aleitamento materno destacaram-se como um dos principais focos de efetividade, tanto pelo apoio técnico às mães quanto pela valorização do vínculo e da escuta durante o atendimento.

No Caso 2, os resultados estiveram relacionados ao fortalecimento das práticas educativas, especialmente sobre aleitamento materno, desenvolvimento infantil e vacinação. As falas indicam que a certificação da unidade como UAPI contribuiu para atualizar conhecimentos e aprimorar o olhar da equipe sobre a primeira infância, refletindo em maior segurança nas orientações. Já na Gestão, a efetividade foi observada na intensificação das ações e no aprimoramento dos registros, que possibilitaram melhor acompanhamento dos indicadores e alcance de 100% de cobertura vacinal em algumas equipes.

Quadro 3. Elementos facilitadores na dimensão de efetividade do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Resultados percebidos com as crianças	Efeitos percebidos nas crianças	“Consegui ter um retorno durante e depois das ações, melhoria no peso, com resultados concretos com as crianças.” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Sensibilidade e vínculo com famílias	Acolhimento e comunicação empática	“Aumentou a sensibilidade em relação à comunicação e interação com a família...” (ACS - Participante 4)

Caso 1	Melhora de indicadores	Melhoria de indicadores	“Os indicadores deram uma melhoria sim, as consultas de pré-natal, o aleitamento materno exclusivo ...” (Médica - Participante 5)
Caso 1	Sentinela/alerta da equipe	Vigilância ativa da equipe	“É como se tivesse acendido uma sentinela, todos estão alertas...” (Médica - Participante 5)
Caso 1	Educação em saúde para apoio à amamentação	Promoção do aleitamento materno	“A gente veste aquele seio... traz o seio para a mãe ver.” (Fonoaudióloga - Participante 8)
Caso 2	Educação em amamentação (técnicas/pega)	Promoção do aleitamento materno	“Sobre a amamentação, a gente sempre faz, (que é o Agosto Dourado)...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Orientação a mães adolescentes	Métodos Contraceptivos	“Tem mães muito novinhas... a gente busca elas, fala sobre anticoncepcional...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Atualização sobre desenvolvimento infantil	Aprimoramento técnico em desenvolvimento infantil	“A certificação foi fundamental para atualizar algumas coisas sobre aprendizado, os marcos...” (Enfermeira - Participante 15)
Caso 2	Educação em amamentação (técnicas/pega)	Promoção do aleitamento materno	“...a pega correta do bebê no peito... mãe que tem o bico invertido também pode...” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Atualização sobre vacinação	Atualização técnica em imunização	“...é sempre bom estar se atualizando... saber qual vacina está sendo aplicada...” (ACS - Participante 19)

Caso 2	Orientações sobre telas e brincar	Promoção do brincar e redução de telas	“Na visita, eu sempre procuro estimular as mães... evitar as telas...” (ACS - Participante 18)
Gestão	Melhora por intensificação e registro	Cultura do registro e melhoria	“...melhoraram seus dados não só porque intensificaram as ações, mas também porque melhoraram o registro.” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Cobertura vacinal 100%	Resultados em imunização	“Alcançamos 100% de adesão à vacinação...” (Gestão- Caso 1- Participante 3)
Gestão	Melhora a quadrimestre quadrimestre	Melhora temporal/monitoramento	“...primeiro quadrimestre de 2025... ninguém... regrediu.” (Gestão- Participante 2)

5.3.4 ELEMENTOS DE BARREIRAS NA DIMENSÃO DE EFETIVIDADE DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão efetividade, as principais barreiras relatadas no Caso 1 estavam associadas à resistência de algumas famílias em aderir às orientações repassadas pelas equipes e à forte influência das redes sociais sobre as práticas de cuidado infantil. Os profissionais destacaram que informações equivocadas ou contraditórias circulando na internet interferem na continuidade do aleitamento materno e na adesão a condutas recomendadas. Além disso, a vulnerabilidade social e a presença de violência no território foram apontadas como fatores que dificultam o acompanhamento e a manutenção dos vínculos com as famílias.

No Caso 2, as barreiras mantêm características semelhantes, com relatos de resistência familiar, condições socioeconômicas precárias e contextos de risco que limitam o alcance das ações de cuidado. Os profissionais mencionaram desafios para sensibilizar as famílias sobre práticas de saúde e proteção infantil, em territórios marcados por desigualdades e insegurança. Na gestão, a principal limitação identificada foi a cultura da falta de registro sistemático das

ações, o que compromete a confiabilidade dos dados e dificulta a avaliação precisa dos resultados alcançados.

Quadro 4. Elementos de barreiras na dimensão de efetividade do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Baixa adesão/resistência familiar (influência da internet)	Influência das redes/baixa adesão	“A internet com tantas informações, hoje em dia.. sobre leite, fórmula... é uma ou outra mãe que permanece... nesse aleitamento direitinho.” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Baixa adesão/resistência familiar (influência da internet)	Influência das redes/baixa adesão	“É muito mais fácil outra pessoa me ajudar dando a mamadeira...algumas mães falam assim...” (Fonoaudióloga - Participante 8)
Caso 1	Baixa adesão/resistência familiar (influência da internet)	Influência das redes/baixa adesão	“Já chegam... pedindo remédio... já com diagnóstico formado...não querem escutar a gente...” (ACS - Participante 7)
Caso 1	Vulnerabilidade social/violência no território	Vulnerabilidade social e contextos de risco	“Resume tudo na desigualdade social.” (ACS - Participante 7)
Caso 1	Vulnerabilidade social/violência no território	Vulnerabilidade social e contextos de risco	“Estou com uma família... a mãe é uma usuária de drogas ilícitas...Isso afeta o vínculo...” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Vulnerabilidade social/violência no território	Vulnerabilidade social e contextos de risco	“Área... muito complicada... drogas, violência, marginalidade.” (ACS - Participante 7)

Caso 2	Baixa adesão/resistência familiar (influência da internet)		Resistência/baixa adesão familiar	“Os usuários daqui são muito rebeldes. A maioria é... não aceitam conversar algumas vezes...” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Vulnerabilidade social/violência território	no	Vulnerabilidade social e contextos de risco	“Tem família que não tem nem o básico, aí fica difícil falar... se eles tem quase nada” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Vulnerabilidade social/violência território	no	Vulnerabilidade social e contextos de risco	“...ficam mais na rua até certas horas, 11 horas. Então ficam muito vulneráveis.” (ACS - Participante 14)
Caso 2	Vulnerabilidade social/violência território	no	Vulnerabilidade social e contextos de risco	“A área que eu trabalho [...] tráfico de drogas. Muitas crianças entrando nas drogas.” (ACS - Participante 14)
Gestão	Melhoria intensificação registro	por e	Cultura da falta registro e melhoria	“...precisavam melhorar seus dados não só porque intensificaram as ações, mas também porque melhoraram o registro.” (Gestão - Participante 1)

5.3.5 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE ADOÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão adoção, os profissionais reconheceram a importância dos conhecimentos abordados durante a iniciativa UAPI para o aprimoramento da prática profissional e para a qualificação do cuidado oferecido às crianças e famílias. No Caso 1, destacaram-se a motivação para participar das capacitações e o fortalecimento do trabalho em equipe, tanto entre os profissionais da unidade quanto nas parcerias estabelecidas com a E-multi, o CRAS e o programa Mãe Coruja. Essa integração favoreceu a incorporação das ações da UAPI na rotina da unidade, garantindo a continuidade de práticas voltadas à primeira infância, após o encerramento dos ciclos formativos. A colaboração interprofissional foi percebida como um dos principais fatores que sustentam a adesão às propostas da iniciativa no cotidiano do serviço.

No Caso 2, a adoção das práticas também ocorreu por meio da motivação intrínseca e do senso de responsabilidade dos profissionais, especialmente dos Agentes Comunitários de Saúde, que relataram orgulho e satisfação em atuar com o público infantil. As falas evidenciam que o aprendizado adquirido durante a certificação foi incorporado às atividades diárias, com ênfase nas orientações às famílias e no apoio mútuo entre os membros da equipe. Na Gestão, o processo de adoção foi descrito como resultado da sensibilização e da proatividade das equipes, que já se mostravam comprometidas com os processos de trabalho e dispostas a integrar as ações na rotina.

Quadro 5. Elementos facilitadores na dimensão de adoção do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Motivação para capacitação e cuidado	Motivação intrínseca para capacitação	“Eu gostei muito! Havia muitas novidades...” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Colaboração intraequipe	Integração da equipe	“Integração das equipes com todo mundo falando a mesma língua...” (Médica - Participante 5)
Caso 1	Colaboração multiprofissional/intersetorial	Parcerias intersetoriais	“Com a ajuda do NASF... ‘amarra’ as coisas direitinho... pra atender melhor os usuários...” (ACS - Participante 7)
Caso 1	Colaboração multiprofissional/intersetorial	Parcerias intersetoriais	“Trabalho junto com o CRAS... parceria com o Mãe Coruja para tentar dar conta das demandas...” (Fonoaudióloga - Participante 8)
Caso 1	Adoção na rotina da unidade	Práticas na rotina	“É uma unidade organizada... as agentes de saúde sempre fazem a busca ativa...” (Assistente social - Participante 9)

Caso 1	Adoção na rotina da unidade	Práticas na rotina	“Independente do curso... a unidade... junto com o Mãe Coruja... desenvolve ações.” (Enfermeira - Participante 10)
Caso 2	Motivação para capacitação e cuidado	Motivação intrínseca	“É sempre bom a gente estar se capacitando... É enriquecedor pra gente...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Motivação para capacitação e cuidado	Motivação intrínseca	“Mesmo com dificuldade, eu tenho orgulho de ser ACS...” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Motivação para capacitação e cuidado	Motivação intrínseca	“Tudo é um ensinamento a mais pra mim... Até pra nosso currículo...” (ACS - Participante 14)
Caso 2	Motivação para capacitação e cuidado	Motivação intrínseca	“Lidar com criança é uma responsabilidade muito grande... precisamos aprender sempre” (Enfermeira - Participante 15)
Caso 2	Colaboração intraequipe	Integração da equipe	“A gente se ajuda, a enfermeira orienta e a gente reforça nas visitas.” (ACS - Participante 18)
Gestão	Equipe sensibilizada/proativa	Proatividade de equipes	“Os profissionais já estavam cientes... do que de fato era o UAPI.” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Equipe sensibilizada/proativa	Proatividade de equipes	“Não tivemos dificuldades... as equipes são bem proativas.” (Gestão Caso 1 - Participante 3)

5.3.6 ELEMENTOS DE BARREIRA NA DIMENSÃO DE ADOÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão adoção, a principal barreira identificada no Caso 1 foi a sobrecarga de atividades e a sensação de obrigatoriedade associada à participação nos módulos de capacitação da UAPI. Embora os profissionais reconheçam a importância dos conteúdos, parte deles relatou dificuldade em conciliar a rotina de trabalho com as demandas formativas, o que resultou em adesão limitada e menor engajamento nos momentos de estudo coletivo. Essa percepção de “convite obrigatório” e de carga horária extensa gerou cansaço e reduziu a motivação em algumas etapas do processo.

No Caso 2, as falas reforçam esse padrão, indicando que a participação no curso ocorreu, em parte, por exigência institucional e não necessariamente por interesse espontâneo. Alguns profissionais destacaram que buscaram a certificação apenas para atender a requisitos formais, sem envolvimento direto nas discussões propostas. Já na Gestão, foram mencionadas duas barreiras principais: a adoção não homogênea entre as equipes e a resistência inicial ao modelo de gestão por resultados, especialmente pela sensação de maior cobrança e monitoramento.

Quadro 6. Elementos de barreira na dimensão de adoção do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Adesão por obrigação/baixa motivação	Engajamento limitado/obrigatoriedade	“Convite meio que obrigatório... achei a carga horária extensa...” (Enfermeira - Participante 10)
Caso 2	Adesão por obrigação/baixa motivação	Engajamento limitado/obrigatoriedade	“Chegou para a gente que todos tinham que fazer o curso...” (ACS - Participante 17)

Caso 2	Adesão por obrigação/baixa motivação	Engajamento limitado/obrigatoriedade	“Tem gente que só fez o curso por obrigação, não se engajou.” (ACS-Participante 18)
Caso 2	Adesão por obrigação/baixa motivação	Engajamento limitado/obrigatoriedade	“Vou ser bem sincera, fiz o curso pra ganhar o certificado...” (ACS - Participante 13)
Gestão	Adoção não homogênea entre equipes	Heterogeneidade de adesão	“Não foi homogênea... às vezes era uma adesão mais da equipe de gestão, ou de uma equipe da unidade..” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Resistência inicial/gestão por resultados	Resistência ao modelo de gestão por resultados	“...aquela coisa do novo... monitoramento tão próximo...” (Gestão - Participante 2)

5.3.7 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão implementação, os profissionais reconheceram a articulação entre os conhecimentos adquiridos na iniciativa UAPI e a prática cotidiana nos serviços. No Caso 1, a incorporação dos conteúdos ocorreu de forma direta no atendimento às famílias, com aplicação dos aprendizados nas consultas e visitas domiciliares. Essa integração entre teoria e prática demonstrou que a iniciativa conseguiu influenciar rotinas assistenciais, aproximando as ações educativas do cuidado real no território.

No Caso 2, a implementação esteve relacionada à educação permanente, destacando o papel das reuniões de equipe como espaço de troca e atualização. O uso de ferramentas como o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e listas de acompanhamento para busca ativa também se mostrou um diferencial, facilitando o monitoramento das crianças e a organização das ações.

Para a Gestão, a implementação foi marcada pela promoção da cultura do registro, pelo desenvolvimento de painéis de indicadores online e pela oferta de assistência técnica contínua

às equipes. Foram ainda mencionadas estratégias de gestão de dados por meio de planilhas territoriais, realização de reuniões mensais de rotina e investimentos em formação de tutores e aquisição de materiais, configurando uma estrutura gerencial voltada à sustentabilidade da iniciativa e à consolidação de um modelo de governança local.

Quadro 7. Elementos facilitadores na dimensão de implementação do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Implementação na rotina	Aplicação cotidiana no atendimento	“A prática diária mesmo, porque assimilávamos e aplicávamos no atendimento o que viamos no curso...” (Médica - Participante 5)
Caso 2	Educação permanente com ACS	Educação permanente	“...discutindo durante as reuniões de equipe, fazendo educação permanente...” (Enfermeira - Participante 15)
Caso 2	Uso de PEC/listas para busca ativa	Uso de sistemas e dados	“...utilizar as ferramentas do PEC, ver lista de crianças com vacina atrasada...” (Enfermeira - Participante 15)
Gestão	Cultura do registro/gestão por resultados	Cultura do registro	“A UAPI ajudou a criar uma cultura do registro... registrar tudo o que eles fazem” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Painel de indicadores (online)	Ferramentas de monitoramento	“...contratou uma equipe para desenhar um painel online. E assim termos mais informações, mais robustas...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Metodologia e assistência técnica	Suporte metodológico e técnico	“Disponibilizamos a metodologia, os cursos, a assistência técnica...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Planilhas territoriais como suporte	Gestão local de dados	“Eu tinha acesso a planilhas do território...” (Gestão Caso 1 - Participante 3)

Gestão	Planilhas territoriais como suporte	Gestão local de dados	“...criar planilhas para garantir uma certificação mais confiável.” (Gestão Caso 1- Participante 3)
Gestão	Reuniões fixas (fluxo mensal)	Governança de rotina	“Temos um fluxo de reuniões na unidade, geralmente na primeira semana do mês...” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Licitação de materiais/ formação de tutores	Investimento em insumos e formação	“Estamos em plena fase de licitação... 2 profissionais... rede de desenvolvimento...” (Gestão - Participante 2)

5.3.8 ELEMENTOS DE BARREIRA NA DIMENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão implementação, os profissionais do Caso 1 relataram dificuldades para inserir integralmente as ações da UAPI na rotina de trabalho, apontando limitações de tempo, excesso de demandas e descontinuidades das atividades após o período inicial da iniciativa. Também foram citadas barreiras relacionadas à infraestrutura, como falta de salas adequadas, equipamentos danificados e insuficiência de insumos básicos. A sobrecarga das equipes e a ausência de atualizações ou novas formações contribuíram para a redução do ritmo das ações. Além disso, houve menções a falhas nos sistemas de informação da Atenção Primária, com inconsistências no PEC e dificuldades de comunicação com a gestão, o que dificultou o monitoramento e o registro adequado das atividades realizadas.

No Caso 2, as barreiras estavam relacionadas à falta de materiais educativos, à necessidade de custeio pessoal de ações e às condições precárias dos espaços físicos. Os profissionais destacaram a ausência de apoio multiprofissional e a fragilidade na integração entre as áreas, o que limitou a execução de ações conjuntas. Também relataram que o curso da UAPI, embora reconhecido como relevante, foi percebido como distante da realidade do território, por apresentar situações consideradas “utópicas” frente às condições locais.

Na Gestão, foram apontadas dificuldades relacionadas à sobrecarga das equipes após a pandemia, inconsistências no sistema de informação, listagens desatualizadas e lacunas de

registro das atividades. As diferenças entre territórios e a desigualdade na distribuição de recursos também foram citadas, evidenciando desafios para manter a equidade e a padronização da implementação nos diferentes contextos da rede.

Quadro 8. Elementos de barreira na dimensão de implementação do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Implementação limitada	Inserção parcial das ações	“Não houve mudança no nosso trabalho por conta de não conseguir colocar na prática diária, falta de tempo, por exemplo... UAPI.” (Enfermeira - Participante 6)
Caso 1	Implementação limitada	Descontinuidade das ações	“Não tivemos... uma reciclagem... Não teve uma continuidade.” (Fonoaudióloga - Participante 8)
Caso 1	Excesso de demanda/queda de acompanhamento	Sobrecarga e tempo insuficiente	“É muito cadastro para fazer e N coisas...” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Excesso de demanda/queda de acompanhamento	Sobrecarga e tempo insuficiente	“Hoje em dia... não consegue fazer essas coisas todas.” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Falta de espaço/tempo para curso	Falta de tempo/condições para formação	“Não tem espaço para fazer dentro da unidade... fora daqui, é complicado... demanda mais tempo de todos nós..” (Enfermeira - Participante 6)

Caso 1	Deficiência estrutural (balança/salas/auditório)	Infraestrutura e insumos insuficientes	“Estamos com a balança quebrada... faz muito tempo...” (Médica - Participante 5)
Caso 1	Deficiência estrutural (balança/salas/auditório)	Infraestrutura e insumos insuficientes	“Auditório vai ser reduzido... Como é que o Mãe Coruja vai trabalhar...?” (Assistente social - Participante 9)
Caso 1	Curso pouco acessível/burocrático (plataforma/login)	Acesso difícil à plataforma de curso	“Tive que fazer outro login... tive que começar do zero.” (Enfermeira - Participante 6)
Caso 1	Curso pouco acessível/burocrático (plataforma/login)	Acesso difícil à plataforma de curso	“Não foi acessível... muita burocracia...” (Enfermeira - Participante 6)
Caso 1	Curso pouco acessível/burocrático (plataforma/login)	Acesso difícil à plataforma de curso	“Tive um pouco de dificuldade com o acesso à informática, mas depois a enfermeira nos ajudou.” (ACS - Participante 4)
Caso 1	Comunicação/gestão deficiente (PEC/e-SUS/verticalização/sem devolutiva)	Gestão e sistemas de informação problemáticos	“Bota no tablet, não vai para o computador... os dados não vão...” (ACS - Participante 7)
Caso 1	Comunicação/gestão deficiente (PEC/e-SUS/verticalização/sem devolutiva)	Gestão e sistemas de informação problemáticos	“PEC... uma grande incógnita... várias inconsistências.” (Enfermeira - Participante 10)
Caso 1	Comunicação/gestão deficiente (PEC/e-SUS/verticalização/sem devolutiva)	Gestão e sistemas de informação problemáticos	“A gestão é muito verticalizada. A gente não tem... participação.” (Enfermeira - Participante 10)

Caso 2	Falta de material educativo	Materiais didáticos insuficientes	“Disseram que esse material iria chegar... mas nenhum chegou.” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Falta de material educativo (panfletos)	Materiais didáticos insuficientes	“Eu acho que o que falta mais para a gente são panfletos mesmo...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Ações custeadas pelos ACS	Custeio pessoal das ações	“Às vezes sim, às vezes não, isso geralmente é mais a nosso bolso mesmo...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Deficiência de recursos físicos/insumos	Infraestrutura e insumos insuficientes	“...nosso estadiômetro está quebrado, a balança a gente reveza, é difícil trabalhar dessa maneira” (Enfermeira - Participante 15)
Caso 2	Falta de espaço físico	Espaço físico inadequado	“Aqui não tem espaço pra juntar as mães, não conseguimos fazer reunião...” (ACS - Participante 17)
Caso 2	Falta de espaço físico	Espaço físico inadequado	“...unidade abarrotada de gente... todos os dias é assim, e com o espaço muito pequeno, só piora” (ACS - Participante 13)
Caso 2	Deficiência de recursos físicos/insumos	Infraestrutura e insumos insuficientes	“...a gente não tem consultório nem maca para atender... vamos organizando da maneira que dá...” (Enfermeira - Participante 15)

Caso 2	Deficiência de recursos físicos/insumos	Infraestrutura e insumos insuficientes	“Não vem mais os kits. Faz mais de dois anos que não vem o kit para darmos escova de dente e creme dental para as crianças... não temos como conversar sobre isso, sem mostrar para as criança, e eles levarem alguma coisa pra casa” (ACS - Participante 12)
Caso 2	Falta de apoio multiprofissional/integração	Integração multiprofissional frágil	“A gente não tem esse tipo de profissional que dê esse apoio... para ajudar, pensar em coisas novas...” (ACS - Participante 13)
Caso 2	Falta de apoio multiprofissional/integração	Integração multiprofissional frágil	“Não existe aquela coisa da equipe toda com as mães... por que não conseguimos dar conta, são muitas demandas...” (ACS - Participante 13)
Caso 2	Curso distante/utópico da realidade	Desalinhamento curso–realidade	“É um curso muito bom, mas não é usado na nossa realidade.” (ACS - Participante 13)
Caso 2	Curso distante/utópico da realidade	Desalinhamento curso–realidade	“O que mostram nos vídeos é muito bonito, mas não é a realidade daqui.” (ACS - Participante 18)
Caso 2	Curso distante/utópico da realidade	Desalinhamento curso–realidade	“O curso dá a sensação de algo mágico, como o mundo de Alice... utópico.” (ACS - Participante 16)
Caso 2	Comunicação/gestão deficiente (sem diálogo)	Gestão e comunicação frágeis	“Mudaram de dia e de horário sem comunicar... falta água... sistema cai.” (ACS - Participante 12)

Caso 2	Comunicação/gestão deficiente (sem diálogo)	Gestão comunicação frágeis e	“Não é uma coisa construída junto, precisa ter diálogo da gestão com os profissionais...” (ACS - Participante 12)
Gestão	Metodologia e assistência técnica	Suporte metodológico e técnico	“Disponibilizamos a metodologia, os cursos, a assistência técnica...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Planilhas territoriais como suporte	Gestão local de dados	“Eu tinha acesso a planilhas do território...” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Planilhas territoriais como suporte	Gestão local de dados	“...criar planilhas para garantir uma certificação mais confiável.” (Gestão Caso 1- Participante 3)
Gestão	Reuniões fixas (fluxo mensal)	Governança de rotina	“Temos um fluxo de reuniões na unidade, geralmente na primeira semana do mês algumas vezes é difícil reunir, mas vamos tentando...” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Facilitadores da casa no território	Facilitadores locais	“Todos os facilitadores foram facilitadores da casa e no território...” (Gestão - Participante 2)
Gestão	Sobrecarga pós-pandemia nas equipes	Sobrecarga de trabalho	“...sobrecarga para os profissionais que o período pandêmico trouxe...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Lacuna de registro	Falhas de registro	“...acompanhavam... mas isso não estava no registro.” (Gestão - Participante 1)

Gestão	Diferenças entre territórios (equidade)	Equidade territorial	“De um território para outro há diferenças. É preciso trabalhar... equidade.” (Gestão- Participante 1)
Gestão	Inconsistências do PEC	Inconsistências sistêmicas (PEC)	“...não aparecia no PEC naquele momento.” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Listagens desatualizadas	Dados cadastrais desatualizados	“A listagem de crianças e famílias... frequentemente estava desatualizada.” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Lacuna de registro	Falhas de registro	“...a tarefa é feita, mas... não é registrada corretamente...” (Gestão - Participante 2)

5.3.9 ELEMENTOS FACILITADORES NA DIMENSÃO DE MANUTENÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO

Na dimensão manutenção, observou-se que, no Caso 1, coexistem estratégias de sustentabilidade baseadas na educação permanente, no uso de materiais educativos e na existência de protocolos e roteiros práticos que orientam a continuidade das ações. Os profissionais mencionaram o desejo de formações contínuas e presenciais, destacando que o formato híbrido, com momentos de troca direta, favorece o engajamento e a atualização contínua sobre o desenvolvimento infantil. A presença de instrumentos como manuais e cronogramas foi citada como facilitadora da rotina, auxiliando na padronização e no registro das atividades.

No Caso 2, a manutenção das práticas esteve associada principalmente ao trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, que mantêm a temática da primeira infância ativa nas visitas domiciliares, reforçando orientações sobre alimentação, vacinação e estímulos precoces. As falas evidenciam que as visitas atuam como um elo constante entre a capacitação e a prática,

garantindo a permanência de parte das ações mesmo diante de limitações estruturais e operacionais.

Na gestão, destacaram-se iniciativas voltadas à sustentabilidade institucional da UAPI, expressas na realização de formações periódicas, na articulação com o governo federal e indicadores do Ministério da Saúde, e na defesa da transformação da iniciativa em política de Estado. Também foram mencionadas estratégias de devolutivas e escuta protegida entre as equipes, reconhecidas como mecanismos de engajamento e retroalimentação das ações ao longo dos ciclos da UAPI.

Quadro 9. Elementos facilitadores na dimensão de manutenção do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Educação continuada/atualizações	Educação permanente	“Seria bom ter um instrutor diário...” (Médica - Participante 5)
Caso 1	Educação continuada/atualizações	Educação permanente	“Por outros cursos ofertados... às vezes ficava muita coisa e pouco tempo” (Enfermeira - Participante 10)
Caso 1	Manual/cronograma claro	Protocolos e roteiros práticos	“Um... manualzinho que a gente sabe folhear... sobre cuidados e atenção com as crianças...” (ACS - Participante 7)
Caso 1	Curso com parte presencial	Modalidade presencial/híbrida como incentivo	“Se tivesse sido... totalmente presencial... talvez engaje melhor.” (Enfermeira - Participante 6)

Caso 1	Educação continuada/atualizações	Educação permanente	“Precisava mais capacitações... avaliação de desenvolvimento infantil.” (Fonoaudióloga - Participante 8)
Caso 1	Materiais educativos necessários	Materiais didáticos e recursos	“Seria interessante... material informativo... para dar na sala de espera...” (ACS - Participante 4)
Caso 2	Continuidade visitas/ACS via	Sustentação visitas/rotina via	“A gente continuou nas visitas perguntando sobre amamentação...” (ACS - Participante 11)
Caso 2	Continuidade visitas/ACS via	Sustentação visitas/rotina via	“Mesmo sem apoio, a gente mantém nas visitas as orientações.” (ACS - Participante 16)
Caso 2	Continuidade visitas/ACS via	Sustentação visitas/rotina via	“...acho que continua, geralmente a gente sempre na visita a gente pergunta... sobre as vacinas, se o bebê está mamando...” (ACS - Participante 11)
Gestão	Formações focalizadas e recorrentes	Educação continuada	“...em cada ciclo, trouxe duas ou três formações e capacitações... para melhorar e aumentar a adesão...” (Gestão - Participante 1)

Gestão	Sustentabilidade institucional (3º ciclo/política de Estado/indicadores MS)	Institucionalização/Política de Estado	“Agora, no terceiro ciclo, estamos trabalhando... com o governo federal.” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Sustentabilidade institucional (3º ciclo/política de Estado/indicadores MS)	Institucionalização/Política de Estado	“Queremos... uma política de estado, não de governo.” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Devolutivas/feedback para engajar	Feedbacks e devolutivas	“Eles sempre perguntam: ‘E aí, como foi o resultado?’” (Gestão Caso 1 - Participante 3)
Gestão	Escuta protegida/trocas entre equipes	Escuta/rodas de troca	“Também foi um momento de escuta, mesmo, uma escuta protegida... estar perto dos profissionais...” (Gestão - Participante 2)
Gestão	Sustentabilidade institucional (3º ciclo/política de Estado/indicadores MS)	Institucionalização/Política de Estado	“...pegando carona... nesses novos indicadores... esse é o caminho.” (Gestão- Participante 2)

5.3.10 ELEMENTOS DE BARREIRAS NA DIMENSÃO DE MANUTENÇÃO DO CASO 1, CASO 2 E GESTÃO.

Na dimensão manutenção, o Caso 1 apresentou barreiras relacionadas à ausência de monitoramento e de apoio continuado após a capacitação. Os profissionais relataram falta de acompanhamento das atividades propostas e de suporte técnico para a realização dos cursos, o que contribuiu para a interrupção do processo formativo. Também foi citada a escassez de materiais e recursos básicos para o desenvolvimento das ações, dificultando a reprodução das atividades educativas e a consolidação das práticas da UAPI na rotina da unidade.

No Caso 2, as barreiras estiveram relacionadas à descontinuidade das ações após a capacitação, à dificuldade de manter cronogramas regulares e à ausência de apoio para a execução das atividades no território. Os profissionais relataram que, embora o curso tenha sido concluído, não houve acompanhamento posterior nem condições estruturais adequadas para garantir a continuidade.

Na Gestão, foram destacadas limitações relacionadas ao curto tempo de duração dos ciclos de implementação, considerado insuficiente para produzir impacto consolidado nas práticas, e à carência de materiais didáticos específicos do programa. A oscilação no monitoramento e o ritmo acelerado das etapas foram apontados como fatores que dificultaram a sustentação das ações e o fortalecimento institucional da iniciativa ao longo do tempo.

Quadro 10. Elementos de barreira na dimensão de manutenção do Caso 1, Caso 2 e Gestão.

Caso	Código	Tema emergente	Trecho da entrevista
Caso 1	Falta de monitoramento/apoio para curso	Ausência de monitoramento e suporte	“Não tivemos um monitoramento posterior...” (Médica - Participante 5)
Caso 1	Falta de monitoramento/apoio para curso	Ausência de monitoramento e suporte	“Não houve... apoio para se fazer o curso... uma parte dos participantes precisava de ajuda para acessar o sistema...” (Enfermeira - Participante 10)
Caso 1	Falta de materiais/recursos	Materiais didáticos e recursos escassos	“Queríamos... tinta para pintar, e a gente não teve... mais recursos para ações...” (Fonoaudióloga - Participante 8)

Caso 2	Descontinuidade das ações	Descontinuidade pós-capacitação	“No começo até teve muito movimento, mas depois foi diminuindo... parece que se perde o que eu se aprendeu” (ACS - Participante 16)
Caso 2	Falta de continuidade/monitoramento pós-capacitações	Ausência de monitoramento	“A gente fez o curso, mas depois não teve mais acompanhamento.” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Dificuldade de manter cronogramas	Planejamento vs execução	“...às vezes fazemos cronograma, mas não conseguimos seguir... por que sempre aparecem mais demandas de trabalho...” (ACS - Participante 18)
Caso 2	Falta de apoio para manutenção	Insuficiência de suporte	“Mostraram o que tinha que fazer, mas não deram condições.” (ACS - Participante 19)
Caso 2	Falta de continuidade/monitoramento pós-capacitações	Ausência de monitoramento	“Não teve mais acompanhamento após o curso.” (ACS - Participante 19)
Gestão	Tempo/ciclo curto para impacto	Ciclo curto/tempo insuficiente	“...foi muito rápido. Não dá para impactar em um ciclo tão curto...” (Gestão - Participante 1)
Gestão	Materiais didáticos insuficientes	Materiais didáticos escassos	“Recebemos alguns materiais... mas do programa...” (Gestão - Participante 3)
Gestão	Tempo/ciclo curto para impacto	Ciclo curto/tempo insuficiente	“Foi contar números, né?... tem que ir avaliando a cada ano para acompanhar os progressos...” (Gestão - Participante 2)

Gestão	Falta de monitoramento pós-capacitações	Monitoramento oscilante	“...mas aí não vai pra frente, é preciso o acompanhamento, monitorar...” (Gestão - Participante 2)
--------	---	-------------------------	--

5.4 COMPARAÇÃO DE ELEMENTOS ENTRE OS CASOS 1, 2 E GESTÃO

O quadro 12 sintetiza 142 ocorrências codificadas nos três conjuntos analisados (Caso 1, Caso 2 e Gestão). Em termos agregados, há ligeira predominância de barreiras (74) sobre facilitadores (68), o que indica que a iniciativa alcançou impulso no território, embora a ainda encontre entraves operacionais e contextuais que dificultam a materialização de seu potencial máximo.

Quadro 11. Facilitadores e barreiras por dimensão (Casos 1, 2 e Gestão).

Dimensão	Facilitadores			Barreiras			Total Facilitadores	Total Barreiras	Total de ocorrências
	C1	C2	Gestão	C1	C2	Gestão			
Alcance	5	6	6	1	5	0	17	6	23
Efetividade	5	6	3	6	4	1	14	11	25
Adoção	6	5	2	1	3	2	13	6	19
Implementação	1	2	6	13	15	11	9	39	48
Manutenção	6	3	6	3	5	4	15	12	27
TOTAL	23	22	23	24	32	18	68	74	142

Fonte: a autora

A leitura integrada dos achados apresenta tendências gerais; no entanto, considerando que cada dimensão contempla aspectos distintos do processo de implementação, torna-se necessário examinar separadamente a relação entre facilitadores e barreiras. No presente estudo,

observa-se que, de modo geral, os facilitadores se sobrepõem às barreiras no conjunto das dimensões analisadas. A seguir, apresenta-se a análise comparativa por dimensão, destacando a proporção entre ocorrências e os padrões que emergem no contexto estudado.:

A dimensão Alcance apresentou o maior volume de facilitadores do estudo (17), superando de forma consistente as barreiras identificadas (6). Essa relação sugere que a iniciativa teve condições para estabelecer contato com as famílias e garantir que as ações chegassem ao público-alvo. As práticas de visita domiciliar, busca ativa de gestantes e crianças e ações educativas foram componentes centrais desse processo, integradas à rotina das equipes e articuladas com a lógica da territorialização na APS. A atuação dos ACS constitui-se como responsável dessa aproximação, pela presença contínua no território e pelo vínculo já estabelecido com as famílias.

Apesar do predomínio de fatores favoráveis, as barreiras identificadas apresentam pontos que limitam a amplitude e a uniformidade do alcance. A baixa participação das famílias em atividades coletivas diminui a possibilidade de diversificar estratégias de aproximação e concentra grande parte das interações nas visitas individuais. Essas barreiras atuam sobre pontos específicos que podem restringir a abrangência das ações, sobretudo quando a participação comunitária é baixa ou quando fatores externos. Nesse contexto, a redução desses entraves depende do fortalecimento de estratégias já presentes na rotina das equipes — como ampliar espaços coletivos, aprimorar a comunicação entre serviços e famílias e qualificar a circulação de informações no território — de modo a sustentar o predomínio dos facilitadores observados e ampliar o alcance da iniciativa nos diferentes contextos.

A dimensão Efetividade apresentou uma relação próxima entre facilitadores (14) e barreiras (11), o que indica um equilíbrio entre avanços e limitações. A pequena diferença numérica demonstra que, embora haja elementos que favoreçam a produção de resultados — como melhorias percebidas no cuidado, atualizações técnicas e práticas existentes — esses ganhos não se distanciam significativamente dos fatores que os tensionam, apresentando uma dimensão mais vulnerável às condições do território e aos comportamentos das famílias, especialmente no que se refere à adesão às orientações, à continuidade das práticas recomendadas e à influência de informações externas que interferem nas decisões de cuidado.

Na perspectiva comparativa, o conjunto de barreiras exerce peso considerável sobre a efetividade, reduzindo a estabilidade dos resultados observados. A resistência familiar, a

influência de informações externas e as condições sociais adversas atuam de uma forma competitiva com os facilitadores, limitando a consolidação dos efeitos positivos. Assim, a efetividade se configura como uma dimensão em que os resultados existem, mas permanecem sensíveis a entraves, o que torna sua sustentação dependente da capacidade das equipes de reduzir essas interferências.

A dimensão Adoção apresentou uma distribuição amplamente favorável aos facilitadores, com 13 ocorrências e 6 barreiras, configurando a menor proporção de entraves entre todas as dimensões analisadas. Essa diferença indica que, no processo de incorporação das ações ao cotidiano das equipes, predomina uma postura favorável ao modelo, marcada por motivação para capacitação, engajamento individual, integração entre profissionais e articulações multiprofissionais e intersetoriais. A presença recorrente de relatos sobre interesse dos trabalhadores, colaboração interna e inserção das ações na rotina das unidades demonstra que as equipes buscam construir e manter condições organizacionais e relacionais que favorecem a adoção das práticas propostas pela iniciativa.

Apesar desse conjunto expressivo de facilitadores, as 6 barreiras identificadas chamam atenção por evidenciar tensões no processo de adoção, ainda que em menor número relativo. Entre elas, destaca-se a percepção de obrigatoriedade e a sobrecarga associada à participação nas capacitações, que geraram engajamento parcial, principalmente quando as atividades formativas foram percebidas como extensas ou impostas institucionalmente. Além disso, surgiram limitações relacionadas à heterogeneidade de adesão entre equipes e à resistência inicial ao modelo de gestão por resultados, fatores que, mesmo pouco frequentes, apontam que a adoção não ocorreu de forma completamente homogênea no conjunto das unidades.

A análise comparativa entre facilitadores e barreiras mostra que, embora existam entraves pontuais, o resultado da dimensão Adoção é amplamente positivo, indicando maior estabilidade na incorporação das ações em comparação às demais dimensões do RE-AIM. A predominância clara de elementos favoráveis sugere que a adoção depende menos de mudanças estruturais e mais da continuidade de práticas já presentes nos serviços, como colaboração cotidiana, motivação das equipes e articulação com atores externos. Nesse sentido, a redução das barreiras observadas pode estar associada ao oferecimento de processos formativos e ao alinhamento das orientações institucionais, favorecendo que as condições positivas predominantes se consolidem de forma mais homogênea e contínua no processo de adoção.

A dimensão Implementação apresentou o cenário menos favorável entre todas as dimensões do RE-AIM, com 9 facilitadores e 39 barreiras, configurando a proporção mais desigual identificada no estudo. Essa distribuição indica que, os mecanismos que sustentam a execução cotidiana da iniciativa são superados por fatores que dificultam sua operacionalização. A distância numérica entre os dois grupos sugere que a implementação é o ponto do processo mais sensível às condições estruturais, organizacionais e de gestão presentes no território.

Embora em menor número, os facilitadores revelam elementos importantes, sobretudo relacionados ao uso de ferramentas de monitoramento, à institucionalização de práticas de registro, ao apoio metodológico da gestão e à presença de rotinas como reuniões mensais e processos de educação permanente. Isso demonstra que existem algumas condições favoráveis que permitem avançar na implementação, especialmente quando há suporte técnico e governança local. No entanto, a escala reduzida desses facilitadores, diante do volume de barreiras, evidencia que sua capacidade de influenciar o desempenho da dimensão é limitada.

As barreiras concentram fatores estruturais e organizacionais, como sobrecarga assistencial, ausência de tempo protegido, insuficiência de espaços físicos, falta de insumos básicos, obsolescência de equipamentos, indisponibilidade de materiais educativos e deficiências em sistemas de informação. Esses fatores, presentes de forma reiterada tanto no Caso 1 quanto no Caso 2, mostram que as equipes operam em condições que inviabilizam a incorporação plena das ações previstas, mesmo quando existe interesse em executar as atividades.

A capacitação é percebida como distante do cotidiano ou difícil de acessar, seu potencial para a implementação diminui, criando uma lacuna entre o que é proposto pela iniciativa e o que é possível realizar na prática. Em comparação com os facilitadores revela que, embora haja suporte metodológico, sua efetividade é reduzida pelo acúmulo de obstáculos operacionais. A relação comparativa entre facilitadores e barreiras mostra que a implementação é a dimensão mais sensível reunindo infraestrutura inadequada, sobrecarga, fragilidade dos sistemas de informação e insuficiência de condições materiais para execução das ações.

Diferentemente das outras dimensões, onde os facilitadores exercem maior ou proporcional influência, aqui as barreiras definem o desempenho da dimensão como um todo. Assim, a implementação se configura como o ponto crítico da iniciativa, no qual os avanços

dependem não apenas de aprimoramentos técnicos, mas da reorganização das condições concretas de trabalho que estruturam o cotidiano das unidades.

A dimensão Manutenção apresentou uma proporção equilibrada entre facilitadores e barreiras, com 15 e 12 elementos, respectivamente, configurando um cenário intermediário na capacidade de sustentar as ações da iniciativa ao longo do tempo. Essa proximidade indica que, embora existam condições para continuidade, elas competem diretamente com fatores que limitam a permanência das práticas na rotina das unidades. Assim, diferentemente de dimensões com predomínio de facilitadores, a Manutenção se estrutura sobre um equilíbrio entre avanços e interrupções.

Os facilitadores identificados na dimensão Manutenção apontam para a presença de mecanismos que contribuem para preservar a continuidade das ações quando sustentados por práticas de atualização profissional, disponibilização de materiais orientadores e incorporação das recomendações no cotidiano das equipes, como ocorre nas visitas domiciliares. A existência de formações recorrentes, devolutivas periódicas, espaços de escuta e integração com ciclos institucionais mais amplos demonstra que há esforços organizados para manter a iniciativa ativa ao longo do tempo. Em comparação com outras dimensões, esses elementos funcionam como suportes que diminuem o risco de interrupção das práticas, permitindo que a continuidade seja preservada mesmo quando outras etapas do processo de trabalho enfrentam fragilidades.

As barreiras atingem dimensões distintas do processo de trabalho: planejamento, infraestrutura, gestão do tempo e suporte técnico. A dificuldade de manter cronogramas regulares, a sobreposição de demandas e a insuficiência de recursos físicos compõem um conjunto de entraves que enfraquece a permanência das práticas. Assim, mesmo diante de avanços em educação continuada e institucionalização, a presença simultânea desses obstáculos reduz a capacidade das equipes de manter rotinas organizadas, criando um tensionamento constante entre continuidade e interrupção.

A comparação entre os dois grupos mostra que, ao contrário da Implementação, onde as barreiras predominam amplamente, a Manutenção se caracteriza por um equilíbrio delicado, em que avanços e limitações se contrapõem com magnitudes semelhantes. A consolidação dessa dimensão depende do fortalecimento dos mecanismos de acompanhamento contínuo, garantir suporte técnico e assegurar materiais e recursos para as atividades propostas pelos profissionais. A predominância relativa de facilitadores sugere um potencial de sustentação, no

entanto, as barreiras evidenciam que isso poderá ocorrer quando há continuidade no apoio institucional e condições práticas que permitam às equipes manter o ciclo de ações, e mantendo os benefícios da iniciativa ao longo do tempo.

5.4.1 COMPARAÇÕES DOS CASOS A PARTIR DAS DIMENSÕES DO RE-AIM

5.4.1.1 Dimensão Alcance- Facilitadores

Na dimensão alcance, ambos os casos evidenciaram que a UAPI conseguiu expandir suas ações no território, ainda que por caminhos distintos. O Caso 1, com cinco ocorrências de facilitadores, destacou-se pela organização do trabalho em equipe e colaborativo entre os profissionais e pela sistematização das visitas domiciliares como parte integrante do cuidado oferecido às famílias. As falas indicam que o alcance foi resultado de uma prática estruturada, na qual o conteúdo das capacitações foi incorporado à rotina da unidade:

“Começamos a abordar sobre a leitura, a música, na preparação do bebezinho, ainda na gestação, assim elas podem se sentir mais seguras” (ACS 04).

“A mãe se sentia totalmente acolhida... ela tinha segurança quando a gente fazia a visita, respondemos as perguntas, e tentamos tirar todas as dúvidas” (ACS 04).

Já o Caso 2, com seis facilitadores, apresentou um alcance dependente da iniciativa dos Agentes Comunitários de Saúde. As ações foram baseadas na educação em saúde durante as visitas, na busca ativa e em pequenas ações coletivas.

“Tudo termina mesmo nas nossas visitas. É onde a gente vê a própria realidade, dentro do território, eu acho o momento mais importante” (ACS 13).

“A gente faz convite para as mães, e aí a gente sempre faz lanche... Convidamos para roda de conversa, e também nas comemorações dos meses, como no Agosto Dourado, elas gostam de participar” (ACS 11).

Comparativamente, observa-se que o Caso 1 representa um alcance institucionalizado, articulado e sustentado por uma lógica coletiva de cuidado, na qual a equipe atua de forma integrada e respaldada por parcerias intersetoriais. A presença de estratégias coordenadas e o alinhamento entre gestão e profissionais permitem que as ações cheguem às famílias de forma

sistemática e contínua, refletindo um modelo de implementação mais amadurecido. No Caso 2, por outro lado, o alcance assume um caráter relacional, adaptativo e fortemente dependente do empenho individual dos ACS, que mobilizam recursos próprios e vínculos pessoais para garantir a presença da unidade no território. Trata-se de um alcance mantido pela proximidade cotidiana, mas ainda pouco institucionalizado, o que o torna mais vulnerável a rupturas e descontinuidades.

Para a Gestão, o olhar territorial e a necessidade de reconhecer as especificidades de cada comunidade:

“Um dos pontos que a UAPI traz é: vamos olhar primeiro para o nosso território, o que está acontecendo, quais são os problemas, as potencialidades, o que essas pessoas precisam, assim conseguimos ver a realidade...” (Gestão).

A gestão compreende o alcance como um processo estratégico, sustentado pela integração entre saúde, educação e assistência social. Essa visão amplia o foco das ações, que passam a considerar as condições concretas das famílias e as especificidades de cada território. Diferente dos Casos 1 e 2, que expressam o alcance na prática cotidiana, a gestão atua na articulação intersetorial e no planejamento territorial, buscando garantir coerência e continuidade às ações da UAPI no município.

5.4.1.2 Dimensão Alcance- Barreiras

Na dimensão alcance, as barreiras No Caso 1, a principal limitação foi a baixa adesão da comunidade às ações coletivas, o que restringiu o impacto das estratégias fora do ambiente domiciliar:

“A gente já fez Agosto Dourado e vem pouquíssima gente...Depende do ano, depende se elas foram avisadas muito antes, esquecem, então é preciso que a gente converse sempre, quando está mais próximo da data, para não esquecerem....”

Esse relato demonstra que, mesmo em uma unidade com estrutura organizacional mais consolidada, o envolvimento comunitário permanece frágil, sugerindo a necessidade de reforçar mecanismos de mobilização e de comunicação mais efetivos com as famílias.

No Caso 2, as barreiras foram mais complexas e associadas à fragilidade estrutural e ao distanciamento institucional. As ACS relataram dificuldades de acesso das famílias e falhas na comunicação com a gestão às ações:

“Sendo bem sincera, não tiveram acesso... A gente tenta, mas a unidade não tem como fazer uma sala de espera, sempre é confuso, com muitas pessoas, e pouco espaço... Antes tínhamos um espaço cedido pela igreja, mas hoje não temos mais, e isso impede que a gente consiga fazer um grupo, por exemplo...” (ACS 16).

“A gestão pede que a gente faça atividades, cobra, mas não temos espaço, e quando a gente responde, participa, por exemplo de uma ação, tem um questionário, alguma coisa que a gente precisa saber, pra entender, mas depois não tem retorno” (ACS 17).

Em conjunto, esses resultados mostram que, enquanto o Caso 1 enfrenta entraves ligados à participação e engajamento, o Caso 2 expressa limitações relacionadas à estrutura e ao suporte organizacional, isso evidencia que o alcance efetivo da UAPI requer tanto o fortalecimento das estratégias locais quanto o aprimoramento da articulação entre equipes e gestão.

5.4.1.3 Dimensão Efetividade- Facilitadores

Na dimensão efetividade, os resultados mostram que as ações da UAPI promoveram mudanças perceptíveis tanto nas práticas das equipes quanto nos resultados junto às famílias e crianças, embora com intensidades distintas entre os contextos. No Caso 1, destacam-se os efeitos observados diretamente nas crianças e nas famílias, evidenciando que o conhecimento adquirido nas capacitações foi realizado em ações práticas e sensíveis, de acordo com as falas trazidas:

“Consegui ter um retorno durante e depois, com resultados concretos com as crianças, a gente vê eles se desenvolvendo, com as mães conversando um pouco mais, elas tentam prestar mais atenção nos filhos, é importante para o profissional ter essas capacitações, pra se aprimorar, saber o que vai falar...” (ACS 04).

“Aumentou a sensibilidade em relação à comunicação e interação com a família, com as informações que a gente dá nas visitas também, pra ver se a criança tá se desenvolvendo, que é preciso brincar, conversar, ficar mais perto mesmo...” (ACS 05).

O Caso 2, por sua vez, também apresentou avanços significativos, embora com ênfase em ações educativas e técnicas pontuais, como a promoção do aleitamento materno, o apoio a mães adolescentes e a atualização sobre imunização e desenvolvimento infantil:

“a certificação foi fundamental para atualizar algumas coisas sobre aprendizado, os marcos do desenvolvimento, pois tantas mudanças estão acontecendo e muito rápido, é preciso atualizações para responder às novas demandas dentro dos atendimentos...(ENF Participante 15)”,

Reforçando a continuidade de práticas educativas, mesmo em condições adversas, com orientações sobre amamentação, e que apesar de recursos limitados, o compromisso dos profissionais garantiu a permanência das ações e um cuidado mais qualificado.

“Sobre a amamentação, a gente sempre faz, que é o Agosto Dourado, mesmo tendo ano que as mães não participam muito, mas acho importante ter, pra elas saberem que tem, todos os anos ” (ACS 11)

“A pega correta do bebê no peito... mãe que tem o bico invertido também pode, explicar para elas, nas visitas, nas ações, que elas podem amamentar, informar sobre o assunto, e tentar que a maioria consiga amamentar pelo menos seis meses...” (ACS 19)

“Na visita, eu sempre procuro estimular as mães... evitar as telas, conversar com elas que a criança pode ter problema para aprender a falar, ” (ACS 18)

Para a Gestão, a efetividade foi associada à melhoria progressiva dos indicadores e à consolidação da cultura do registro, aspectos essenciais para monitorar resultados e aprimorar o desempenho das equipes. Um gestor destacou:

“Alcançamos 100% de adesão à vacinação...” (Participante 3), enquanto outro enfatizou que: *“melhoraram seus dados não só porque intensificaram as ações, mas também porque melhoraram o registro” (Participante 1).*

De modo comparativo, o Caso 1 demonstra uma efetividade mais relacional e centrada no vínculo com as famílias, com efeitos diretos no cuidado e na vigilância infantil; o Caso 2 apresenta uma efetividade formativa e técnica, voltada à atualização profissional e à continuidade de ações educativas; enquanto a gestão reflete uma efetividade institucional e mensurável, voltada ao monitoramento e à melhoria de indicadores. Em conjunto, essas

perspectivas indicam que a efetividade da UAPI acontece tanto das transformações nas relações de cuidado quanto da capacidade institucional de sustentar e medir essas mudanças, articulando prática, aprendizado e gestão de resultados no território.

5.4.1.4 Dimensão Efetividade- Barreiras

As barreiras relacionadas à efetividade apresentam desafios que superam a dimensão técnica do cuidado, refletindo aspectos socioculturais, econômicos e comunicacionais presentes nos territórios. Em ambos os contextos, as equipes relataram dificuldades para manter a adesão das famílias às orientações, especialmente sobre o aleitamento materno e o uso racional de informações obtidas nas redes sociais. No primeiro contexto, as falas expressam como a influência da internet interfere nas práticas parentais e fragiliza o vínculo com os profissionais:

“A internet com tantas informações, hoje em dia... sobre leite, fórmula... é uma ou outra mãe que permanece nesse aleitamento direitinho” (ACS 04).

“É muito mais fácil outra pessoa me ajudar dando a mamadeira” (Fonoaudióloga 08); *“Já chegam... pedindo remédio... já com diagnóstico formado”* (ACS 07).

De acordo com as falas dos participantes, a unidade Caso 1 apresenta barreiras ligadas à influência de informações externas e à vulnerabilidade social, enquanto o Caso 2 concentra desafios mais severos de acesso e risco territorial. Já a gestão aponta a necessidade de aprimorar o monitoramento e a qualidade dos registros e modo a transformar o esforço cotidiano das equipes em informações consistentes e fidedignas:

“...precisavam melhorar seus dados não só porque intensificaram as ações, mas também porque melhoraram o registro” (Gestão - Participante 1).

Em conjunto, esses achados demonstram que a efetividade da é condicionada tanto pela realidade social das famílias quanto pela capacidade institucional de apoiar e registrar as práticas de cuidado.

5.4.1.5 Dimensão Adoção- Facilitadores

Na dimensão adoção, os resultados descrevem que a incorporação das ações da UAPI foi favorecida por motivação pessoal e colaboração entre os profissionais, tanto dentro das

equipes quanto com outros setores e programas do território. No Caso 1, as práticas aparecem a partir de uma postura proativa e pela integração multiprofissional. No Caso 2, a motivação aparece de forma genuína, associada ao interesse em aprender e aplicar os novos conteúdos, articulação com outras profissionais expressa na valorização da capacitação e do cuidado.

“Eu gostei muito! Havia muitas novidades” (ACS 04).

“Integração das equipes com todo mundo falando a mesma língua” (Médica 05).

“Com a ajuda da E-Multi ... ‘amarra’ as coisas direitinho” (ACS 07).

“É sempre bom a gente estar se capacitando... é enriquecedor pra gente” (ACS 11).

“Mesmo com dificuldade, eu tenho orgulho de ser ACS” (ACS 19)

“Lidar com criança é uma responsabilidade muito grande” (Enfermeira 15).

A colaboração dentro da equipe também se destacou, fortalecendo o trabalho conjunto e a troca de saberes e que, mesmo em um contexto de menor estrutura e maior sobrecarga, a adoção foi sustentada pelo comprometimento individual e pela solidariedade entre os trabalhadores.

“A gente se ajuda, a enfermeira orienta e a gente reforça nas visitas” (ACS 18).

Sob a ótica da gestão, a adoção foi percebida como resultado da proatividade e do engajamento das equipes, especialmente nas unidades que já haviam participado de ciclos anteriores da UAPI:

“Os profissionais já estavam cientes do que de fato era o UAPI” (Caso 1 - Participante 3).

“Não tivemos dificuldades... as equipes são bem proativas” (Gestão 03). Essas falas indicam que o processo de adoção foi mais fluido quando houve continuidade institucional e clareza sobre os objetivos da iniciativa.

De modo comparativo, o Caso 1 evidencia uma adoção estruturada e interprofissional, sustentada pela cooperação entre equipes e setores; o Caso 2, uma adoção motivada individualmente, marcada pela dedicação pessoal e apoio mútuo entre os ACS; e a gestão, uma adoção mediada por maturidade institucional, fortalecida por experiências anteriores. Nesse contexto, esses resultados mostram que a adoção das ações da UAPI depende tanto da

motivação individual e da cultura colaborativa, quanto da continuidade das estratégias de apoio e reconhecimento institucional que consolidam o compromisso das equipes com a iniciativa.

5.4.1.6 Dimensão Adoção- Barreiras

Na dimensão da adoção, identificaram-se barreiras relacionadas à motivação e ao engajamento dos profissionais. Nos Casos 1 e 2 o engajamento foi descrito como limitado, destacando a adesão motivada pela obrigatoriedade e pela obtenção de certificação, mas não pelo engajamento efetivo na proposta, como nas falas a seguir:

“Convite meio que obrigatório... carga horária extensa...” (Enfermeira, Participante 10).

“Chegou para a gente que todos tinham que fazer o curso...” (ACS, 17)

“Tem gente que só fez o curso por obrigação, não se engajou.” (ACS, 18)

“Vou ser bem sincera, pra ganhar o certificado...” (ACS, 13).

A Gestão apresentou a adoção acontecendo de forma não homogênea entre as equipes, com maior adesão por parte dos setores administrativos e resistência ao modelo de gestão de resultados:

“Não foi homogênea... às vezes era uma adesão mais da equipe de gestão...” (Gestão, Participante 1).

“...aquela coisa do novo... monitoramento tão próximo...” (Gestão, Participante 2).

Ambos os casos enfrentaram desafios semelhantes, com adesão motivada em grande parte por exigências formais e engajamento limitado. Observou-se ainda variação no compromisso entre as equipes, refletindo uma adesão não homogênea. No nível da gestão, identificou-se maior envolvimento dos setores administrativos, embora tenha havido resistência inicial ao modelo de gestão por resultados, refletindo a necessidade de fortalecer o engajamento e padronizar os processos tanto nas equipes operacionais quanto na gestão para garantir a consolidação da iniciativa.

5.4.1.7 Dimensão Implementação- Facilitadores

No Caso 1, a implementação mostrou-se mais internalizada e contínua, com as práticas incorporadas ao atendimento cotidiano, facilitada por uma equipe organizada e comprometida, a profissional destacou:

“A prática diária mesmo, porque assimilávamos e aplicávamos no atendimento” (Médica 05)

“Independente do curso... a unidade, junto com o Mãe Coruja, desenvolve ações” (Enfermeira 10)

No outro caso, a implementação esteve associada principalmente à educação permanente e à gestão da informação, com uso de ferramentas como o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e reuniões:

“Discutindo durante as reuniões de equipe, fazendo educação permanente” (Enfermeira 15))

“Utilizar as ferramentas do PEC, ver lista de crianças com vacina atrasada” (Enfermeira 15).

Sob a perspectiva da gestão, a implementação foi compreendida como um processo institucional e estratégico, voltado ao fortalecimento da governança e à consolidação da cultura de monitoramento. Um gestor destacou:

“A UAPI ajudou a criar uma cultura do registro” (Gestão 01)

“Temos um fluxo de reuniões na unidade, geralmente na primeira semana do mês” (Gestão Caso 1 – Participante 3).

O Caso 1 evidencia uma implementação mais integrada ao cotidiano das práticas, com as ações incorporadas de forma gradual às rotinas da equipe. O Caso 2 apresenta uma implementação em processo de consolidação, apoiada principalmente na educação permanente e na iniciativa dos profissionais para manter o conteúdo formativo em uso. Já a gestão demonstra uma abordagem mais estruturada, voltada à padronização dos registros, ao monitoramento das atividades e à oferta de suporte técnico. Em conjunto, os achados indicam que a efetividade da implementação da UAPI se apoia na articulação entre a prática cotidiana das equipes, o acompanhamento técnico e o papel da gestão em criar condições que favoreçam a continuidade das ações.

5.4.1.8 Dimensão Implementação- Barreiras

A dimensão da implementação apresentou diversos desafios que impactaram a inserção plena das ações previstas pela Iniciativa nos dois casos estudados. Em ambos a sobrecarga de trabalho e o tempo insuficiente foram mencionados como fatores limitantes para o acompanhamento adequado e a execução completa das ações, no Caso 1, foram trazidas as seguintes falas:

“Não houve mudança no nosso trabalho por conta de não conseguir colocar na prática diária, falta de tempo, por exemplo...” (Enfermeira - Participante 6).

“Não tivemos... uma reciclagem... Não teve uma continuidade.” (Fonoaudióloga - Participante 8)

“Estamos com a balança quebrada...” (Médica - Participante 5)

No segundo caso, evidenciaram-se problemas semelhantes, reforçando a fragilidade da infraestrutura, a insuficiência de materiais educativos e a ausência de apoio multiprofissional adequado, o que impactou negativamente a integração das equipes e a qualidade do atendimento oferecido:

“Disseram que esse material iria chegar... mas nenhum chegou.” (ACS - Participante 11)

“É um curso muito bom, mas não é usado na nossa realidade.” (ACS - Participante 13)

“...unidade abarrotada de gente...” (ACS - Participante 13)

A gestão da Iniciativa trouxe desafios ligados à organização e ao suporte técnico necessário para a implementação eficaz das ações:

“...sobrecarga que o período pandêmico trouxe...” (Gestão- Participante 3)

“...a tarefa é feita, mas... não é registrada corretamente...” (Gestão- Participante 2)

As barreiras nos dois casos são a dificuldade de incorporar completamente as ações no cotidiano das equipes, sobrecarga de trabalho e limitações estruturais, como falta de espaço e insumos adequados. Além disso, aspectos relacionados à capacitação e às barreiras tecnológicas dificultam a formação contínua dos profissionais. Na gestão, apesar dos avanços na criação de sistemas de monitoramento e cultura de registro, persistem problemas como sobrecarga, falhas na documentação e desigualdades territoriais.

5.4.1.9 Dimensão Manutenção- Facilitadores

No Caso 1, a manutenção foi associada à educação continuada e à busca por atualização constante. Os profissionais descreveram a necessidade de espaços permanentes de formação, capazes de renovar o conhecimento e fortalecer o compromisso com o desenvolvimento infantil:

“Seria bom ter um instrutor diário...” (MED 05), enquanto uma enfermeira ressaltou: *“Por outros cursos ofertados, há uma participação maior”* (ENF 10).

Essas falas demonstram o reconhecimento da importância da educação permanente como eixo estruturante da sustentabilidade das ações, especialmente quando associada a estratégias de apoio pedagógico e metodologias mais dinâmicas.

Além da capacitação, o uso de materiais e instrumentos de apoio foi percebido como elemento facilitador:

“Um manualzinho que a gente sabe folhear...” (ACS 07).

“Precisava mais capacitações, principalmente sobre avaliação do desenvolvimento infantil” (FONO 08).

Já no Caso 2, essa dimensão se apresenta sobretudo pela ação cotidiana dos agentes comunitários de saúde (ACS), que incorporaram as orientações da UAPI nas visitas domiciliares. Mesmo sem o apoio sistemático da gestão, os profissionais relataram esforço para manter as práticas no território:

“A gente continuou nas visitas perguntando sobre amamentação” (ACS 11)

“Mesmo sem apoio, a gente mantém nas visitas as orientações” (ACS 16)

Essa persistência ilustra uma forma autônoma de sustentabilidade, em que o conhecimento transmitido na capacitação se converte em prática de cuidado integrada ao vínculo com as famílias.

Do ponto de vista da gestão, a manutenção aparece associada à institucionalização da iniciativa, por meio da integração da UAPI em políticas de Estado e ciclos formativos recorrentes:

“Em cada ciclo, trouxemos duas ou três formações e capacitações” (GESTÃO 01)

“Agora, no terceiro ciclo, estamos trabalhando com o governo federal... queremos uma política de Estado, não de governo” (GESTÃO 01).

Em conjunto, esses achados demonstram que a manutenção da UAPI está relacionada à capacidade das equipes de manter o aprendizado vivo nas rotinas, às estratégias de apoio técnico da gestão e à existência de espaços institucionais que favoreçam a aprendizagem contínua. Enquanto a prática dos ACS representa o núcleo da manutenção comunitária, a gestão responde pelo fortalecimento da manutenção institucional, criando condições para que o conhecimento, as metas e os indicadores da iniciativa não se percam ao longo do tempo.

5.4.1.10 Dimensão Manutenção- Barreiras

No Caso 1, os profissionais relataram que o encerramento das formações não foi acompanhado de um processo de supervisão ou devolutiva institucional:

“Não tivemos um monitoramento posterior” (MED 05)

“Não houve apoio para se fazer o curso” (ENF 10).

Outro aspecto recorrente foi o desequilíbrio entre demanda assistencial e tempo disponível para ações educativas que apontam que o excesso de tarefas burocráticas e o acúmulo de funções reduzem o espaço para o trabalho preventivo e comunitário.

“É muito cadastro para fazer e N coisas... Hoje em dia, não consegue fazer essas coisas todas” (ACS 04).

“A gente tenta manter as ações, mas o tempo é muito curto, a demanda é enorme, e falta gente pra dividir o trabalho” (ENF 06).

A descontinuidade das ações foi ainda mais evidente no Caso 2, no qual os profissionais descreveram um movimento inicial de engajamento, seguido por um enfraquecimento progressivo:

“No começo até teve muito movimento, mas depois foi diminuindo” (ACS 16).

“A gente fez o curso, mas depois não teve mais acompanhamento” (ACS 19).

“Às vezes fazemos um cronograma, mas não conseguimos seguir” (ACS 18).

“Mostraram o que tinha que fazer, mas não deram condições” (ACS 19).

Comparativamente, o Caso 1 apresenta uma manutenção fragilizada, mas ainda apoiada em certa estrutura de equipe e experiência institucional prévia, enquanto o Caso 2 expressa um quadro de maior vulnerabilidade operacional, no qual a continuidade depende quase exclusivamente do compromisso individual dos profissionais. A diferença entre os dois contextos está na presença, ainda que limitada, de uma cultura de planejamento no Caso 1, contrastando com a informalidade e a dependência do esforço dos ACS no Caso 2.

Para a Gestão, que por sua vez, reconheceu as limitações temporais e estruturais que comprometem a continuidade da iniciativa, atribuindo parte das dificuldades ao curto tempo dos ciclos e à ausência de planejamento de longo prazo.

“Foi muito rápido. Não dá para impactar em um ciclo tão curto” (GEST 01),

“Tem que ir avaliando a cada ano... senão, acaba se perdendo o que foi construído” (GEST 02).

“É um desafio manter o acompanhamento porque as mesmas pessoas estão em várias frentes” (GEST 01).

A gestão reconhece que a sustentabilidade da UAPI depende da institucionalização de rotinas de monitoramento e da ampliação do tempo de cada ciclo, de forma a permitir que os resultados se consolidem e gerem aprendizados.

5.5 PERCEPÇÕES, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS SOBRE O CICLO DE CAPACITAÇÃO DO CASO 1

O ciclo de capacitação da Iniciativa UAPI no Caso 1 foi reconhecido pelos profissionais como um processo formativo relevante, que estimulou novas formas de olhar para o desenvolvimento infantil e ressignificou o papel da atenção básica no início da vida. As falas revelam entusiasmo e apropriação prática:

“Eu gostei muito! Havia muitas novidades na época. A questão do acolhimento...” (ACS-4).

“Consegui ter um retorno durante e depois, com resultados concretos com as crianças.” (ACS-4).

“É como se tivesse acendido uma sentinela, todos estão alertas...” (Méd-5), indicando que o conteúdo do curso promoveu uma sensibilidade compartilhada entre as equipes.

Os conhecimentos trazidos envolvem comunicação com as famílias, estímulo à leitura e à música na gestação e no puerpério, e fortalecimento de práticas de acolhimento e vínculo. Segundo uma ACS:

“Começamos a abordar sobre a leitura, a música, na preparação do bebezinho...” (ACS-4).

“A mãe se sentia totalmente acolhida... ela tinha segurança quando a gente fazia a visita.” (ACS-4).

“Na vacinação... a gente fica em cima... faz busca ativa.” (ACS-7).

A integração de conhecimentos técnicos e relacionais contribuiu para consolidar uma linguagem comum entre os profissionais:

“Integração das equipes com todo mundo falando a mesma língua.” (Méd-5)

Contudo, os relatos também apontam limitações do processo formativo, como falta de monitoramento e devolutiva após o curso, essas fragilidades reduziram a continuidade do aprendizado e a atualização dos conteúdos:

“A UAPI foi colocada... mas a gente ficou solto. Não tivemos um monitoramento posterior...” (Méd-5),

“Muita burocracia para entrar... tive que fazer outro login...” (Enf-6)

5.5.1 RELAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA INICIATIVA UAPI DO CASO 1.

Os efeitos do ciclo de capacitação na Caso 1, são perceptíveis na implementação das ações da Iniciativa UAPI. A unidade conseguiu incorporar elementos centrais do cuidado à primeira infância, sobretudo nas visitas domiciliares, nas consultas de puericultura e nas atividades de educação em saúde. As práticas cotidianas refletem o conteúdo do curso: a equipe utiliza exemplos práticos nas visitas (demonstração de pega correta, estímulo ao aleitamento e à leitura, incentivo à vacinação), fortalecendo o alcance da iniciativa, e a manutenção das ações:

“A gente veste aquele seio... traz o seio para a mãe ver.” (Fono-8).

“Depois do primeiro ano... os indicadores deram uma melhorada sim.” (Méd-5).

A implementação também foi facilitada por uma forte coesão de equipe e por parcerias intersetoriais com a E-Multi, o CRAS e o Programa Mãe Coruja, que ajudaram a manter o engajamento comunitário mesmo diante de restrições estruturais. Essa integração se traduz em práticas colaborativas e sustentáveis, mitigando lacunas de gestão e carência de insumos. Os profissionais expressam o desejo de continuidade e educação permanente:

“Seria bom ter um instrutor diário... educação continuada dos profissionais.” (Méd-5).

“Tem muitas coisas que a gente ‘engole’, não é nem problema na gestão, é a falta de tempo mesmo.” (ACS-4).

De modo geral, esse Caso demonstra que, quando há alinhamento entre formação, coesão de equipe e apoio intersetorial, o ciclo de capacitação potencializa a implementação da UAPI e gera mudanças observáveis no cuidado, mesmo com desafios de estrutura e de monitoramento.

5.5.2 PERCEPÇÕES, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS SOBRE O CICLO DE CAPACITAÇÃO DO CASO 2

Na Caso 2, as percepções sobre o ciclo de capacitação são mais críticas e revelam um sentimento de distanciamento entre o conteúdo proposto e a realidade cotidiana da atenção básica. Embora alguns profissionais reconheçam aspectos positivos, o discurso predominante aponta frustrações, falta de suporte e pouca adequação contextual:

“Porque nem sempre a teoria acompanha a prática. O curso em si dá uma sensação de algo mágico, como o mundo de Alice... aquilo é utópico para a nossa realidade.” (ACS-16).

“É um conteúdo muito rico, mas... não é usado na nossa realidade... aqui a gente trabalha no limite.” (ACS-13).

Há também críticas ao modo como a capacitação foi organizada e imposta:

“Chegou para a gente que todos tinham que fazer o curso... é difícil, porque você tem seus planos.” (ACS-17).

“Estão discutindo entre eles, já estão vindo com o discurso pronto... não é uma coisa construída junto.” (ACS-12).

Apesar dessas limitações, há evidências de aprendizagem prática. A formação deixou marcas pontuais na rotina, especialmente nas orientações sobre amamentação e vacinação:

“A pega correta do bebê no peito... mãe que tem o bico invertido também pode amamentar.” (ACS-19),

“Na visita, eu sempre procuro estimular as mães... e a evitar as telas.” (ACS-18).

“A gente pega tudinho e traz para a unidade para vacinar. É busca ativa mesmo.” (ACS-12).

5.5.3 RELAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA INICIATIVA UAPI DO CASO 2

A relação entre o ciclo de capacitação e a implementação das ações da UAPI é marcada por descontinuidades e restrições. A apropriação do conteúdo formativo ocorre, mas de modo fragmentado e individualizado, com baixa inserção institucional. As ações coletivas são escassas devido à falta de estrutura física:

“A gente não tem um local para fazer uma palestra sobre amamentação... a unidade é abarrotada de gente.” (ACS-12).

Além das limitações operacionais, os determinantes sociais do território impõem barreiras adicionais: violência, uso de drogas e desestruturação familiar dificultam a adesão das famílias e a sustentabilidade das práticas

“crianças... 12, 13 anos já entrando nas drogas...” (ACS-14).

O esforço cotidiano de repassar orientações nas visitas e manter busca ativa mostra que o conhecimento foi parcialmente incorporado, mas sem gerar mudanças estruturais. Em termos de RE-AIM, o ciclo de capacitação teve baixo alcance (restrito às visitas), adoção parcial (motivação individual) e manutenção frágil (ausência de monitoramento e de condições de trabalho adequadas).

Dessa forma, o Caso 2 revela que, quando a formação não é acompanhada por apoio institucional, materiais, espaços e processos de devolutiva, a implementação tende a se diluir na rotina e a depender do esforço individual de profissionais sobrecarregados. A ausência de coprodução e de políticas de acompanhamento limita a capacidade do ciclo formativo de se traduzir em práticas sustentáveis e visíveis no território.

5.6 ANÁLISE QUANTITATIVA

A dimensão quantitativa da pesquisa foi incorporada ao desenho metodológico com o propósito de complementar a análise qualitativa e detalhar o desempenho das unidades de saúde na implementação da Iniciativa UAPI. Essa etapa permitiu mensurar aspectos objetivos do processo de implementação, especialmente aqueles relacionados à cobertura e ao alcance das ações, bem como observar variações nos indicadores que refletem mudanças nas práticas de cuidado à gestante, à criança e à família. Dessa forma, a análise quantitativa buscou contextualizar como os indicadores priorizados pela Iniciativa UAPI se comportaram ao longo do tempo, oferecendo uma leitura complementar, ampliando a compreensão sobre os avanços e desafios do processo de implementação.

Os dados utilizados foram disponibilizados pela Coordenação da Política de Saúde da Criança do município do Recife, mediante autorização institucional, e correspondem aos

indicadores de monitoramento. Esses indicadores foram trazidos pelas próprias unidades participantes, derivados dos sistemas de informação da Atenção Primária à Saúde e constituem a linha de base para o acompanhamento da iniciativa. A comparação entre os valores observados nas unidades foi feita a partir das médias municipais e dos parâmetros definidos pelo programa, o que permitiu situar cada unidade em relação ao conjunto da rede e identificar padrões de desempenho e variação temporal.

Os dados foram analisados de maneira descritiva, por meio de frequências absolutas e relativas, de modo a caracterizar o comportamento das variáveis em cada quadrimestre e evidenciar o comportamento dos indicadores ao longo do período estudado. Em seguida, foram realizadas duas análises inferenciais: a primeira comparando as proporções observadas entre os Casos 1 e 2 em cada momento avaliado; e a segunda examinando a variação temporal dentro de cada unidade, para verificar tendências e possíveis mudanças de desempenho.

A aplicação de testes de hipóteses para comparação de proporções (Qui-quadrado e Q de Cochran) permitiu verificar se as diferenças observadas apresentavam significância estatística. Adotou-se um nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$), interpretando-se valores de p inferiores a esse limiar como indicativos de diferenças significativas entre grupos ou períodos avaliados. Essa estratégia foi fundamental para subsidiar a análise comparativa entre as unidades, possibilitando uma leitura integrada entre as evidências quantitativas e as percepções qualitativas dos profissionais, fortalecendo a coerência interna do estudo e a interpretação dos resultados da implementação da UAPI.

5.6.1 PROPORÇÃO DE GESTANTES COM 6 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO PERÍODO DE 4 MESES

A tabela 1 e a figura 6 apresentam a evolução temporal do acesso ao pré-natal (≥ 6 consultas em 4 meses) nas USF Caso 1 e Caso 2. Em linha de base, as unidades exibem proporções semelhantes e moderadas (Caso 1: 44,1%; Caso 2: 38,5%). A partir de 2022, as trajetórias divergem e oscilam: no 3º quadrimestre de 2022, a Caso 1 sofre queda (31,1%), enquanto a Caso 2 sobe para 61,3%—diferença estatisticamente significativa ($p=0,009$). Já no 1º quadrimestre de 2023, ocorre o inverso: a Caso 1 salta para 68,4% e a Caso 2 recua para 38,8% ($p=0,028$).

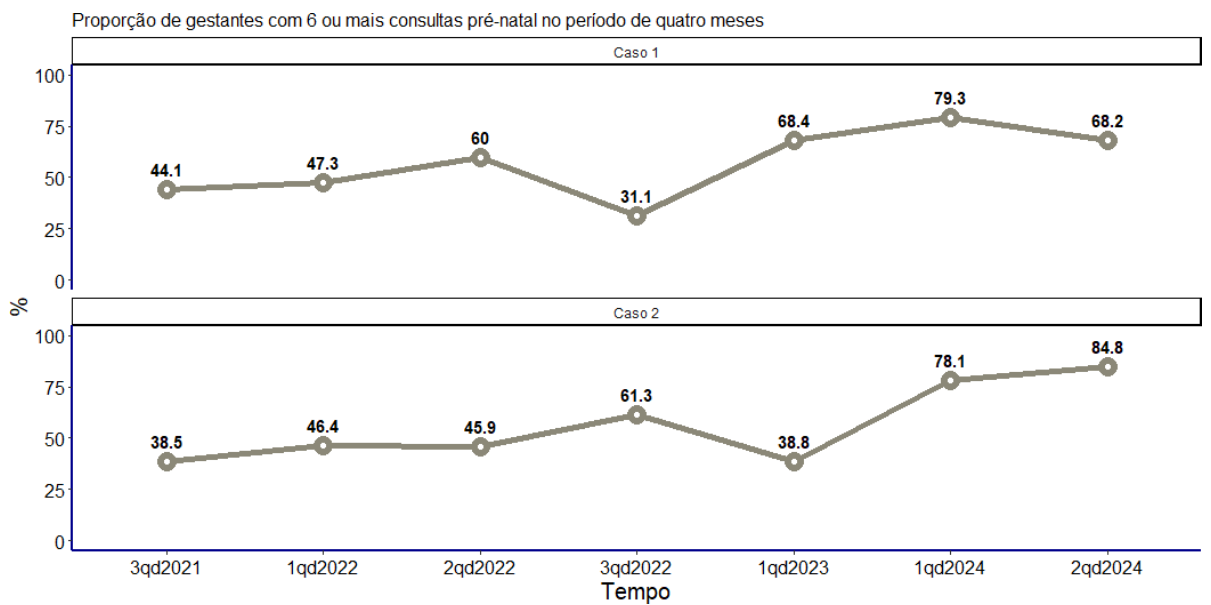
A evolução do indicador apresenta movimentos distintos e complementares entre as duas Unidades de Saúde da Família analisadas. Em linha de base, tanto o Caso 1 (44,1%) quanto

o Caso 2 (38,5%) apresentavam desempenho intermediário e relativamente semelhante, o que reflete o estágio inicial de consolidação das ações preconizadas pela Iniciativa UAPI. A partir de 2022, as trajetórias passam a divergir: o Caso 1 apresenta queda expressiva no terceiro quadrimestre (31,1%), enquanto o Caso 2 alcança um de seus melhores resultados (61,3%), diferença estatisticamente significativa ($p=0,009$). Essa variação sugere que aspectos relacionados à organização do processo de trabalho e à continuidade das ações podem ter influenciado os resultados de curto prazo, com distintos graus de estabilidade entre as unidades.

Tabela 1. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal no período de quatro meses. Recife, 2025.

Unidade	3º quadrimestre 2021	1º quadrimestre 2022	2º quadrimestre 2022	3º quadrimestre 2022	1º quadrimestre 2023	1º quadrimestre 2024	2º quadrimestre 2024	3º quadrimestre 024	P-valor
Caso 1	26/59 (44.1%)	26/55 (47.3%)	21/35 (60.0%)	14/45 (31.1%)	13/19 (68.4%)	23/29 (79.3%)	15/22 (68.2%)	23/31(74.2%)	0.001
Caso 2	20/52 (38.5%)	13/28 (46.4%)	17/37 (45.9%)	19/31 (61.3%)	19/49 (38.8%)	25/32 (78.1%)	28/33 (84.8%)	-	0.001
p-valor	0.550	0.942	0.233	0.009	0.028	0.910	0.143		

Figura 6. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal no período de quatro meses. Recife, 2025.



As narrativas qualitativas ajudam a interpretar essas oscilações. No Caso 1, os relatos de profissionais apontam momentos de reestruturação interna e ajustes de equipe, o que pode ter afetado a regularidade do acompanhamento das gestantes. Já no Caso 2, as falas destacam maior envolvimento da equipe e fortalecimento da busca ativa, aspectos que parecem ter favorecido a ampliação do acesso oportuno às consultas de pré-natal. Nesse aspecto, as condições organizacionais e estratégias de engajamento local se refletem nos padrões observados nos indicadores.

No início de 2023, o comportamento das séries se inverte: o Caso 1 demonstra recuperação expressiva (68,4%), enquanto o Caso 2 apresenta recuo (38,8%). Essa inversão sugere que o indicador é particularmente sensível às variações no cotidiano dos serviços, respondendo a fatores como estabilidade das equipes, gestão de agendas e continuidade das visitas domiciliares. O fortalecimento da integração entre enfermeiros e agentes comunitários, assim como a reorganização do fluxo de atendimento, pode ter contribuído para a melhora gradual do desempenho no Caso 1, ao passo que o aumento das demandas assistenciais pode ter limitado a capacidade de acompanhamento no Caso 2.

Em 2024, observa-se uma tendência de convergência positiva entre as duas unidades. O Caso 1 atinge 79,3% no primeiro quadrimestre e mantém patamares elevados (68,2%–74,2%), enquanto o Caso 2 alcança entre 78,1% e 84,8% nos dois primeiros quadrimestres do mesmo ano ($p < 0,001$ em ambas as séries). Esses resultados sugerem a incorporação gradual das práticas estimuladas pela Iniciativa UAPI, com fortalecimento do acompanhamento longitudinal e da atenção qualificada à gestante.

A leitura integrada dos achados evidencia que, apesar das oscilações, as duas unidades avançaram de forma consistente ao longo do período, com ganhos expressivos em relação à linha de base (+30,1 p.p. no Caso 1 e +46,3 p.p. no Caso 2). De maneira geral, o comportamento do indicador sugere que o fortalecimento institucional e o engajamento das equipes contribuíram para consolidar práticas mais contínuas e sensíveis ao cuidado da gestante.

5.6.2 PROPORÇÃO DE GESTANTES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV

A tabela 2 e a figura 7 apresentam a evolução desse indicador, e mostra melhora gradual nas duas unidades, acompanhada por oscilações expressivas ao longo do período. Partindo de

patamares semelhantes na linha de base — Caso 1: 56,8% e Caso 2: 53,6% —, observa-se crescimento com significância estatística dentro de cada série ($p < 0,001$), alcançando níveis elevados em 2024: 80,0% na Caso 1 e 100,0% na Caso 2. Ainda que o desempenho final aponte para resultados positivos, o percurso até esse estágio foi marcado por variações e momentos de instabilidade, refletindo diferenças na forma como cada equipe organizou e sustentou as práticas de cuidado.

Entre 2022 e 2023, o comportamento do indicador foi irregular. No Caso 1, após atingir 84,2% no primeiro quadrimestre de 2023, observou-se uma queda expressiva no início de 2024 (31,0%), seguida de retomada dos níveis anteriores nos quadrimestres seguintes. No Caso 2, o padrão foi semelhante: crescimento até 93,3% no primeiro quadrimestre de 2023, decréscimo para 42,1% no segundo quadrimestre do mesmo ano e posterior recuperação, alcançando 100% em 2024. Essas flutuações sugerem a influência de fatores operacionais e organizacionais, como disponibilidade de testes, rotina de registro e continuidade das ações de acompanhamento, que se mostraram determinantes para a estabilidade dos resultados.

A comparação entre as unidades apresenta momentos de contraste relevantes. Em 2023, o Caso 1 apresentou desempenho superior no segundo quadrimestre (80,6% vs 42,1%, $p = 0,001$), enquanto no primeiro quadrimestre de 2024 a vantagem passou para o Caso 2 (62,5% vs 31,0%, $p = 0,014$), ampliando-se no período seguinte (100,0% vs 72,7%, $p = 0,001$). Esses movimentos indicam que a consolidação dos processos de testagem pode ter ocorrido de forma desigual, possivelmente associada ao grau de organização interna, à estabilidade das equipes e à regularidade das ações de busca ativa, aspectos recorrentes nos relatos dos profissionais.

De modo geral, o comportamento do indicador reflete o esforço contínuo das equipes em qualificar o cuidado pré-natal e ampliar o acesso aos exames de rotina, especialmente aqueles voltados à prevenção da transmissão vertical de sífilis e HIV. As oscilações observadas podem ser entendidas como parte do processo de adaptação das práticas assistenciais às condições concretas de funcionamento das unidades, evidenciando avanços graduais, ainda que permeados por desafios de gestão e de oferta de insumos.

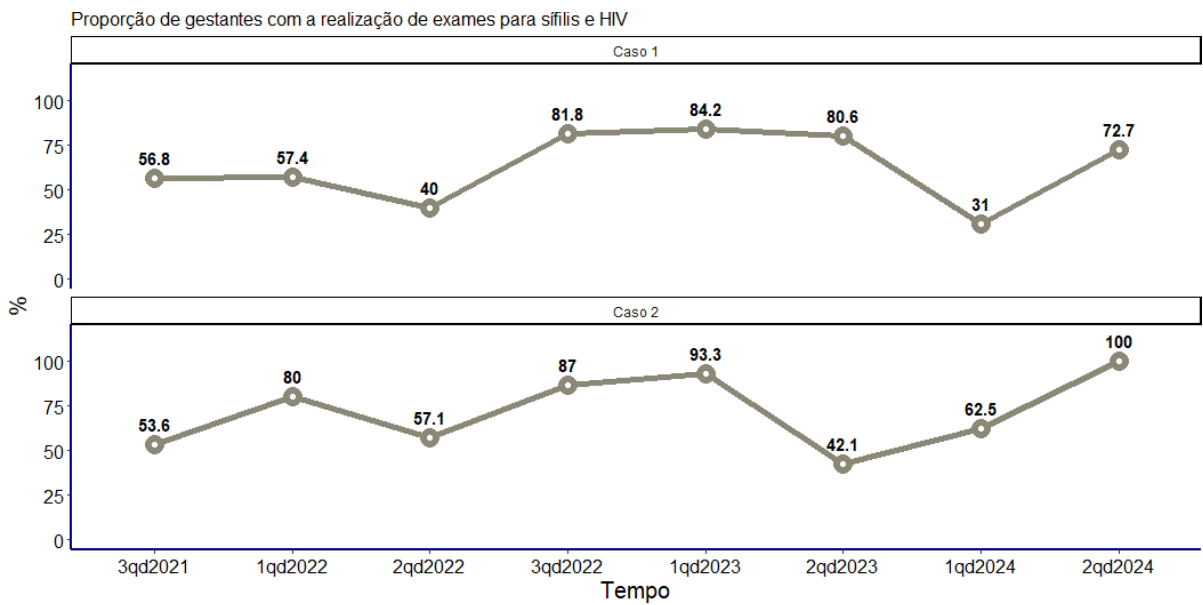
Em síntese, o desempenho alcançado pelas duas unidades em 2024 expressa a consolidação de práticas mais sistemáticas de acompanhamento das gestantes, em consonância com as diretrizes da Iniciativa UAPI. Os resultados sugerem progressos nas dimensões de alcance e implementação do modelo RE-AIM, indicando maior capacidade dos serviços em

integrar ações preventivas e assegurar o cuidado contínuo no pré-natal.

Tabela 2. Proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV. Recife, 2025.

Unidade	3º quadrimestr e 2021	1º quadrimestr e 2022	2º quadrimestr e 2022	3º quadrimestr e 2022	1º quadrimestr e 2023	2º quadrimestr e 2023	1º quadrimestr e 2024	2º quadrimestr e 2024	3º quadrimestr e 2024	P-vlr
Caso 1	21/37 (56.8%)	27/47 (57.4%)	10/25 (40.0%)	27/33 (81.8%)	16/19 (84.2%)	25/31 (80.6%)	9/29 (31.0%)	16/22 (72.7%)	28/35 (80)	0.001
Caso 2	15/28 (53.6%)	16/20 (80.0%)	16/28 (57.1%)	20/23 (87.0%)	28/30 (93.3%)	24/57 (42.1%)	20/32 (62.5%)	33/33 (100.0%)	-	0.001
p-vlor	0.798	0.078	0.213	0.607	0.304	0.001	0.014	0.001		

Figura 7. Proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV. Recife, 2025.



5.6.3 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ 6 MESES

Os dados apresentados na tabela 3 e figura 8 evidenciam melhora significativa no indicador de aleitamento materno exclusivo nas duas unidades, com tendência ascendente estatisticamente confirmada ($p < 0,001$ em ambas as séries). Apesar do avanço ao longo do período, o comportamento dos dados foi marcado por oscilações intermediárias, refletindo as variações no desempenho das equipes e na adesão das famílias às ações de promoção do aleitamento. Partindo de patamares moderados, ambas as unidades registram redução expressiva em 2023 — aproximadamente 23% no Caso 1 e 21% no Caso 2 —, seguida de recuperação importante em 2024, quando os percentuais se elevam para 60–71% no Caso 1 e 52–67% no Caso 2. No último ponto observado, os dois casos mantêm valores superiores aos da linha de base, indicando progresso gradual e consolidação das práticas de incentivo à amamentação.

As entrevistas com os profissionais oferecem elementos que ajudam a compreender essas flutuações. Em ambos os contextos, mencionou-se que mudanças na composição das equipes, ausência de capacitações recentes e sobrecarga assistencial podem ter contribuído para a redução dos índices em 2023, especialmente pela menor frequência de grupos e orientações voltadas à amamentação. Por outro lado, a retomada dos percentuais em 2024 parece estar associada a esforços de reorganização das atividades educativas e de acompanhamento pós-parto, estimulados pela retomada das ações da Iniciativa UAPI. Os relatos destacaram que a sensibilização das equipes e o fortalecimento do vínculo com as mães favoreceram maior adesão ao aleitamento e ampliação das orientações nas consultas e visitas domiciliares.

Na comparação entre as unidades, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na maior parte dos quadrimestres (p variando entre 0,20 e 0,99), com apenas um ponto limítrofe ($p \approx 0,057$). Esse padrão indica trajetórias semelhantes de evolução, com oscilações pontuais, mas tendência comum de melhora e convergência para patamares mais elevados no final da série. O comportamento paralelo das duas unidades sugere que os avanços obtidos refletem processos estruturais de incorporação das práticas de incentivo ao aleitamento, mais do que diferenças específicas de gestão local.

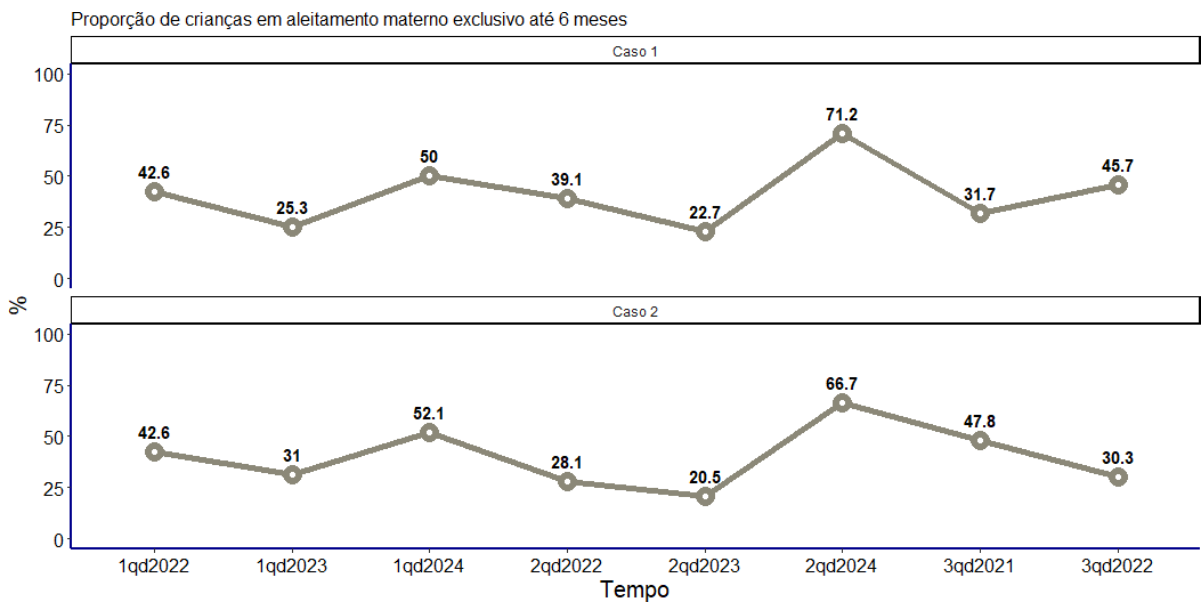
De modo geral, o aumento da proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até seis meses reflete o fortalecimento das ações de cuidado e aconselhamento às famílias, um dos eixos centrais da Iniciativa UAPI. A análise integrada dos resultados sugere que o

engajamento das equipes e a valorização da amamentação como prática promotora do desenvolvimento infantil contribuíram para a sustentação de resultados positivos, ainda que permeados por desafios operacionais. Assim, o indicador expressa avanços nas dimensões de alcance e implementação do modelo RE-AIM, evidenciando melhoria na cobertura e na continuidade das práticas de promoção da saúde na primeira infância.

Tabela 3. Proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Recife, 2025.

Unidade	3º quadrimest re 2021	1º quadrimest re 2022	2º quadrimest re 2022	3º quadrimest re 2022	1º quadrimest re 2023	2º quadrimest re 2023	1º quadrimest re 2024	2º quadrimest re 2024	3º quadrimestre 2024	P-valor
Caso 1	13/41 (31.7%)	26/61 (42.6%)	25/64 (39.1%)	37/81 (45.7%)	23/91 (25.3%)	22/97 (22.7%)	26/52 (50.0%)	37/52 (71.2%)	24/42 (57.1%)	0.001
Caso 2	11/23 (47.8%)	20/47 (42.6%)	16/57 (28.1%)	20/66 (30.3%)	22/71 (31.0%)	18/88 (20.5%)	25/48 (52.1%)	32/48 (66.7%)	-	0.001
p-valor	0.201	0.994	0.202	0.057	0.421	0.713	0.835	0.628		

Figura 8. Proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Recife, 2025.



5.6.4 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS COM PESO ADEQUADO PARA A IDADE

Os resultados apresentados na tabela 4 e figura 9 demonstram tendência ascendente e consistente em ambas as unidades, com significância estatística dentro de cada série ($p < 0,001$). A Caso 1 parte de um patamar intermediário (61,2% no terceiro quadrimestre de 2021, chegando a 50,0% no início de 2022) e, a partir desse ponto, apresenta crescimento contínuo e sustentado, alcançando valores entre 91,6% e 92,2% entre o terceiro quadrimestre de 2022 e o segundo de 2023, mantendo-se estável até 2024.

Já a Caso 2, iniciando-se em nível ligeiramente superior (68,7%), exibe elevação gradual, atingindo 95,7% no segundo quadrimestre de 2023 e permanecendo próxima a esse patamar (~92–96%) até o final da série. Em termos de ganho líquido, observa-se aumento expressivo em ambas as unidades — cerca de +30 pontos percentuais na Caso 1 e +23 a +27 pontos percentuais na Caso 2 —, o que aponta para melhora substancial nas práticas de acompanhamento e vigilância nutricional ao longo do tempo.

As variações observadas podem ser interpretadas à luz dos achados qualitativos, que destacaram a valorização da puericultura como espaço privilegiado de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Esse fortalecimento da puericultura foi percebido como resultado da reorganização das rotinas e do reconhecimento, pelas equipes, da importância do acompanhamento sistemático do crescimento das crianças. Além disso, o planejamento mais estruturado das consultas e o acompanhamento ativo das crianças em situação de risco são fatores que favorecem a manutenção de indicadores mais estáveis e elevados.

Na comparação entre as unidades, as diferenças são pontuais e de pequena magnitude. Apenas no primeiro quadrimestre de 2022 observou-se vantagem estatisticamente significativa para o Caso 2 (66,7% vs 50,0%; $p = 0,005$). Nos demais períodos, os valores se mantêm próximos (p variando entre 0,214 e 0,741), revelando convergência de desempenho após 2022. Essa convergência reforça a interpretação de que os avanços refletem melhorias de processo e de organização do cuidado, mais do que variações específicas entre contextos.

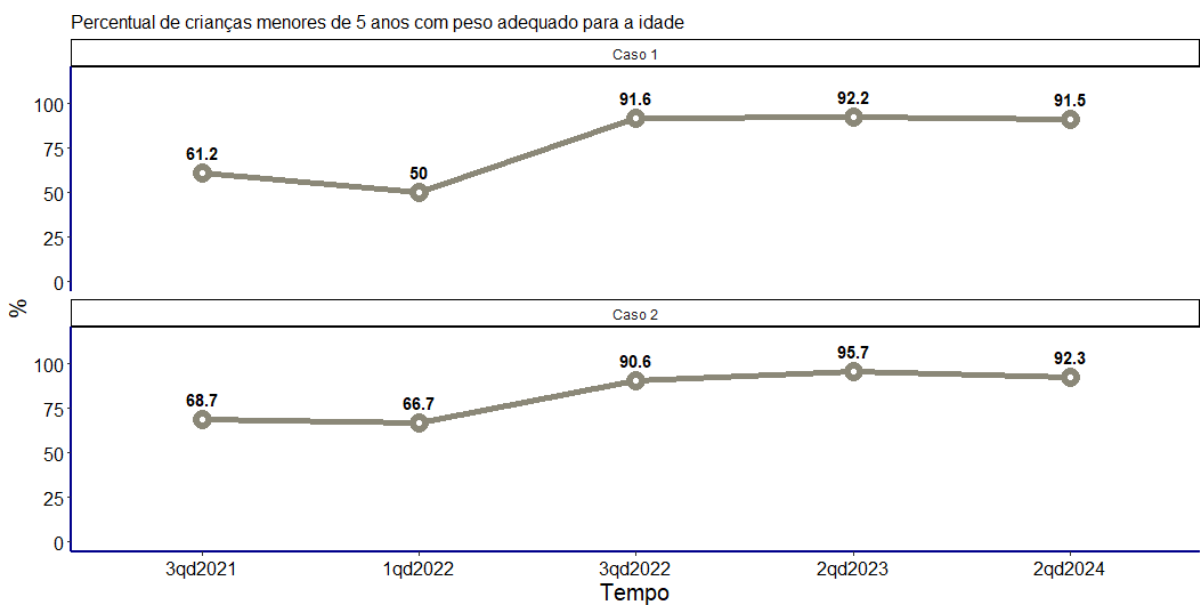
De modo geral, o comportamento do indicador evidencia a consolidação de rotinas mais estruturadas de acompanhamento do crescimento, em alinhamento com as diretrizes da Iniciativa UAPI e com os princípios da atenção integral à criança. Os resultados sugerem

avanços nas dimensões de alcance e implementação do modelo RE-AIM, expressos no aumento da cobertura, na continuidade do cuidado e na capacidade das equipes de monitorar o desenvolvimento infantil de forma mais regular e qualificada.

Tabela 4. Percentual de crianças menores de 5 anos com peso adequado para a idade. Recife, 2025.

Unidade	3º quadrimestre 2021	1º quadrimestre 2022	3º quadrimestre 2022	2º quadrimestre 2023	2º quadrimestre 2024	p-valor
Caso 1	71/116 (61.2%)	91/182 (50.0%)	197/215 (91.6%)	201/218 (92.2%)	247/270 (91.5%)	0.001
Caso 2	46/67 (68.7%)	74/111 (66.7%)	115/127 (90.6%)	112/117 (95.7%)	169/183 (92.3%)	0.001
p-valor	0.312	0.005*	0.734	0.214	0.741	

Figura 9. Percentual de crianças menores de 5 anos com peso adequado para a idade. Recife, 2025.



5.6.5 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS ATÉ 1 ANO, 11 MESES E 29 DIAS COM 1 OU MAIS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMÁTICAS

A tabela 5 e a Figura 10 apresentam resultados contrastantes entre as duas unidades, com diferenças estatisticamente significativas em grande parte dos quadrimestres ($p \leq 0,001$). A Caso 1 apresenta variação expressiva ao longo da série ($p < 0,001$), partindo de níveis baixos em 2021 e início de 2022 (~15–16%), alcançando um pico acentuado no segundo quadrimestre de 2022 (61,3%), seguido por oscilações sucessivas, incluindo novo declínio para 15,7% em 2023, leve recuperação no segundo quadrimestre (44,6%) e queda marcante em 2024, quando o indicador atinge 0,7% no primeiro quadrimestre e se recupera parcialmente no segundo (12,3%). Já a Caso 2 exibe percentuais persistentemente baixos durante todo o período, variando entre 0,9% e 4,7%, ainda que com diferença estatisticamente detectável ao longo do tempo ($p \approx 0,048$). Ao final da série, o desempenho permanece reduzido (2,4% no segundo quadrimestre de 2024).

Na comparação entre unidades, a Caso 1 mantém desempenho superior na maior parte do período, com exceção de 2024, quando ambas registram queda acentuada e aproximação dos valores ($p = 0,532$ no 1º quadrimestre e $p = 0,073$ no 2º). Esses resultados sugerem dificuldades estruturais e operacionais na manutenção das ações odontológicas programáticas, expressas tanto nas flutuações da Caso 1 quanto na persistente baixa cobertura da Caso 2.

Nos achados qualitativos, o tema não foi relatado de forma direta pelas equipes. No entanto, a fala da Gerente destacou que a perda da certificação da unidade esteve associada ao desempenho crítico desse indicador, chegando a zerar em determinado momento. Essa observação reforça a sensibilidade do indicador e sua importância no processo avaliativo da Iniciativa UAPI, ao mesmo tempo em que evidencia a vulnerabilidade das ações de saúde bucal diante de descontinuidades na equipe odontológica e da baixa integração com as demais atividades de puericultura.

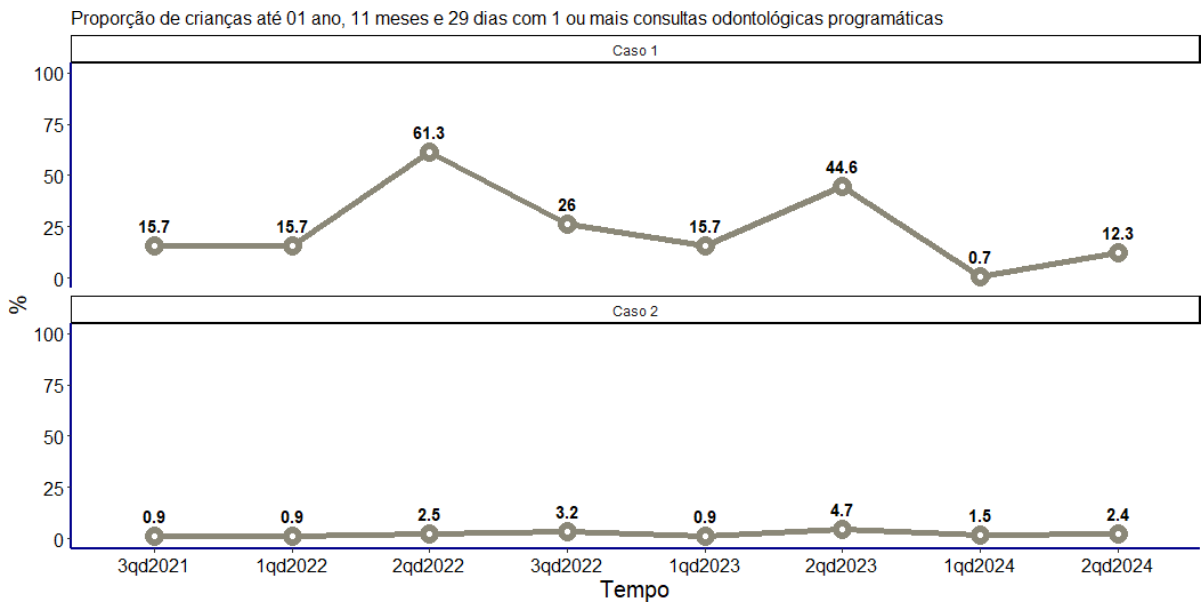
De modo geral, o comportamento do indicador evidencia um dos pontos mais frágeis do conjunto analisado, refletindo a dificuldade de institucionalizar práticas regulares de acompanhamento odontológico na primeira infância. As oscilações acentuadas e os baixos percentuais indicam desafios tanto na organização dos fluxos de atendimento quanto na integração da saúde bucal às ações de cuidado integral. À luz do modelo RE-AIM, os achados

sugerem limitações nas dimensões de *alcance e implementação*, destacando a necessidade de estratégias específicas para fortalecer a presença da odontologia nas ações de promoção da saúde da criança.

Tabela 5. Proporção de crianças até 01 ano, 11 meses e 29 dias com 1 ou mais consultas odontológicas programáticas. Recife, 2025.

Unida de	3º quadrim estre 2021	1º quadrim estre 2022	2º quadrim estre 2022	3º quadrim estre 2022	1º quadrim estre 2023	2º quadrim estre 2023	1º quadrim estre 2024	2º quadrim estre 2024	3º quadrim estre 2024	P-vlor
Caso 1	18/115 (15.7%)	18/115 (15.7%)	38/62 (61.3%)	25/96 (26.0%)	18/115 (15.7%)	25/56 (44.6%)	1/142 (0.7%)	9/73 (12.3%)	6/100 (6.0%)	0.001
Caso 2	1/115 (0.9%)	1/115 (0.9%)	3/120 (2.5%)	4/125 (3.2%)	1/115 (0.9%)	2/43 (4.7%)	2/135 (1.5%)	1/41 (2.4%)	-	0.048
p-vlor	0.001*	0.001*	0.001*	0.001*	0.001*	0.001*	0.532	0.073		

Figura 10. Proporção de crianças até 01 ano, 11 meses e 29 dias com 1 ou mais consultas odontológicas programáticas. Recife, 2025.



5.6.6 PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM 2 ANOS COMPLETOS QUE TIVERAM 9 OU MAIS CONSULTAS DE PUERICULTURA

Trata-se de um indicador de alta exigência, pois pressupõe início precoce do acompanhamento, regularidade das consultas e registros consistentes ao longo dos dois primeiros anos de vida. Os resultados apresentados na Tabela 7 e Figura 9 evidenciam ganhos relevantes em ambas as unidades, ainda que com trajetórias temporais bastante distintas.

Na Caso 1, observa-se evolução irregular, mas com tendência estatisticamente significativa ($p < 0,001$): o indicador parte de 3,7% no 1º quadrimestre de 2022, sobe para 8,3% em 2023, sofre uma queda acentuada no início de 2024 (2,6%) e, posteriormente, apresenta crescimento expressivo, alcançando 39,8% no 3º quadrimestre de 2024. Já na Caso 2, a série inicia praticamente sem registros (0,0% em 2022) e permanece estável em níveis mínimos até o 2º quadrimestre de 2023 (0,4%), quando passa a exibir ascensão acentuada, atingindo 40,5% no 1º quadrimestre de 2024 ($p < 0,001$), não havendo dados disponíveis para o período seguinte.

Na comparação entre unidades, o desempenho inicial é semelhante ($p = 0,099$). Em 2023, a Caso 1 apresenta resultados superiores (8,3% vs 0,4%; $p = 0,001$), enquanto em 2024 ocorre o oposto, com melhor desempenho da Caso 2 (40,5% vs 2,6%; $p = 0,001$). No último ponto observável de cada série, ambas atingem patamares próximos de 40%, embora por caminhos distintos — o que sugere processos de reorganização interna e retomada das práticas de acompanhamento ocorrendo em momentos diferentes nas duas unidades.

Do ponto de vista qualitativo, a puericultura foi reiteradamente reconhecida pelos profissionais como um espaço estratégico de cuidado longitudinal à criança, ainda que permeado por desafios de continuidade, especialmente nos períodos de maior sobrecarga assistencial. Esse reconhecimento ajuda a compreender o desempenho ascendente do indicador no período final, sugerindo esforços das equipes para restabelecer a regularidade das consultas e fortalecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil.

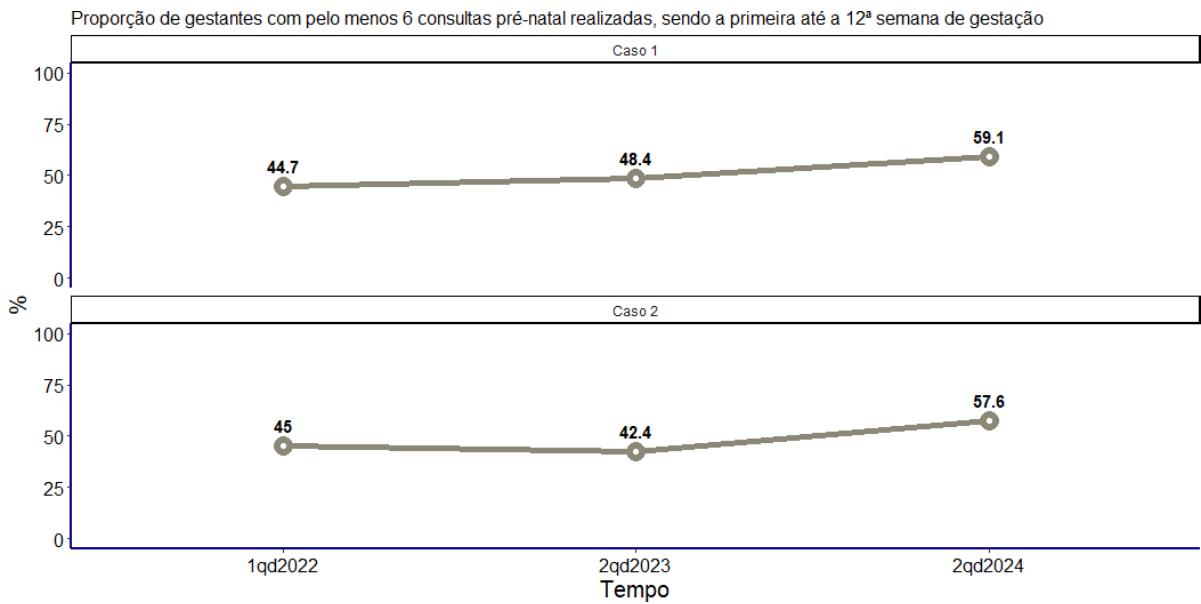
De modo geral, o comportamento do indicador demonstra avanços importantes na consolidação da puericultura como eixo estruturante da atenção à infância, um dos pilares valorizados pela Iniciativa UAPI. As diferenças observadas entre as unidades não indicam desigualdade de resultados, mas sim tempos distintos de amadurecimento das práticas. Segundo o modelo RE-AIM, os achados apontam progresso nas dimensões de alcance e implementação, evidenciado pela ampliação gradual do acompanhamento continuado das crianças e pela

recuperação da capacidade das equipes em garantir a integralidade do cuidado nos primeiros anos de vida.

Tabela 6. Proporção de crianças com 2 anos completos que tiveram 9 ou mais consultas de Puericultura. Recife, 2025.

Grupo	1º quadrimestre 2022	2º quadrimestre 2023	1º quadrimestre 2024	3º quadrimestre 2024	P-valor
Caso 1	3/82 (3.7%)	15/180 (8.3%)	2/77 (2.6%)	39/98(39.8%)	0.001
Caso 2	0/73 (0.0%)	1/237 (0.4%)	15/37 (40.5%)	-	0.001
p-valor	0.099	0.001*	0.001*		

Figura 11. Proporção de crianças com 2 anos completos que tiveram 9 ou mais consultas de Puericultura. Recife, 2025.



6 DISCUSSÃO

Ancorado na Ciência da Implementação, este estudo parte do pressuposto de que os resultados de uma iniciativa não são explicados apenas por seu desenho técnico, mas pelas condições contextuais, organizacionais e relacionais que moldam sua execução no cotidiano dos serviços. Nesse sentido, a utilização do modelo RE-AIM permitiu organizar a análise em dimensões-chave, evidenciando como alcance, adoção, implementação e manutenção se expressam de maneira distinta em contextos institucionais desiguais. Os achados, portanto, buscam compreender os mecanismos que sustentam ou fragilizam a incorporação da UAPI nas rotinas da APS.

A análise comparativa da implementação da Iniciativa UAPI nas duas USF, à luz do modelo RE-AIM, evidencia que a certificação e a posterior perda desse status não se explicam apenas pelo desempenho em indicadores específicos, mas refletem diferenças estruturais, organizacionais e contextuais que atravessam o processo de implementação. Embora ambos os casos apresentem volumes semelhantes de ocorrências codificadas, o Caso 1, a unidade certificada, caracteriza-se pela predominância de facilitadores nas dimensões Alcance, Adoção e Manutenção, indicando maior institucionalização das práticas, integração entre profissionais e capacidade de sustentar as ações ao longo do tempo.

Em contraste, o Caso 2, que perdeu a certificação, concentra maior número de barreiras, especialmente na dimensão Implementação, revelando fragilidades relacionadas à sobrecarga assistencial, limitações de infraestrutura, descontinuidade de processos formativos e menor suporte organizacional. Esses achados sugerem que a certificação não é apenas resultado do cumprimento de metas, mas é expressão de uma trajetória de implementação mais madura, na qual condições institucionais, governança local e aprendizagem organizacional desempenham papel central na sustentação das ações da UAPI.

Este estudo revelou que a implementação da Iniciativa UAPI constitui o ponto mais crítico, concentrando a maior parte das barreiras identificadas nas duas unidades analisadas. Contudo, essa interpretação deve ser considerada com cautela, uma vez que a maior densidade de barreiras nessa dimensão pode refletir não apenas fragilidades empíricas da iniciativa, mas também características inerentes ao próprio modelo RE-AIM. A dimensão Implementação, por seu caráter mais operacional, abrange aspectos concretos do processo de trabalho, como disponibilidade de recursos, organização do serviço, carga de trabalho e suporte institucional,

os quais tendem a gerar maior volume de relatos, exemplos e, consequentemente, maior densidade de codificação nas análises qualitativas.

Nesse sentido, o predomínio de barreiras nessa dimensão pode estar relacionado tanto a desafios reais na operacionalização da iniciativa quanto à maior sensibilidade analítica do framework para captar esse tipo de elemento. Assim, ao mesmo tempo em que os achados apontam para a implementação como um eixo crítico, é necessário reconhecer que tal centralidade pode também ser parcialmente influenciada pela própria estrutura analítica adotada, evitando-se interpretações unidimensionais desse resultado.

Apesar de alcances positivos — impulsionados por ações como a busca ativa, as visitas domiciliares e a motivação profissional — e da adesão das equipes à proposta, a execução cotidiana das ações mostrou-se fragilizada por fatores estruturais e organizacionais, como sobrecarga de trabalho, limitações na infraestrutura, falhas nos sistemas de informação e descompasso entre o ciclo de capacitação e as exigências práticas do serviço. Esses desafios, por sua vez, repercutem diretamente na manutenção das práticas, que se revelou instável e dependente de mecanismos institucionais pouco consolidados. Assim, embora o estudo evidencie o potencial da UAPI para qualificar o cuidado na primeira infância, demonstra que a sustentabilidade e a efetividade da iniciativa dependem de estratégias de implementação mais robustas, sistemáticas e apoiadas por suporte institucional permanente.

Os indicadores analisados dialogam diretamente com as fragilidades identificadas na análise qualitativa, reforçando que a dimensão da implementação constitui o principal ponto crítico da UAPI. Embora alguns indicadores — como consultas de pré-natal e peso adequado para a idade — apresentem tendência geral de melhoria ao longo dos ciclos avaliativos, assim, os dados quantitativos não apenas corroboram as barreiras, mas evidenciam que a fragilidade da implementação repercute diretamente nos resultados assistenciais, comprometendo a continuidade e a sustentabilidade das ações preconizadas pela iniciativa.

Os resultados indicaram que o alcance das ações relacionadas à primeira infância foi expressivo, porém com diferenças entre as duas unidades. O caso 1 — a unidade certificada e ainda reconhecida como UAPI — apresentou maior amplitude de participação das famílias e integração entre os profissionais, especialmente em atividades de puericultura e grupos educativos. Já o caso 2 evidenciou um alcance mais restrito, condicionado à disponibilidade de profissionais e à ausência de estratégias consistentes de comunicação com a comunidade. Essa

discrepância reflete a importância das lideranças locais e da continuidade do engajamento institucional para o sucesso das ações, aspecto também enfatizado por Durlak e DuPre (2008) e reforçado por Glasgow et al. (2020), segundo os quais a manutenção de lideranças comprometidas e o apoio organizacional são determinantes para garantir representatividade e equidade na adoção das intervenções.

No caso 1, a presença de uma liderança técnica engajada, a estabilidade da equipe e o apoio da gestão local se destacaram como fatores envolvidos no alcance e na adesão das famílias. O engajamento comunitário foi fortalecido por práticas participativas, como reuniões da equipe e práticas em grupo com a comunidades, que favoreceram o sentimento de pertencimento dos cuidadores. Esses mecanismos são descritos na literatura de implementação como estratégias de *empowerment* local que ampliam o “*Reach*” e o “*Adoption*” de programas sociais (PROCTOR et al., 2022; RABIN et al., 2023). Já o caso 2, marcado por descontinuidade das atividades, rotatividade de profissionais e comunicação institucional limitada, ilustram como a fragilidade na gestão e na infraestrutura podem comprometer a institucionalização das práticas e a percepção de legitimidade da iniciativa junto à comunidade.

Em relação à adoção, observou-se que o caso 1 conseguiu institucionalizar práticas do cuidado à primeira infância, integrando-as à rotina da ESF, enquanto o caso 2 dependia de iniciativas pontuais de profissionais específicos, que se perderam com a rotatividade e o enfraquecimento da gestão local. A literatura reforça que a adoção sustentada de programas intersetoriais em atenção primária requer estrutura mínima, incentivo gerencial e reconhecimento simbólico das equipes — elementos observados apenas no caso 1 (NILSEN; BERNHARDSSON, 2024; TABAK et al., 2023). Além disso, o caso 1 demonstrou maior capacidade de aprender com a experiência e adaptar protocolos de acordo com a realidade local, refletindo o princípio de “aprendizagem adaptativa” da Ciência da Implementação (CHAMBERS et al., 2022). No caso 2, a falta de espaços institucionais para reflexão coletiva limitou a consolidação das práticas, demonstrando que a implementação sem mecanismos de aprendizagem tende a se dissolver ao longo do tempo.

Quanto à efetividade, identificou-se que o caso 1 alcançou melhores resultados na articulação entre vigilância do desenvolvimento e puericultura, evidenciando integração entre o acompanhamento clínico e ações intersetoriais. O caso 2, por sua vez, apresentou fragilidades na continuidade do cuidado e menor vínculo entre profissionais e famílias, o que comprometeu a efetividade das ações. Essa diferença sugere que o contexto organizacional e a estabilidade

da equipe exercem influência direta sobre os resultados de implementação — fenômeno igualmente descrito por Shelton et al. (2023), que destacam a importância das condições contextuais, da cultura organizacional e da liderança distribuída para o desempenho das estratégias em atenção primária. A unidade certificada (caso 1) representa, um exemplo de “implementação de alta aderência” (*high-fidelity implementation*), enquanto a unidade não certificada se enquadra em um padrão de “erosão adaptativa” (*drift*), caracterizado pela perda gradual da coerência e do foco programático (DAMSCHOREDER et al., 2022).

Ainda nessa dimensão, a barreira, quando comparados os casos, eles apresentam semelhanças estruturais, expressas na resistência de parte das famílias às orientações das equipes, nas limitações materiais e na exposição cotidiana à violência. Esses contextos impõem restrições às oportunidades de cuidado e aprendizado, comprometendo tanto a adesão às ações quanto a efetividade das estratégias intersetoriais. A literatura internacional tem enfatizado que as desigualdades territoriais e as condições de vulnerabilidade produzem trajetórias de desenvolvimento desiguais desde a primeira infância, exigindo políticas capazes de transformar as circunstâncias ambientais e sociais que moldam o bem-estar das crianças (SHONKOFF, 2021; BLACK et al., 2017).

Nessa direção, o conceito de *ECD 2.0* amplia a compreensão sobre o desenvolvimento infantil ao incluir os determinantes contextuais e sistêmicos que sustentam ou fragilizam as experiências das crianças. essa abordagem propõe o fortalecimento de ecossistemas de cuidado, reconhecendo que “o lugar importa” e que o impacto das políticas depende de sua inserção em territórios desiguais. Assim, promover o desenvolvimento na primeira infância requer ações que integrem saúde, educação e proteção social, fortalecendo o papel da APS (SHONKOFF; FISHER, 2019; DAELMANS et al., 2020).

No que se refere à dimensão de implementação, as principais barreiras comuns a ambas as unidades incluíram a sobrecarga de trabalho, a escassez de tempo e as dificuldades no uso do sistema e-SUS/PEC. Entretanto, o caso 1 apresentou maior capacidade de adaptação e inovação local, com divisão de responsabilidades, reuniões de planejamento e uso mais sistemático dos dados de prontuário eletrônico para organizar ações. Essa diferença de maturidade operacional sugere que a implementação bem-sucedida está associada à governança local, à clareza de papéis e à presença de mecanismos de supervisão e apoio contínuo, como apontam Stamatakis et al. (2024) e Hailemariam et al. (2022). Já o caso 2 mostrou uma gestão fragmentada, com fragilidade nos fluxos de comunicação, perda de registros e ausência de

monitoramento regular — fatores que reduziram a consistência das ações e limitaram a aprendizagem organizacional.

A dimensão de manutenção revelou contrastes entre os casos. O caso 1 conseguiu preservar parte significativa das práticas após a certificação, mantendo o engajamento da equipe e a realização de ações educativas mesmo diante de mudanças de gestão. Isso demonstra a presença de uma cultura institucional voltada à sustentabilidade, que é sustentada por valores compartilhados e memória organizacional. O caso 2, em contrapartida, apresentou um processo de desinstitucionalização gradual: as atividades deixaram de ocorrer, os registros se perderam e a equipe passou a encarar a UAPI como um projeto “do passado”. Esses achados reforçam o que Hall et al. (2022) e Nevedal et al. (2024) descrevem como o “desgaste natural” de programas sem mecanismos formais de retroalimentação e financiamento. O caso 1, portanto, representa uma trajetória de manutenção ativa, enquanto o caso 2 evidencia o fenômeno de “sustentabilidade passiva”, em que a continuidade depende de motivações individuais e não de estruturas institucionais estáveis (MOORE et al, 2023).

Outro aspecto relevante foi a integração entre puericultura e saúde bucal. O caso 1 demonstrou articulação consistente entre a equipe de saúde bucal e as atividades de puericultura, incorporando a primeira consulta odontológica do bebê ao acompanhamento regular da criança e registrando avanços nos indicadores de prevenção. No caso 2, a ausência dessa integração resultou em lacunas na promoção da saúde oral e na prevenção precoce de agravos. Essa diferença está em consonância com estudos nacionais e internacionais que apontam a importância de incluir a saúde bucal nas agendas de puericultura como componente essencial do cuidado integral à infância (PACHECO et al, 2024; MENDES et al, 2023). A vinculação precoce da saúde bucal ao cuidado infantil amplia a adesão familiar, reduz iniquidades de acesso e fortalece o eixo “cuidado responsivo” do modelo Nurturing Care (PÉREZ-ESCAMILLA, R.; VENÂNCIO, S.; BUCCINI, 2022)

A consolidação dessas práticas integradas depende diretamente da atuação qualificada e reflexiva dos profissionais de saúde, o que reforça a relevância dos processos de capacitação contínua (MENDES et al, 2021). É por meio dessas formações que as equipes ampliam suas competências clínicas e educativas, fortalecendo a capacidade de identificar vulnerabilidades, planejar ações interdisciplinares e adaptar o cuidado às demandas do território. A educação permanente em saúde, nesse sentido, constitui-se como eixo estruturante para sustentar

mudanças nas práticas e favorecer a incorporação de abordagens inovadoras no cotidiano assistencial (FUNAYAMA; CYRINO; GARCIA, 2022).

Nessa perspectiva, a capacitação dos profissionais de saúde, especialmente aquelas voltadas ao fortalecimento do cuidado na primeira infância, são importantes para ampliar a qualidade das práticas na Atenção Primária (SILVA et al, 2025). A formação contínua favorece o desenvolvimento de competências clínicas, comunicacionais e educativas, essenciais para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil. Ao promover o diálogo entre o conhecimento técnico e a experiência cotidiana das equipes, tais iniciativas contribuem para consolidar práticas mais sustentáveis e alinhadas aos princípios da atenção integral. Assim, a capacitação contínua deve ser compreendida como um investimento estratégico e não como ação pontual (AVGERINOU et al, 2021).

A partir do fortalecimento das práticas profissionais por meio da capacitação, é necessário ampliar e sustentar os efeitos formativos no cotidiano dos serviços, o que tem sido possível com o apoio das tecnologias em saúde. Estudos realizados em diferentes contextos da Atenção Primária demonstram que plataformas digitais e ambientes virtuais de aprendizagem favorecem o aprendizado contínuo, a troca de experiências e a integração entre teoria e prática (LOPES et al., 2021; ANDRADE et al., 2023). Assim, o uso de ferramentas digitais consolida o que é construído nos processos formativos, permitindo que o conhecimento se mantenha vivo, compartilhado e aplicável nas rotinas assistenciais.

Diante desse cenário, as capacitações ganham papel estratégico na formação crítica dos profissionais frente à desinformação, estimulando a análise de fontes e o uso ético das mídias digitais. Ao incorporar temas como comunicação em saúde, verificação de evidências e letramento digital, os processos formativos preparam as equipes para atuar como mediadoras entre o conhecimento científico e o saber popular. Estudos apontam que o desenvolvimento dessas competências reduz a propagação de informações incorretas e fortalece a confiança das famílias nas orientações emitidas pela Atenção Primária (JAFREE et al, 2021; ERKU et al., 2023).

Além disso, é importante reconhecer que o enfrentamento da infodemia exige abordagens coletivas e interdisciplinares, nas quais a tecnologia é utilizada como aliada na promoção da saúde e na construção de vínculos. Experiências recentes demonstram que ações de comunicação ativa em unidades básicas contribuem para ampliar o engajamento comunitário

e reduzir resistências frente às práticas de cuidado. O estudo de Chen, Lee e Lin (2022), evidencia o papel ambíguo das mídias sociais no campo da saúde, destacando que, embora sejam instrumentos para compartilhamento de informações, também podem favorecer a propagação de conteúdos imprecisos.

O fluxo intenso de notícias e opiniões, muitas vezes não verificadas, exige das equipes de saúde uma atuação mais ativa na mediação das informações e na promoção do letramento midiático da população. No contexto das vacinas, por exemplo, a circulação de informações falsas sobre efeitos adversos ou sobre a eficácia dos imunizantes tem demandado respostas rápidas, coordenadas e baseadas em evidências por parte dos profissionais da Atenção Primária (GISONDI et al, 2022; KAWUKI et al, 2023).

Do ponto de vista das políticas públicas, a análise comparativa evidencia que a UAPI, quando institucionalizada e acompanhada por mecanismos de governança e formação continuada — como no caso 1 —, apresenta maior potencial de impacto, sustentabilidade e disseminação. O caso 1 revela um processo de aprendizagem organizacional que se aproxima das experiências internacionais de *scale-up* sustentável, nas quais o programa deixa de ser uma intervenção pontual e passa a ser parte integrante das rotinas da atenção primária (Fixsen et al., 2022). Já o caso 2 mostra os riscos da descontinuidade política e administrativa, comum em programas municipais, especialmente quando não há incorporação formal nas agendas de gestão. Essa constatação dialoga com evidências de Purtle et al. (2023) e Chambers et al. (2022), que defendem a importância da institucionalização e da cultura de implementação como pilares da sustentabilidade em políticas públicas.

Em termos práticos, os resultados deste estudo sugerem que experiências bem-sucedidas, como a do caso 1, podem servir de referência para a ampliação da UAPI em outras regiões, desde que acompanhadas de mecanismos estruturantes — entre eles, devolutivas regulares de indicadores, valorização das lideranças locais, protocolos integrados de atenção e incentivos à inovação organizacional. Também se destaca a importância de estratégias que fortaleçam a governança compartilhada entre gestores, profissionais e comunidade, aproximando o princípio da “responsividade social” da prática cotidiana. A adoção de ferramentas de feedback em tempo real e de supervisão apoiadora (*facilitation approach*) pode ampliar a qualidade da implementação, como indicam recentes estudos sobre aprimoramento contínuo na APS (RABIN et al., 2023; PADEK et al., 2024).

Para suporte às análises qualitativas, foram também utilizados indicadores quantitativos, que serão discutidos. O primeiro deles está relacionado à atenção ao pré-natal, que conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, o número mínimo de consultas é de sete distribuídas da seguinte maneira: até a 28ª semana: uma consulta por mês (mensalmente), entre a 28ª e a 36ª semana: uma consulta a cada quinze dias, da 36ª até a 41ª semana: uma consulta. Em âmbito internacional, a OMS passou a recomendar, desde 2016, um mínimo de oito consultas durante a gestação, com o objetivo de proporcionar uma experiência positiva de cuidado e reduzir a mortalidade perinatal (MELO et al, 2025).

Estudos conduzidos em diferentes contextos reforçam que a adesão às consultas de pré-natal depende fortemente da organização dos serviços e da qualidade do vínculo entre gestantes e profissionais. Um estudo realizado em Moçambique afirmou que a regularidade das consultas aumenta quando há oferta contínua de cuidados, acolhimento humanizado e disponibilidade de recursos básicos nos serviços de atenção primária (MULEVA, 2020). Esses achados evidenciam que a estruturação dos fluxos assistenciais e a presença de profissionais capacitados são determinantes para a adesão ao acompanhamento gestacional e para a melhoria dos desfechos materno-infantis nesses contextos.

De modo semelhante, pesquisas desenvolvidas no Brasil apontam que unidades com equipes e processos de trabalho consolidados tendem a apresentar melhores indicadores de acompanhamento durante a gestação. Assim, a variação observada entre as unidades deste estudo pode refletir não apenas diferenças estruturais e operacionais, mas também distintos estágios de maturidade organizacional e de integração das ações de cuidado. Esses achados reforçam que o fortalecimento do pré-natal na APS requer estratégias que articulem gestão, qualificação profissional e engajamento comunitário, a fim de garantir o acesso oportuno e a continuidade da atenção à gestante (TADESSE et al., 2022; ADEBAYO et al., 2021; DOMINGUES et al., 2022; WHO, 2016).

Nessa continuidade aparece o indicador das gestantes testadas para sífilis e HIV, que nas duas unidades teve o percurso oscilante, esse comportamento sugere a capacidade adaptativa das equipes diante de desafios operacionais, como interrupções na oferta de insumos, reorganização de fluxos e instabilidade das equipes. Estudos realizados em diferentes contextos da APS apontam que a regularidade dos testes rápidos está diretamente associada à disponibilidade logística e ao monitoramento contínuo pelas coordenações locais (RONCALLI et al, 2021; PIMENTEL; PARMA; TRAEBERT, 2024). Tais fatores são determinantes para a

continuidade do cuidado e para a redução da transmissão vertical, considerando que o diagnóstico e tratamento oportunos de infecções sexualmente transmissíveis representam uma das metas prioritárias da OMS.

Ela reforça a importância da testagem universal para sífilis e HIV no primeiro trimestre, com repetição ao longo da gestação e no puerpério, como estratégia para eliminar a transmissão vertical até 2030 (WHO, 2017; COLETA et al, 2021). Entretanto, a instabilidade observada entre 2022 e 2023 evidencia desafios que são semelhantes aos relatados em países de média renda, onde a sustentabilidade das ações depende da integração intersetorial, da formação continuada das equipes e da incorporação de práticas baseadas em evidências.

Essa mesma lógica se aplica ao aleitamento materno exclusivo (AME), cuja manutenção exige suporte técnico constante e integração entre as ações educativas e assistenciais. Nesse estudo, o AME até seis meses teve oscilações intermediárias observadas entre 2022 e 2023 que podem ser compreendidas como reflexo das condições organizacionais e de gestão do cuidado, uma vez que o desempenho desse indicador está intimamente relacionado à continuidade das ações educativas, à formação permanente das equipes e ao vínculo estabelecido com as famílias. Os estudos de Christoffel et al. (2021), Machado et al. (2023), Martins et al. (2023), corroboram que a manutenção do aleitamento exclusivo depende tanto de políticas institucionais de apoio quanto da presença de profissionais capacitados e sensíveis às dificuldades enfrentadas pelas mães (SILVA et al., 2021; BRASIL, 2023).

Sob uma perspectiva mais ampla, os resultados convergem com o cenário internacional, em que o aleitamento materno é reconhecido como uma intervenção de alto impacto para a sobrevivência e o desenvolvimento infantil (FARIA; SILVA; PASSBERG, 2023). Em estudo realizado em Ermelo, na África do Sul, foram identificados fatores que influenciam a manutenção do aleitamento materno exclusivo, como crenças culturais, influência familiar e medos relacionados ao estigma do HIV (MODJADJI; MADIBA; NDLOVU 2023). Esses achados reforçam que, para além das políticas institucionais, é necessário que os profissionais de saúde estejam preparados para oferecer apoio contínuo, acolhimento e orientação culturalmente sensível às mães, favorecendo a superação de barreiras e a continuidade da amamentação.

Estudos realizados em países da América Latina demonstram que as oscilações nos índices de aleitamento materno exclusivo estão associadas a fatores contextuais, como

condições socioeconômicas, suporte familiar e consistência das políticas locais de incentivo (MANGIALAVOR et al, 2022; MEIRA et al, 2022). Nesse sentido, a trajetória semelhante entre as duas unidades estudadas indica que os avanços observados não se limitam a intervenções isoladas, mas refletem um processo mais estruturante de incorporação e manutenção das práticas de apoio à amamentação.

Nesse processo, as práticas dos profissionais de saúde têm um papel central, uma vez que é no vínculo cotidiano com as famílias que se constrói o suporte necessário para a amamentação. Segundo Peres et al. (2021), a escuta qualificada, o acolhimento e as orientações sensíveis às realidades locais fortalecem a confiança das mães e favorecem a superação de barreiras culturais, emocionais e sociais que interferem na continuidade do aleitamento. A atuação interprofissional fortalece o alcance e a efetividade das ações educativas, consolidando o apoio à amamentação como uma prática construída de forma colaborativa e sustentada pelos vínculos e pela responsabilidade compartilhada entre os membros da equipe (FERRONATO et al, 2023).

O aleitamento materno exclusivo e o acompanhamento regular das crianças são essenciais para assegurar um crescimento saudável e prevenir desequilíbrios nutricionais nos primeiros anos de vida (PATNODE et al, 2025). Nesse contexto, o indicador de proporção de crianças menores de cinco anos com peso adequado para a idade revela como o cuidado contínuo e as práticas de promoção da amamentação contribuem para o bom estado nutricional infantil. Esse resultado expressa não apenas a efetividade das ações de vigilância alimentar e nutricional, mas também o compromisso das equipes em apoiar as famílias e garantir o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

A tendência ascendente e estável observada na proporção de crianças menores de cinco anos com peso adequado para a idade indica melhorias na vigilância nutricional e no acompanhamento do crescimento infantil no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Esse comportamento está em consonância com o cenário nacional, no qual o fortalecimento da atenção básica e a ampliação do acesso às ações de puericultura contribuíram para reduzir deficiências nutricionais e consolidar práticas de acompanhamento mais sistemáticas (BRASIL, 2021; MONTEIRO et al., 2022).

A melhoria das condições nutricionais das crianças brasileiras está intimamente associada às políticas de proteção social, e às ações voltadas à segurança alimentar e ao

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. Os programas de transferência de renda têm a redução das desigualdades e na promoção da saúde infantil. Iniciativas nacionais, como o Bolsa Família, e estaduais, como o Programa Mães de Pernambuco, representam estratégias para mitigar os efeitos das vulnerabilidades sociais históricas, ampliando as oportunidades de cuidado e contribuindo para reduzir disparidades que ainda marcam a infância em diferentes territórios do país (RIBEIRO et al, 2022; GOULART.; RAVAZZANI,2024)

Para acompanhamento da condição nutricional, a consulta de puericultura é um componente da vigilância, preconizado pelo Ministério da Saúde que durante os dois primeiros anos de vida sejam realizadas sete consultas no primeiro ano de vida, e mais duas no segundo ano de vida (PEDRAZA, 2023). Pesquisas realizadas em diferentes regiões do país apontam que a regularidade das consultas está associada à estabilidade das equipes, à organização da agenda e à presença de ações de busca ativa, elementos que fortalecem o vínculo entre os profissionais e as famílias e favorecem o acompanhamento integral da criança (SCHIMITT et al, 2020; FERNANDES et al, 2023).

Além disso, o aumento da cobertura do indicador acompanha a tendência nacional de ampliação do escopo de práticas voltadas à primeira infância, impulsionadas por políticas recentes que reforçam o papel da atenção básica na promoção do desenvolvimento infantil (FERNANDES et al, 2023). No presente estudo, houve um avanço em ambos os casos, entretanto, dados não se apresentam de forma contínua entre os quadrimestres, o que pode refletir interrupções nos registros, variações na cobertura ou períodos de reorganização das equipes.

Seidu et al. (2023) e Nsehimyryo et al. (2024) evidenciam fragilidades no acompanhamento contínuo das crianças, marcadas por altas taxas de descontinuidade e falhas no registro de informações, especialmente no monitoramento do desenvolvimento infantil. Nessas análises, a regularidade das consultas é apontada como fator determinante para a qualidade do cuidado, pois visitas periódicas favorecem a detecção precoce de agravos e a adoção de medidas preventivas. A interrupção do acompanhamento, por sua vez, enfraquece o vínculo entre profissionais e famílias, comprometendo a efetividade das ações voltadas à promoção do desenvolvimento na primeira infância.

O fortalecimento da puericultura como eixo organizador da atenção à infância reafirma a importância da ampliação do acesso e da continuidade do cuidado para promover o

desenvolvimento integral das crianças. Nessa perspectiva, a integração da saúde bucal às ações de puericultura constitui um passo essencial para consolidar uma abordagem verdadeiramente integral nos primeiros anos de vida. O cuidado odontológico iniciado precocemente reforça o acompanhamento infantil, contribuindo para a prevenção de agravos bucais e para a formação de hábitos saudáveis desde os primeiros meses de vida (ANDRADE; GALINA; DOTTO, 2023; SILVA et al, 2023)

O indicador referente às consultas odontológicas na primeira infância apresentou comportamento irregular e baixo alcance, configurando-se como um dos pontos mais frágeis do conjunto analisado. A unidade Caso 2 manteve desempenho persistentemente reduzido durante todo o período, chegando a registrar valores zerados, o que levou à perda da certificação da unidade no âmbito da Iniciativa UAPI. Essa situação evidencia a vulnerabilidade das ações de saúde bucal frente à descontinuidade das equipes, à rotatividade de profissionais e à baixa integração à puericultura, reforçando o caráter sensível desse indicador como marcador da capacidade institucional de sustentar práticas regulares de promoção do cuidado.

Esse cenário dialoga com a literatura nacional, que tem reiterado as dificuldades históricas de incorporação da odontologia às ações regulares da Atenção Primária à Saúde. Pesquisas apontam que a atenção odontológica infantil, quando presente, ainda se concentra em demandas curativas, com pouca inserção nas atividades preventivas e de rotina. Estudos de Baldani et al. (2021) e Galvão; Medeiros; Roncalli (2021), destacam que, mesmo após avanços estruturais trazidos pela ESF e pela Política Nacional de Saúde Bucal, que em foi instituída formalmente por lei em 2023, a política promove o acesso gratuito ao tratamento odontológico, organiza os serviços de saúde bucal em todo o país, e busca a integralidade do cuidado em saúde bucal (ARRAIS; RONCALLI; ROSENDO, 2021)

A experiência das duas unidades demonstra que a sustentabilidade das ações de saúde bucal depende de mecanismos de gestão que garantam continuidade, estabilidade das equipes e articulação interprofissional. O fortalecimento da odontologia na primeira infância deve ser compreendido como componente essencial das políticas voltadas à promoção do desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, as diretrizes nacionais (BRASIL, 2023) e internacionais (WHO, 2023) convergem ao destacar a importância da introdução precoce do cuidado odontológico, da integração das práticas às rotinas de acompanhamento infantil e do planejamento de estratégias permanentes que assegurem o acesso regular e o fortalecimento do vínculo com as famílias.

A incorporação de abordagens avaliativas participativas e intersetoriais, que articulem saúde, educação e assistência social, incluindo as perspectivas da população, poderá fortalecer o caráter sistêmico da UAPI e consolidar o cuidado integral à primeira infância no Brasil. O investimento em mecanismos de aprendizagem institucional e redes de apoio técnico, como propõem Glasgow et al. (2024) e o Ministério da Saúde (2025), é essencial para que as boas práticas sejam disseminadas e sustentadas no tempo.

Considerando essas evidências, é importante reconhecer também os limites do presente estudo, especialmente quanto às condições estruturais e operacionais que podem ter influenciado a sustentabilidade das ações. Os resultados não são generalizáveis para todas as Unidades Amigas da Primeira Infância do município, embora ofereçam subsídios para contextos semelhantes. A utilização de autorrelatos e registros de rotina pode ter introduzido vieses de informação, enquanto fatores como mudanças nos sistemas, rotatividade de profissionais e restrições de infraestrutura podem ter impactado o desempenho e a documentação das ações.

Em relação à análise quantitativa, um dos principais desafios foi a falta de acesso a uma parte dos dados previstos. Embora se tenha realizado uma organização inicial do banco de dados em planilhas por quadrimestres, nem todos os indicadores foram fornecidos pelas autoridades responsáveis, o que impediu uma análise estatística mais completa. Essa ausência de informações dificultou a comparação de certos indicadores entre os casos analisados.

No aspecto qualitativo, as dificuldades se concentraram na realização de entrevistas com os profissionais de saúde, pois parte do estudo ocorreu durante um período de ampliação da Atenção Básica e de mudanças na gestão das USFs, fatores que impactaram a disponibilidade e a estabilidade desses profissionais. Vários profissionais estavam passando por processos de redistribuição ou ajustando-se às novas diretrizes organizacionais, o que dificultou sua participação na pesquisa e resultou em um número de entrevistas inferior ao planejado. Essa restrição não apenas diminuiu a variedade de perspectivas coletadas, mas também pode ter introduzido vieses relacionados ao perfil dos profissionais que estavam disponíveis.

Embora os resultados alcançados estejam alinhados com os objetivos estabelecidos, a identificação desses desafios metodológicos promove a transparência na pesquisa e ressalta a necessidade de fortalecer a articulação entre gestão e pesquisa, garantindo acesso contínuo a

bancos de dados abrangentes e estabelecendo condições institucionais que incentivem a participação ativa dos profissionais de saúde em pesquisas avaliativas.

Como desdobramento, futuras pesquisas devem investir em ensaios híbridos que avaliem simultaneamente a efetividade e as estratégias de implementação de intervenções em primeira infância, testando mecanismos como convocação ativa, apoio matricial, uso de dados em tempo real e supervisão participativa. Estudos em escala poderiam estimar o impacto populacional da UAPI em indicadores de desenvolvimento infantil e uso de serviços preventivos. Além disso, recomenda-se o acompanhamento longitudinal de unidades certificadas e não certificadas, investigando fatores que determinam a perda ou manutenção da certificação. A análise de custos e de tempo de trabalho, bem como o uso de modelos realistas, pode enriquecer a compreensão dos mecanismos de implementação e das condições contextuais que sustentam o sucesso da política.

Entre as limitações deste estudo, destaca-se, inicialmente, o desenho comparativo restrito a duas Unidades de Saúde da Família, inseridas em contextos organizacionais distintos, o que limita a possibilidade de generalização dos achados para outros cenários da Atenção Primária. No que se refere aos dados quantitativos, a utilização de registros administrativos implica restrições quanto à qualidade e à completude das informações, evidenciadas por séries temporais incompletas e irregulares ao longo do período analisado. Ademais, as condições do campo empírico também influenciaram o desenvolvimento da pesquisa, especialmente em razão da rotatividade de profissionais e das mudanças na gestão local, que impactaram tanto o acesso aos dados quanto a realização das entrevistas.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da implementação da Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância em duas Unidades de Saúde da Família do Recife evidenciou como uma política pública voltada ao desenvolvimento infantil é traduzida em práticas cotidianas na APS. A iniciativa despertou novos olhares sobre o cuidado à criança e ampliou a percepção dos profissionais acerca do desenvolvimento integral como eixo estruturante das ações. As capacitações do ciclo inicial foram reconhecidas como momentos relevantes de sensibilização e aprendizagem, favorecendo uma abordagem mais intersetorial e humanizada da primeira infância.

Apesar disso, a ausência de continuidade dos ciclos formativos, as fragilidades no acompanhamento e monitoramento das ações e a rotatividade de profissionais comprometeram a implementação e a manutenção das atividades de apoio às famílias. Esses achados indicam a necessidade de transformar formações pontuais em processos permanentes de educação, acompanhados de indicadores quantitativos e qualitativos que permitam avaliar seus impactos. Ao mesmo tempo, o estudo mostrou que o êxito das ações depende fortemente do contexto territorial, marcado por vulnerabilidades sociais que interferem na adesão das famílias e na execução das atividades planejadas.

Nesse sentido, políticas públicas efetivas são aquelas capazes de reconhecer as condições locais, valorizar saberes comunitários e integrar diferentes setores por meio de mecanismos de governança que tornem a intersetorialidade uma prática cotidiana. As diferenças observadas entre as unidades demonstram que fatores como infraestrutura física, vínculos entre equipes e usuários e coesão comunitária exercem influência direta sobre os resultados, reforçando a importância de considerar as singularidades dos territórios no planejamento municipal. Direcionar recursos e apoio técnico de forma equitativa torna-se indispensável para responder adequadamente às necessidades identificadas.

Os resultados também apontam para a necessidade de consolidar a UAPI como política de Estado, e não apenas de gestão. A institucionalização da iniciativa nos instrumentos de planejamento e a criação de estruturas técnicas responsáveis pelo acompanhamento e avaliação são fundamentais para garantir coerência, continuidade e sustentabilidade das ações ao longo do tempo. Além disso, a estabilidade das equipes e o fortalecimento do diálogo com as famílias surgem como elementos centrais, uma vez que a rotatividade fragiliza vínculos e dispersa

aprendizados. Investir em estratégias comunicativas próximas e afetivas pode favorecer o pertencimento e a corresponsabilização comunitária, contribuindo para que o cuidado à criança seja integral, equitativo e sustentável.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. G.; KFOURI, R. A.; PASTERNAK, N. T.; LIMA, E. J. F.; PILATI, R. Assessing vaccine hesitancy among healthcare providers in Brazil: the influence of vaccine status and professional experience. **Jornal de Pediatria**, v. 101, n. 2, p. 216-223, 2025.
- ALVES, C. O.; MENDONÇA, E. S.; FERREIRA, J. A.; SANTANA, M. F.; NOGUEIRA, P. H.; SOUZA, R. L.; MOURA, T. L.; MARTINS, V. S. Empoderamento de mulheres negras: avaliação de necessidades a partir do modelo RE-AIM. **Psicologia USP**, v. 36, p. e220155, 2025.
- AMARAL, V. L.; SPADOTTO, G. C.; GOMES, C. B. Conhecimento, atitudes e práticas de profissionais da atenção primária sobre o guia alimentar para crianças até 2 anos: estudo transversal, Botucatu, São Paulo, 2023. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20240111, 2024.
- AMORIM, L. P.; MORAIS, C. F. A.; COSTA, D. R. S.; PEREIRA, T. A. R.; et al. Filling process of the child health record in health care services of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 27, 2018.
- ANDRADE, M.; GALINA, G. R.; DOTTO, M. G. Puericultura odontológica: avaliação do conhecimento das mães na atenção primária em saúde e orientações. **Santé – Cadernos de Ciências da Saúde**, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 7–26, 2023. DOI: 10.51909/sante.v2i1.2023.
- ANDRADE, R. S.; CARNEIRO, T. F.; LIMA, V. P.; SOUZA, M. F. Ambientes virtuais de aprendizagem e formação em serviço na Atenção Primária à Saúde: potencialidades e limites. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 47, n. 1, e190, 2023. DOI: 10.1590/1981-5271v47.1-20220367.
- ARAÚJO, J. P.; SILVA, R. M. M.; COLLET, N.; NEVES, E. T.; TOSO, B. R. G. O.; VIERA, C. S. História da saúde da criança: conquistas, políticas e perspectivas. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 67, n. 6, p. 1000-1007, 2014.
- ARRAIS, M. G. S.; RONCALLI, A. G.; ROSENDO, T. S. Qualidade da assistência à saúde bucal na Atenção Primária no Brasil. Physis: **Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 2, p. e310203, 2021. DOI: 10.1590/S0103-73312021310203.
- AVGERINOU, C.; KOTSANI, M.; GAVANA, M.; ANDREOU, M.; PAPAGEORGIOU, D. I.; ROKA, V.; SYMINTIRIDOU, D.; MANOLAKI, C.; SOULIS, G.; SMYRNAKIS, E. Perceptions, attitudes and training needs of primary healthcare professionals in identifying and managing frailty: a qualitative study. **European Geriatric Medicine**, v. 12, n. 2, p. 321–332, 2021. DOI: 10.1007/s41999-020-00420-0.
- BAEK, Y.; FISHER, J.; TRAN, T.; OWEN, A.; NGUYEN, T.; LUCHTERS, S.; HIPGRAVE, D. B.; HANIEH, S.; TRAN, T.; HA, T. T. T.; BIGGS, B. A.; ADEMI, Z. Economic returns on investing in early childhood development in Vietnam: a cost-benefit analysis. **BMC Health Services Research**, v. 25, n. 1, art. 384, 15 mar. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12516-z>
- BALDANI, M. H.; SANTOS, C. M.; ANTUNES, J. L. F.; SOUSA, M. L. Primary dental care

in Brazil: from prevention to comprehensive care. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 37, n. 8, e00060520, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00060520.

BISPO JÚNIOR, J. P.; ALMEIDA, E. R. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS (EMULTI): Potencialidades e desafios para a ampliação da atenção primária à saúde no Brasil. *Cadernos de saúde pública*, V. 39, P. E00120123, 2023.

BLACK, M. M.; TRUDE, A. C. B.; KOWALSKI, A. J. Growth in the first 1000 days lays the foundation for human capital formation. *American Journal of Clinical Nutrition*, v. 113, n. 4, p. 767-768, 6 abr. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa426>

BLACK, M. M.; WALKER, S. P.; FERNALD, L. C. H.; ANDERSEN, C. T.; et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, v. 389, p. 77-90, 2017. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31389-7.

BLACK, M. M.; WALKER, S. P.; FERNALD, L. C. H.; ANDERSEN, C. T.; DIAS, J. C.; GRANTHAM-MCGREGOR, S.; LU, C.; FERNALD, L.; IRAZOLA, V.; STEIN, A.; KURZWEIL, M.; FIELDS, R.; MCCOY, D. C.; FINK, G.; HARTINGER, S.; DEWORME, J.; GRANDE, J. Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, v. 389, n. 10064, p. 77-90, 2017. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31389-7.

BORGES, J. P. A.; SANTOS, L. A. dos; SIMÕES, A. L. de A. Indicadores de qualidade na assistência à saúde da criança na atenção primária a saúde: uma revisão integrativa/Quality indicators in children's health care in primary health care: an integrative review. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 7101–7116, 2020. DOI: 10.34119/bjhrv3n3-241.

BRASIL. Decreto nº 12.574, de 5 de agosto de 2025. Institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNPI). *Diário Oficial da União*, Brasília, 6 ago. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/D12574.htm.

_____. Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016. Institui o Programa Criança Feliz. *Diário Oficial da União*, Brasília, n. 193, Seção 1, p. 2, 6 out. 2016. Disponível em: <http://www.in.gov.br/autenticidade.html?codigo=00012016100600002>.

_____. Marco Legal pela Primeira Infância, Lei nº 13.257 de 2016. Conteúdo disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 149, p. 37, 7 ago. 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.htm.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 180 p. ISBN 978-85-334-2596-5.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). Disponível

em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps>. Acesso em: 2 nov. 2025.

_____. Município do Recife. Lei n. 18.769, de 23 de dezembro de 2020. Institui o Primeiro Plano Decenal para a Primeira Infância do Recife, para o período de 2020 a 2030. Diário Oficial do Município do Recife, Recife, ed. extraordinária n.º 144, 31 dez. 2020. Disponível em:

https://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/plano_decenal_para_a_primeira_infancia-3.pdf.

_____. Plano Nacional pela Primeira Infância: versão atualizada 2020. Brasília: Rede Nacional Primeira Infância, 2020. Disponível em: <https://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/PNPI.pdf>. Acesso em: 9 set. 2025.

_____. Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente: diretrizes para a organização da atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 5 nov. 2025.

_____. Programa Brasil Carinhoso: transferência automática de recursos financeiros para manutenção e desenvolvimento da educação infantil, 2012. Disponível em:

<https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/brasil-carinhoso>. Acesso em: 9 set. 2025.

BRITO, A. E. R. M. A incompletude institucional e a intersetorialidade na política de atenção à criança e ao adolescente no município de Recife. 2020. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

BROWN, M.; ROMAN, N. V. Using the RE-AIM framework to identify and describe nutritional feeding styles and intervention model best practices for primary caregivers in Africa: a narrative review. **Nutrition and Health**, v. 27, n. 2, p. 171-180, jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/0260106020977053>.

BUCCINI, G.; CARVALHO, D.; CUNHA, A. J. L. A.; VENANCIO, S. I. Nurturing care indicators for the Brazilian Early Childhood Friendly Municipal Index (IMAPI). **Maternal & Child Nutrition**, v. 18, p. e13155, 2022.

BUCHANAN, G.; TRAN, M.; KHAN, Z.; et al. Framework for implementing parenting programs in primary care. **Academic Pediatrics**, v. 23, n. 4, p. 423-431, 2023.

BUENO, M. Tradução do conhecimento, ciência da implementação e enfermagem. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 11, 2021.

CACHIA, A.; MANGIN, J.-F.; DUBOIS, J. Mapping the Human Brain from the Prenatal Period to Infancy Using 3D Magnetic Resonance Imaging. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2504.21406>>. Acesso em: 11 set. 2025.

CAPIO, C. M.; MACKINLAY, S.; PERRY, J. R.; HOWARD, H.; HODGE, K.; CAPIO, J. L.; SIMPSON, A.; NELSON, T.; BURNS, Y. R. The contributions of motor skill proficiency to cognitive and social development in early childhood. **Scientific Reports**, v. 14, art. 2245, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-79538-1.

CASTANHEIRA, E. R. L.; GIOVANELLA, L.; MALTA, D. C.; MOROSINI, M. V. G. C.; MENDES, A.; BOSI, M. L. M. Organização da atenção primária à saúde de municípios de São Paulo, Brasil: modelo de atenção e coerência com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 40, p. PT099723, 2024.

CAVALCANTE, L. B. O.; COSTA, L. F.; TAVARES, R. R. Parentalidade positiva e o desenvolvimento infantil: reflexões para a prática em saúde. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 9, n. 3, p. 391-403, 2020. DOI: 10.17267/2317-3394rpdsv9i3.3126.

CAVALHEIRO, A. P. G.; SILVA, C. L.; VERÍSSIMO, M. L. O. R. Consulta de enfermagem à criança: atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde. **Enferm Foco**, v. 12, n. 3, p. 540-545, 2021.

CHEN, E.; NETA, G.; ROBERTS, M. C. Complementary approaches to problem solving in healthcare and public health: implementation science and human-centered design. **Translational Behavioral Medicine**, v. 11, n. 5, p. 1115-1121, 2021. DOI: 10.1093/tbm/ibaa079.

CHEN, S.; ZHANG, L.; LI, M.; GAO, Y.; WANG, X.; LIU, Q.; ZHANG, H. Guaranteeing the Achievement of Sustainable Development Goals 3 and 4: The Case of Temporary Guardianship to Support Children's Health, Well-Being and Sustainable Development During the COVID-19 Pandemic in China. **Sustainability**, v. 16, n. 13, art. 5672, 2024. DOI: 10.3390/su1613567.

CHEN, X.; LEE, W.; LIN, F. Infodemic, institutional trust, and COVID-19 vaccine hesitancy: a cross-national survey. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 19, n. 13, p. 8033, 2022. DOI: 10.3390/ijerph19138033.

CHOMA, E. A.; TREAT-JACOBSON, D. J.; KELLER-ROSS, M. L.; WOLFSON, J.; MARTIN, L.; MCMAHON, S. K. Using the RE-AIM framework to evaluate physical activity-based fall prevention interventions in older adults with chronic conditions: a systematic review. **Translational Behavioral Medicine**, v. 13, n. 1, p. 42-52, 2023. DOI: 10.1093/tbm/ibac072.

CHRISTOFFEL, M. M.; CAÇADOR, B. S.; SANTOS, R. M.; ANDRADE, R. D.; REIS, A. O. A. Aleitamento materno exclusivo e os profissionais da Estratégia Saúde da Família. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, p. e20200545, 2021.

CHRISTOFFEL, M. M.; MORAES, B. A.; CARVALHO, D. F.; SOUZA, S. N. D. H.; BONILHA, A. L. L. Exclusive breastfeeding and professionals from the Family Health Strategy. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 75, e20200545, 2021. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0545.

COLETA, A. V. R.; ALMEIDA, M. F. S.; OLIVEIRA, L. P.; SANTOS, R. C. Ação da Atenção Primária no diagnóstico e tratamento de sífilis na gestação. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 5, p. 21165–21179, 2021.

COSTA, N. M. G. B.; LIMA, A. P. S.; MENDES, F. C. L.; GONÇALVES, R. T.; PEREIRA, T. O. S. Impactos do programa brasil carinhoso na educação, saúde e renda. **Conexões – Ciência e Tecnologia**, v. 15, p. e021022-e021022, 2021.

COUTINHO, S. E. D.; BARBIERI, A. R.; SANTOS, A. A. P.; SAMPAIO, K. K. O.;

SANTOS, M. C.; FONSECA, R. M. C. T. Avaliação em saúde: dimensão processual e estrutural da saúde da criança na atenção primária. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 44, n. 124, p. 115-129, 2020. DOI: 10.1590/0103-1104202012408. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Khq9T7zGx7Ght7pY6cW6m9c/?lang=pt>. Acesso em: 11 set. 2025.

CRESPI, L.; NORO, D.; NÓBILE, M. F. Neurodesenvolvimento na Primeira Infância: aspectos significativos para o atendimento escolar na Educação Infantil. **Ensino em Re-Vista**, p. 1517–1541, 28 set. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14393/ER-v27nEa2020-15>.

CRESPI, L.; NORO, D.; NÓBILE, M. Políticas públicas para a primeira infância: fundamentos para a valorização do desenvolvimento neurobiológico infantil. **Educação Online**, v. 18, n. 42, p. e231808–e231808, 11 abr. 2023.

CRISTOVAM, B. S.; FERREIRA, L. C.; NASCIMENTO, M. E. A.; LOPES, C. M. Impactos da insegurança alimentar e nutricional no desenvolvimento infantil. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 47, p. e14876, 2024. DOI: 10.25248/reac.e14876.2024.

D'LIMA, D.; SOUKUP, T.; HULL, L. Evaluating the application of the RE-AIM planning and evaluation framework: an updated systematic review and exploration of pragmatic application. **Frontiers in Public Health**, v. 9, p. 755738, 2022.

DAELMANS, B.; MANJI, S. A.; RAINA, N. Nurturing Care for early childhood development: global perspective and guidance. *Indian Pediatrics*, New Delhi, v. 15, n. 58, p. 11-15, 2021. Disponível em: <https://www.indianpediatrics.net/supplOct2021/S11.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2023.

DAMASCENO, S. S.; VIEIRA, C. M.; PINTO, V. R.; OLIVEIRA, P. M.; CARVALHO, J. A.; et al. Atenção primária à saúde e o cuidado à criança no Brasil: avanços e desafios a partir da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 4, e00012345, abr. 2016. DOI: 10.1590/0102-311X00012345.

DRAPER, C. E.; YOUSAFZAI, A. K.; MCCOY, D. C.; CUARTAS, J.; OBRADOVIĆ, J.; BHOPAL, S.; FISHER, J.; JEONG, J.; KLINGBERG, S.; MILNER, K.; PISANI, L.; ROY, A.; SEIDEN, J.; SUDFELD, C. R.; WROTTESLEY, S. V.; FINK, G.; NORES, M. M.; TREMBLAY, M. S.; OKELY, A. D. The next 1000 days: building on early investments for the health and development of young children. **The Lancet**, Londres, v. 404, n. 10467, p. 2094-2116, 18 nov. 2024. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01389-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01389-8).

EBRAHIMI, N.; SHAHIN, S.; KOOLAJI, S.; GHANBARI, A.; MEHDIPOUR, P.; MASINAEI, M.; SAEEDI MOGHADDAM, S.; REZAEI, N.; GHAMARI, A.; MALEKPOUR, M. Predicting Iran's achievement to Sustainable Development Goal 3.2: a systematic analysis of neonatal mortality with scenario-based projections to 2030. **PLOS ONE**, v. 18, n. 4, e0283784, abr. 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0283784.

EGRY, E. Y.; APOSTOLICO, M. R.; MORAIS, T. C. P. Notificação da violência infantil, fluxos de atenção e processo de trabalho dos profissionais da Atenção Primária em Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 83-92, 2018.

ENGLE, P. L.; FERNALD, L. C. H.; ALDERMAN, H.; BEHRMAN, J.; O'GARA, C.;

YOUSAFZAI, A.; DE MELLO, M. C.; HIDALGO, A.; MUNN-CHERNOFF, M.; CRUICKSHANK, K.; FINK, G.; GALASSO, E.; LOZOFF, B.; MARTORELL, R.; RICHTER, L.; WALKER, S. P. Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries. **The Lancet**, Londres, v. 378, n. 9799, p. 1339-1353, out. 2011. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60889-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60889-1)

ERKU, D.; KHATRI, R.; ENDALAMAW, A.; WOLKA, E.; NIGATU, F.; ZEWDIE, A.; ASSEFA, Y. Digital health interventions to improve access to and quality of primary health care services: a scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 19, p. 6854, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20196854.

ESHRIQUI, I.; CORDEIRO, L.; ALMEIDA, L. Y.; SOUSA, A. A. F.; PAIVA NETO, F. T.; VESGA-VARELA, A. L.; TEODORO, C. S.; BONFIM, D.; et al. Utilizando ciência da implementação para avaliar intervenção em saúde mental: proposta metodológica. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 36, supl. 1, p. eAPESPE01954, 2023. DOI: 10.37689/acta-ape/2023AOSPE019544.

ESLINGER, P. J.; ANDERS, S.; BALLARINI, T.; BOUTROS, S.; KRACH, S.; MAYER, A. V.; MOLL, J.; NEWTON, T. L.; SCHROETER, M. L.; DE OLIVEIRA-SOUZA, R.; RABER, J.; SULLIVAN, G. B.; SWAIN, J. E.; LOWE, L.; ZAHN, R. FARIA, E. R.; SILVA, D. D. F. D.; PASSBERG, L. Z. Factors related to exclusive breastfeeding in the context of Primary Health Care. **CoDAS**, São Paulo, v. 35, n. 5, e20210163, 2023. DOI: 10.1590/2317-1782/20232021163pt.

FARIA, E. R.; SILVA, D. D. F.; PASSBERG, L. Z. Fatores relacionados ao aleitamento materno exclusivo no contexto da Atenção Primária à Saúde. **CoDAS**, v. 35, p. e20210163, 2023.

FERNANDES, P. C. C.; SANTOS, M. A. F.; LIMA, G. R.; COSTA, L. S.; OLIVEIRA, R. M.; SOUZA, T. R. A puericultura nas diversas regiões do Brasil e a importância da equipe multiprofissional: uma revisão integrativa. **Revista Contemporânea, São Paulo**, v. 3, n. 11, p. 22098–22119, 2023. DOI: 10.56083/rcv3n11-00.

FERNANDES, P. C. C.; SANTOS, M. A. F.; LIMA, G. R.; COSTA, L. S.; OLIVEIRA, R. M.; SOUZA, T. R. Puericultura no Brasil: definição, história e conquistas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 9, n. 6, p. 746–755, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i6.1123

FERRONATO, J.; KINOSHITA, J.; FONSECA, F.; BRUNETTA, P.; ALMEIDA, M. R.; SANTOS, L. C. Interprofessional collaboration in primary healthcare: experiences from Brazilian family health teams. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 10, e00160021, 2023. DOI: 10.1590/0102-311X00160021

FREITAS, M.; PEREIRA, E. R. O diário de campo e suas possibilidades. **Cadernos de Psicologia**, v. 20, n. 3, p. 235-244, 2018.

FUNAYAMA, André Rodrigues; CYRINO, Eliana Goldfarb; GARCIA, Maria Alice Amorim. Atuação profissional em práticas de promoção da saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa. **Revista de Atenção Primária à Saúde**, v. 25, 2022.

FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL. Panorama da primeira infância: edição 2025. São Paulo: FMCSV, 2023. Disponível em: <https://www.fmcsv.org.br>.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Guia metodológico UAPI: ciclo 2025-2028. Brasília, DF: UNICEF, 2025. Disponível em: [inserir link]. Acesso em: 12 de dezembro de 2025.

GALVÃO, M. H. R.; MEDEIROS, A. A.; RONCALLI, A. G. Contextual and individual factors associated with public dental services utilisation in Brazil: a multilevel analysis. **PLoS One**, San Francisco, v. 16, n. 7, p. e0254310, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0254310.1.

GANCE-CLEVELAND, B.; FRENN, M.; BROWNE, N.; GREENBERG, C. S.; SNEHTEN, J. A.; BROOME, M. E.; IRVING, S. Y. A scoping review of the role of policy in mitigating childhood obesity in underserved populations using the RE-AIM framework. **Worldviews on Evidence-Based Nursing**, v. 21, n. 4, p. 445-453, 2024.

GEEHOLED, E.; SAVONA, N.; BONELL, C.; HAINES, A.; ROBERTS, I. Long-term economic outcomes for interventions in early childhood: protocol for a systematic review. **BMJ Open**, v. 10, art. e036647, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036647>.

GIRADE, H. Criança Feliz': A programme to break the cycle of poverty and reduce the inequality in Brazil. *Early Childhood Matters*, n. 127, 2018.

GISONDI, M. A.; CHAMBERS, D.; LA, T. M.; RYAN, A.; SHANKAR, A.; XUE, A.; BARBER, R. A. A Stanford Conference on Social Media, Ethics, and COVID-19 Misinformation (INFODEMIC): qualitative thematic analysis. *Journal of Medical Internet Research*, Toronto, v. 24, n. 2, e35707, 2022. DOI: 10.2196/35707.

GLASGOW, R. E.; HARDEN, S. M.; GAGLIO, B.; RABIN, B.; SMITH, M. L.; PORTZ, J. D.; FERRIS, D.; BALLARD, D.; MASSEY, C. N.; O'NEILL, K.; ESTABROOKS, P. A.; KESSLER, R. S. Use of the reach, effectiveness, adoption, implementation, and maintenance (RE-AIM) framework to guide iterative adaptations: applications, lessons learned, and future directions. **Frontiers in Health Services**, v. 2, p. 959565, 2022.

GOULART, S.; RAVAZZANI, E. D. A. A influência de programas brasileiros de transferência de renda na qualidade da dieta e na segurança alimentar dos beneficiários. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição – RASBRAN**, São Paulo, v. 15, p. 1–13, 2024. DOI: 10.47320/rasbran.2024.2717.

GROUP, W. B. Aproximadamente 350 Milhões de Crianças no Mundo Carecem de Cuidados de Qualidade. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2021/03/04/nearly-350-million-children-lack-quality-childcare-in-the-world>>. Acesso em: 11 set. 2025.

GUBERT, F. A.; VIEIRA, N. F. C.; PINHEIRO, P. N. C.; ALMEIDA, P. C.; ARAÚJO, T. M. de; RODRIGUES, D. P. Qualidade da Atenção Primária à Saúde infantil em estados da região Nordeste. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 1757–1766, 2021.

HECKMAN, JAMES J. Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. **Science**, Washington, v. 312, n. 5782, p. 1900-1902, 30 jun. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1128898>

HILÁRIO, J. S. M.; ALMEIDA, L. R. S.; MOURA, R. P.; LOPES, C. A. B. O.; SOUZA, D. C. C.; MARTINS, F. P. L. Parentalidade e estímulo ao desenvolvimento infantil em domicílio: perspectivas do Nurturing Care. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 33, p. e4611, 2025.

HILÁRIO, J. S. M.; OLIVEIRA, A. P. R.; SOUSA, T. C. A.; LIMA, V. C. Desenvolvimento infantil e visita domiciliar na primeira infância: mapa conceitual. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p. eAPE003652, 2022.

HOAGWOOD, K. E.; PURTLE, J.; SPANDORFER, J.; PETH-PIERCE, R.; HORWITZ, S. M. Aligning dissemination and implementation science with health policies to improve children's mental health. **American Psychologist**, v. 75, n. 8, p. 1130-1145, 2020. DOI: 10.1037/amp0000706. PMID: 33252950; PMCID: PMC8034490.

HODGSON, W.; KIRK, A.; LENNON, M.; JANSSEN, X.; RUSSELL, E.; WANI, C.; ESKANDARANI, D. RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, and Maintenance) evaluation of the use of activity trackers in the clinical care of adults diagnosed with a chronic disease: integrative systematic review. **Journal of Medical Internet Research**, v. 25, e44919, 2023. DOI: 10.2196/44919.

HONE, T.; MACINKO, J.; MILLETT, C. Revisiting Alma-Ata: what is the role of primary health care in achieving the Sustainable Development Goals?. **The Lancet**, v. 392, n. 10156, p. 1461-1472, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recife: panorama. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/recife/panorama>. Acesso em: 24 mar. 2026.

LANG, C.; ZHU, Q.; WANG, X.; WANG, L.; ZHANG, J.; ZHAO, L.; LI, H.; WU, SICHROMY, U. R.; SURYAWAN, A.; IRMAWATI, M. Correlation of responsive caregiving with child development. **Journal of Public Health and Pharmacy**, v. 5, n. 1, p. 64-71, 2025.

IMPrensa NACIONAL. DECRETO No 12.574, DE 5 DE AGOSTO DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.574-de-5-de-agosto-de-2025-646726880>>. Acesso em: 11 set. 2025.

INDRIO, F.; COSTA, L.; PINNA, M.; BASSI, M.; et al. The importance of strengthening mother and child health services during the first 1000 days of life: the foundation of optimum health, growth and development. **Journal of Pediatrics**, 2022.

JAFREE, S. R.; BUKHARI, N.; MUZAMILL, A.; TASNEEM, F.; FISCHER, F. Digital health literacy intervention to support maternal, child and family health in primary healthcare settings of Pakistan during the age of coronavirus: study protocol for a randomised controlled trial. **BMJ Open**, Londres, v. 11, n. 3, e045163, 2021. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-045163.

JEONG, J.; BLIZNASHKA, L.; SULLIVAN, E.; HENTSCHEL, E.; JEON, Y.; STRONG, K. L.; DAELMANS, B. Measurement tools and indicators for assessing nurturing care for early childhood development: a scoping review. **PLOS Global Public Health**, v. 2, n. 4, p. e0000373, 25 abr. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000373>.

JIANG, C.; LI, X.; DU, B.-C.; HUANG, J.; LI, Y.; ZHANG, Y.; WEI, M.; XU, X.; YANG, Y.; JIANG, H. Role of home nurturing environment on early childhood neurodevelopment: a community-based survey in Shanghai, China. *BMC Pediatrics*, London, v. 24, n. 1, p. 721, 2024.

JOLLES, M. P.; FORT, M. P.; GLASGOW, R. E. Aligning the planning, development, and implementation of complex interventions to local contexts with an equity focus: application of the PRISM/RE-AIM framework. *International Journal for Equity in Health*, v. 23, n. 1, p. 41, 2024.

JÚNIOR, E. P. P.; SOUZA, A.; BRITO, A. M.; BARRETO, M. L.; LIMA, R. T. M.; SHIMIZU, H. E.; VIANA, A. L. A.; SILVA, L. J. F. Efeito da Estratégia Saúde da Família nas internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de um ano na Bahia, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro*, v. 34, n. 1, e00133816, 2018. DOI: 10.1590/0102-311X00133816.

KANNO, N. P.; GALVANESE, A. T. C.; SANCHES, V. S.; SILVA, M. M. B.; FRACOLLI, L. A. A colaboração interprofissional na atenção primária à saúde na perspectiva da ciência da implementação. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 39, n. 10, p. e00213322, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT213322>.

KAWUKI, J.; CHEN, S.; FANG, Y.; LIANG, X.; CHAN, P. S.; WANG, Z. COVID-19 vaccine acceptance, attitude and perception among slum and underserved communities: a systematic review and meta-analysis. *Vaccines (Basel)*, Basel, v. 11, n. 5, p. 886, 2023.

KHADJESARI, Z.; BOUFGHED, S.; VITORATOU, S.; SCHATTE, L.; ZIEMANN, A.; DASKALOPOULOU, C.; UGLIK-MARUCHA, E.; SEVDALIS, N.; HULL, L. Implementation outcome instruments for use in physical healthcare settings: a systematic review. *Implementation Science*, v. 15, art. 66, 2020.

LANE, H. G.; TURNER, L.; DUNN, C. G.; HAGER, E. R.; FLEISCHHACKER, S. Leveraging implementation science in the public health response to COVID-19: child food insecurity and federal nutrition assistance programs. *Public Health Reports*, v. 135, n. 6, p. 728-736, 2020. DOI: 10.1177/0033354920959285.

LIKHAR, A.; BAGHEL, P.; PATIL, M. Early Childhood Development and Social Determinants. *Cureus*, v. 14, n. 9, p. 1–6, 2022.

LIMA, S. S. ; DOMINGUES, R. M. S. M.; SILVA, A. A. M.; BETTIOL, H.; BARROS, F. C.; LIMA, D. C. A.; ALMEIDA, M. F.; GONÇALVES, A. C. S.; LEAL, M. C. Avaliação do impacto de programas de assistência pré-natal, parto e ao recém-nascido nas mortes neonatais evitáveis em Pernambuco, Brasil: estudo de adequação. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 2, p. e00039719, 2020.

LOPES, A. S. A.; BLANCO, M.; SMITH, J. P.; DOS SANTOS, C. M. Early-life mortality rates in Brazil and progress toward Sustainable Development Goal 3.2: under-five and neonatal mortality trends. *The Lancet Regional Health – Americas*, 2025.

LOPES, L. M.; BARROS, E. A.; FERREIRA, A. C.; SILVA, C. G. Tecnologias digitais e educação permanente na Atenção Primária à Saúde: experiências e desafios na formação de

profissionais. *Interface: Comunicação, Saúde, Educação*, Botucatu, v. 25, e210077, 2021. DOI: 10.1590/interface.210077.

MACHADO, F. C. A.; OLIVEIRA, M. R. C.; GOMES, L. B.; LIMA, M. G. A.; et al. Intersetorialidade na promoção da saúde da criança e do adolescente: uma experiência da integração ensino-serviço. **Revista Ciência Plural**, v. 7, n. 3, p. 308-327, 2021.

MACHADO, M. E. D.; CAVALCANTE, R. B.; SILVA, M. C. F.; NASCIMENTO, A. F. Health professionals' breastfeeding practices and associated factors: a cross-sectional study. **Online Brazilian Journal of Nursing**, Niterói, v. 22, e6646, 2023. DOI: 10.17665/1676-4285.20236646.

MACINKO, J.; MENDONÇA, C. S. Estratégia Saúde da Família, um forte modelo de Atenção Primária à Saúde que traz resultados. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 18-37, 2018.

MANGIALAVORI, G. L.; AGOST, L. A.; GÓMEZ, C. R.; SANTOS, J. L.; LÓPEZ, A. M.; CASTILLO, M. E. Prevalence of breastfeeding in the public health sector of Argentina according to the National Survey on Breastfeeding of 2017. **Archivos Argentinos de Pediatría**, Buenos Aires, v. 120, n. 3, p. 152–157, 2022. DOI: 10.5546/aap.2022.152.

MARINHO, C. S. R.; CUNHA, C. C.; CAMPOS, M. R.; MEDRONHO, R. A. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: impacto de ações assistenciais e mudanças socioeconômicas e sanitárias na mortalidade de crianças. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00191219, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00191219>.

MAROJA, M. C. S.; SILVA, A. T. M. C. da; CARVALHO, A. T. de. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: uma análise a partir das concepções de profissionais quanto às suas práticas. *Revista Portuguesa de Saúde Pública*, Lisboa, v. 32, n. 1, p. 3–9, mar. 2014.

MARTINS, E. J.; GIUGLIANI, E. R. J.; VICTORA, C. G. Support from health professionals and exclusive breastfeeding: evidence from a cohort study in Southern Brazil. **International Breastfeeding Journal**, London, v. 18, n. 1, p. 15, 2023. DOI: 10.1186/s13006-023-00549-9.

MEIRA, C. A. R.; BUCCINI, G.; AZEREDO, C. M.; CONDE, W. L.; RINALDI, A. E. M. Evolution of breastfeeding indicators and early introduction of foods in Latin American and Caribbean countries in the decades of 1990, 2000 and 2010. **International Breastfeeding Journal**, London, v. 17, n. 1, p. 32, 2022. DOI: 10.1186/s13006-022-00476-9.

MENDES, A. C. A.; BARBOSA, M. F. S.; LOPES, F. A. P.; OLIVEIRA, J. M. T.; FIGUEIREDO, L. S.; NASCIMENTO, R. M. Promoção em saúde para condutas de hábitos saudáveis para redução de diabetes tipo II e hipertensão na atenção primária. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 6, n. 13, p. 1773-1792, 2023.

MENDES, G. N.; SANTOS, M. T.; FERREIRA, J. R.; MARTINS, A. C. S.; SILVA, L. C. S.; BARROS, L. M.; MENDES, I. V. G.; FREITAS, M. C. Educação continuada e permanente na atenção primária de saúde: uma necessidade multiprofissional. **Cenas Educacionais**, v. 4, p. e12113, 2021.

MENDONÇA, E. M.; LANZA, F. M. Perspectivas da intersetorialidade no cotidiano da Atenção Primária à Saúde no Brasil: uma reflexão teórica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, e2549119834, nov. 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.9834.

MENEZES, C. M.; SANTOS, R. V.; GAVAZZA, M. C. Análise situacional de saúde da primeira infância. **Revista de Saúde Coletiva da UEFS**, v. 11, n. 1, p. e5464-e5464, 2021. DOI: <https://doi.org/10.13102/rscdauefs.v11i1.5464>.

MILLÁN, M. C. D.; PÉREZ, M. M. M.; LONDOÑO, S. Y. R.; HERNÁNDEZ, D. C. P. Violencia intrafamiliar: un riesgo para el desarrollo de la primera infancia. **Revista Colombiana de Ciencias Sociales**, Medellín, v. 13, n. 1, p. 77-101, 2022. DOI: 10.21501/22161201.4069.

MISHRA, M. K.; SHRIVASTAVA, N. K.; KOLANDAISAMY, I. A study on the impact of child poverty on children's cognitive and social-emotional development. **Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities**, v. 6, p. 1550-1555, 2023.

MODJADJI, P.; MADIBA, S.; NDLOVU, S. Beliefs and norms influencing initiation and sustenance of exclusive breastfeeding: experiences of mothers in primary health care facilities in Ermelo, South Africa. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 20, n. 2, p. 1513, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20021513.

MOURA, A. G.; ARAÚJO, C. M.; SILVA, C. P. A. Parentalidade positiva e prevenção da violência contra crianças: contribuições para a enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, supl. 4, e20200878, 2021. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0878.

MULEVA, Belarmina Reis. Qualidade da assistência pré-natal em Nampula, Moçambique. 2020. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7143/tde-25022021-132650/>

MUNIZ, M. P. G.; CAMPOS, M. A. O.; PAQUIELA, E. O. A.; FIGUEIREDO, E. B. L.; SOUZA, Â. C.; SILVA, C. F. Primeira infância e promoção da parentalidade positiva e saúde mental. **Revista DELOS, Curitiba**, v. 18, n. 63, p. 1-12, 2025. DOI: 10.55905/rdelosv18.n63-026.

NEVES, A. B. B.; ROCHA, C. F.; OLIVEIRA, T. S.; SANTOS, P. L.; VASCONCELOS, D. J. Temporal trends in vaccination coverage in the first year of life in Brazil. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 42, p. e2023020, 2023.

NIJHOF, S. L.; KRUK, T.; VAN MOL, M.; RIETZTA, F. S.; BAKKER, M.; MULDER, J.; KUYPERS, K.; VERHAALLEN, M. J. A.; VAN DER VELDE, J.; ROUWENHORST-MARCUS, J.; KORF, F.; KAMP, I. van de; LAURENT, D.; VIERHUIS, A.; VAN DER PUTTEN, A. A. The importance of play for the development of children in pediatric health: stimulating play behaviour enhances adaptability and promotes cognitive, social, emotional and psychomotor functioning. **Early Child Development and Care**, v. 188, n. 7, p. 1063–1075, 2018. DOI: 10.1080/03004430.2018.1439484.

NOBRE, J. N. P.; SANTOS, J. N.; SANTOS, L. R.; GUEDES, S. C.; PEREIRA, L.; COSTA, J. M.; MORAIS, R. L. S. Fatores determinantes no tempo de tela de crianças na primeira infância. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 1127-1136, mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021263.00602019>

OELKE, N. D. A ciência de implementação para apoiar a pesquisa e prática de enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 45, p. e20240162, 2024.

PARADA, M. L.; PARADA, J. L. Measuring toxic stress in childhood and youth: current approaches and implications. **Journal of Pediatric Health Care**, v. 38, n. 2, p. 174-184, 2024.

PATNODE, C. D.; HENRIKSON, N. B.; WEBBER, E. M.; BLASI, P. R.; SENGHER, C. A.; GUIRGUIS-BLAKE, J. M. Breastfeeding and health outcomes for infants and children: a systematic review. **Pediatrics, Itasca**, v. 156, n. 1, e2025071516, 2025. DOI: 10.1542/peds.2025-071516.

PEDRAZA, D. F.; BRITO, D. B.; ROSÁRIO, R.; SALAROLI, L. B. Desenvolvimento de crianças pré-escolares na volta às aulas após o confinamento da COVID-19 no Brasil: development of preschool children in the return to school after the COVID-19 confinement in Brazil. **Saúde e Pesquisa**, v. 18, p. e12733, 2025.

PEDRAZA, Dixis Figueroa. Consulta de puericultura na Estratégia Saúde da Família em municípios do interior do estado da Paraíba, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, p. 2291-2302, 2023.

PERES, J. F.; GASPARINO, R. C.; BAPTISTA, S. S.; CAVICCHIOLI, M. G.; MARTINS, A. C. S. Percepções dos profissionais de saúde acerca dos fatores biopsicossocioculturais relacionados com o aleitamento materno. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 128, p. 141–151, 2021. DOI: 10.1590/0103-1104202112808.

PHILLIPS, C. A.; BARAKAT, L. P.; POLLOCK, B. H.; BAILEY, L. C.; BEIDAS, R. S. Implementation science in pediatric oncology: a narrative review and future directions. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 69, n. 4, e29579, 2022. DOI: 10.1002/pbc.29579. PMID: 35044081; PMCID: PMC8860875.

PIMENTEL, B.; PARMA, G. O. C.; TRAEBERT, E. S. A. Tendência temporal de sífilis e HIV em gestantes e a adesão ao tratamento. **Enfermagem em Foco**, Brasília, v. 15, supl. 2, p. 80–88, 2024.

PURTLE, J.; FRIELING, M.; KANE, M.; BARNES, A. J.; LENZ, C. Four very basic ways to think about policy in implementation science research. **Implementation Science Communications**, v. 4, n. 1, p. 94, 2023. DOI: 10.1186/s43058-023-00498-6.

RACEY, M.; JOVKOVIC, M.; ALLISTON, P.; SHERIFALI, D. Applying the RE-AIM implementation framework to evaluate diabetes health coaching in individuals with type 2 diabetes: a systematic review and secondary analysis. **Frontiers in Endocrinology**, v. 13, p. 1069436, 2022. DOI: 10.3389/fendo.2022.1069436.

RAMANADHAN, S.; ALEMÁN, R.; BRADLEY, C. D.; CRUZ, J. L.; SAFAEINILI, N.; SIMONDS, V.; AVELING, E. L. Using participatory implementation science to advance health equity. **Annual Review of Public Health**, v. 45, n. 1, p. 47-67, maio 2024. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-060722-024251>.

RECIFE (Câmara Municipal). Frente Parlamentar pela Primeira Infância do Recife é lançada em reunião pública. Notícia institucional, Recife, 19 ago. 2021. Disponível em: [Site da Câmara Municipal do Recife].

RECIFE (Município). 1º Relatório Detalhado Quadrimestral – 2024. Recife: Secretaria de Saúde do Recife, 2024. Disponível em:

https://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/I%20Relat%C3%B3rio%20Detalhado%20Quadrimestral%202024_da2192701b3cf06afaea44ed9621002e.pdf. Acesso em: 2 nov. 2025.

RECIFE (Município). Secretaria de Saúde. Relatório detalhado do quadrimestre anterior – 1º quadrimestre de 2024. Recife: Secretaria de Saúde, 2024.

REDDY, S. Generative AI in healthcare: an implementation science informed translational path on application, integration and governance. **Implementation Science**, v. 19, art. 27, 15 mar. 2024. DOI: 10.1186/s13012-024-01357-9.

RETICENA, K. O.; GOMES, M. F. P.; FRACOLLI, L. A. Promoção da parentalidade positiva: percepção de enfermeiros da atenção básica. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 31, p. e20220203, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2022-0203>.

RIBEIRO SILVA, R. C.; SILVA, N. J.; FELISBINO MENDES, M. S.; FALCÃO, I. R.; ANDRADE, R. C. S.; SILVA, S. A.; NILSON, E. A. F.; SPANIOL, A. M.; FIACCONE, R. L.; PAIXÃO, E.; ICHIHARA, M. Y. T.; VELASQUEZ MELENDEZ, G.; BARRETO, M. L. Social protection and the COVID-19 pandemic in Brazil: the role of cash transfer programmes in protecting children's health and nutrition. **The Lancet Regional Health: Americas, London**, v. 8, p. 100219, 2022. DOI: 10.1016/j.lana.2021.100219

RONCALLI, A. G.; LIMA, K. C.; CARDOSO, A. R. P.; SILVA, J. M. A.; OLIVEIRA, D. N. Efeito da cobertura de testes rápidos na Atenção Básica sobre a sífilis em gestantes no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 55, p. 94, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055003421.

RUELA, G. A.; ARAÚJO, L. B.; LIMA, R. T. M.; MOURA, C. C.; SILVEIRA, M. M.; MELO, F. P.; TORRES, A. P. Primary health care structure and vaccination coverage in Brazilian municipalities. **Revista de Saúde Pública**, v. 59, p. e12, 2025.

SANTOS, D. M. A. dos; GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. de; ESCOREL, S.; AQUINO, R.; MEDINA, M. G. Estrutura e processo de trabalho referente ao cuidado à criança na Atenção Primária à Saúde no Brasil: estudo ecológico com dados do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 2012-2018. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. 1, p. e2020425, 2021.

SANTOS, L. M. T. D. A.; GODOI, L.; ANDRADE E GUIMARÃES, B.; COUTINHO, I. M.; PIZATO, N.; GONÇALVES, V. S. S.; et al. A qualitative analysis of the nurturing care environment of families participating in Brazil's Criança Feliz early childhood program. **PLOS ONE**, v. 18, n. 7, e0288940, jul. 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0288940.

SANTOS, S. L. B.; BRITO, J. S. S.; OLIVEIRA, R. C.; ALMEIDA, D. M. R.; LIMA, J. S.; OLIVEIRA, L. C. Os desafios da adesão à vacinação na primeira infância: atuação da enfermagem na promoção da saúde. **International Journal of Development Research**, v. 10, n. 07, p. 37911-37917, 2020.

SCHIPPERIJN, J.; PAGE, A. S.; CARLSON, J. A.; NIENHUIS, B.; COOPER, A. R.; NEUHAUS, M.; VEBEREN, C. van; TROELSEN, J. The role of playgrounds in promoting children's health: a scoping review. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 21, n. 1, art. 32, 2024. DOI: 10.1186/s12966-024-01618-2.

SCHMIDT, K. L.; NICKERSON, L. D.; MCLOUGHLIN, K.; BRADLEY, R. H. Society to cell: how child poverty gets “under the skin”. **Developmental Review**, v. 60, p. 1-25, 2021.

SCHMITT, L. R.; CORRÊA, B. P.; NUNES, I. M.; MARIOT, M. D.; SILVA, C. H. A puericultura no primeiro ano de vida – uma avaliação na Atenção Primária em Saúde. **Revista Rede Cuidar Saúde**, v. 14, n. 2, p. –, 2020.

SCHWARZENBERG, S. J.; GEORGY, M.; COMMITTEE ON NUTRITION; SECTION ON GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY, AND NUTRITION. Advocacy for improving nutrition in the first 1000 days to support childhood development and adult health. **Pediatrics**, **Itasca**, v. 141, n. 2, e20173716, 2018. DOI: 10.1542/peds.2017-3716.

SIEGA, C. K.; ADAMY, E. K.; TOSO, B. R. G. de O.; ZOCICHE, D. A. de A.; ZANATTA, E. A. Vivências e significados da consulta do enfermeiro em puericultura: análise à luz de Wanda Horta. **Revista de Enfermagem UFSM**, Santa Maria, v. 10, n. e65, p. 1-21, 2020.

SILVA, G. C.; OLIVEIRA, K. C. P. N.; COSTA, L. M. C.; FORTUNA, C. M.; CARVALHO, R. N. C. Intersetorialidade em saúde e os desafios da Atenção Primária. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, São Paulo, v. 7, n. 15, p. e151572, 2024. DOI: 10.55892/jrg.v7i15.1572. Acesso em: 10 set. 2025.

SILVA, G. S.; ALVES, C. R. L. Avaliação do grau de implantação dos atributos da atenção primária à saúde como indicador da qualidade da assistência prestada às crianças. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, p. e00095418, 2019.

SILVA, G. S.; FERNANDES, D. R. F.; ALVES, C. R. L. Avaliação da assistência à saúde da criança na Atenção Primária no Brasil: revisão sistemática de métodos e resultados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 8, p. 3185-3200, 2020.

SILVA, J. M.; SOUZA, T. P.; ALMEIDA, R. F.; FERREIRA, L. C. Formação para profissionais do Programa Criança Feliz: a importância da primeira infância no desenvolvimento do ser humano. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 9, p. e18721–e18721, 2025.

SILVA, N. M. de L. Contribuição do Programa Unidade Amiga da Primeira Infância para melhoria do acompanhamento de crianças na Atenção Primária à Saúde. 2022. Dissertação (Mestrado em Saúde da Mulher e da Criança) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

SILVA, W. A. P.; OLIVEIRA, L. M.; SANTOS, T. F.; MOURA, R. C.; PEREIRA, J. V.; SOUZA, E. M. Determinantes sociais de saúde de crianças em consulta de puericultura: das condições socioeconômicas aos aspectos relacionados à saúde bucal. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, Umuarama, v. 27, n. 2, p. 770–794, 2023. DOI: 10.25110/arqsaude.v27i2.2023

SOUSA, A. N. A.; SHIMIZU, H. E. Como os brasileiros acessam a Atenção Básica em Saúde: evolução e adversidades no período recente (2012-2018). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 2981-2995, 2021.

SOUSA, N. K. M. de; LIMA, K. C. L. de; OLIVEIRA, A. C. de; LOPES, M. do S.;

MACEDO, I. R.; MOURA, L. H. V. de. Políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil: desafios para atenção integral em saúde e intersetorialidade. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 33, e33006, 2023.

SOUZA, C. D. F.; NASCIMENTO, A. L. O.; SOUZA, C. A. J.; MACHADO, M. F.; ARAÚJO, M. D. P.; WANDERLEY, R. A.; TEIXEIRA, C. P.; CARMO, R. F. Primary care performance measurement in Brazil (Previne Brasil Program), 2022-2023. **BMC Health Services Research**, v. 24, art. 949, 2024.

SOUZA, R. R.; VIEIRA, M. G.; LIMA JÚNIOR, C. J. F. A rede de atenção integral à saúde da criança no Distrito Federal, Brasil: análise com base nos eixos da PNAISC. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, p. 2075–2084, jun. 2019. DOI: 10.1590/1413-81232018246.09512019.

SOUZA, S. S.; SILVA, T. D.; STAREPRAVO, F. A.; YARID, S. D. A promoção da saúde na agenda retórica presidencial brasileira (2006-2023). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 5, p. e10302023, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025305.10302023>

UNESCO. Investing in early childhood care and education yields lifelong benefits. Disponível em: <<https://www.unesco.org/en/articles/investing-early-childhood-care-and-education-yields-lifelong-benefits>>.

VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; ASSUNÇÃO, M. C. F.; HALLAL, P. C.; et al. The importance of maternal and child nutrition for health and human capital in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, 2020. DOI: 10.11606/s1518-8787.2020054001946.

VIEIRA, R. C. M.; HONORATO, L. G. F. A intervenção do assistente social na prevenção da violação de direitos de crianças em situação de vulnerabilidade social. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 11, p. 4375-4393, 2023.

WANG, K.; LIU, X.; LI, Y.; WANG, L.; ZHANG, L.; WU, Y.; LI, M.; WANG, H.; HU, G.; LUO, R.; SHI, Y.; ROZELLE, S. Responsive caregiving and opportunities for early learning: effects on infant development. **Frontiers in Pediatrics**, v. 10, artigo 857107, 2022. DOI: 10.3389/fped.2022.857107.

WANG, Y.; WONG, E. L. Y.; NILSEN, P.; CHUNG, V. C.; TIAN, Y.; YEOH, E.-K. A scoping review of implementation science theories, models, and frameworks: an appraisal of purpose, characteristics, usability, applicability, and testability. **Implementation Science**, v. 18, p. 43, 2023. DOI: 10.1186/s13012-023-01296-x.

WILLIAMS, L. S.; VICKREY, B. G. **Implementation Science**. Stroke, v. 52, n. 12, p. 4054–4056, dez. 2021. DOI: 10.1161/STROKEAHA.121.03397.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030. Geneva: World Health Organization, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNICEF. New report calls for greater attention to children's vital first years. Geneva, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/29-06-2023-new-report-calls-for-greater-attention-to-children-s-vital-first-year>

YOGMAN, M.; GARNER, A.; HUTTER, J.; CHAUDRON, L.; EARLS, M. F. The power of play: a pediatric role in enhancing development in young children. **Pediatrics**, Itasca, v. 142,

n. 3, p. e20182058, set. 2018. DOI: 10.1542/peds.2018-2058.

YOSHIKAWA, H.; WUERMILIEN, C.; RYNNING, J.; WEISSMAN, A.; RIGGI, C.; LU, C.; SHERIDAN, M. Toward high-quality early childhood development: components, systems, and policies. ERIC, 2018. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED595500>. Acesso em: 10 set. 2025.

YOUSAFZAI, A. K.; SIYAL, S.; FRANCHETT, E. E.; DAI, Q.; REHMANI, K.; SUDFELD, C. R.; BHAMANI, S.; HAKRO, S.; REYES, C. R.; FINK, G.; PONGUTA, L. A. Effect of a youth-led early childhood care and education programme on children's development and learning in rural Sindh, Pakistan (LEAPS): a stepped-wedge cluster-randomised implementation trial. **The Lancet Child & Adolescent Health**, v. 9, n. 1, p. 25–36, jan. 2025.

ZANLORENZI, G. B.; SILVA, F. P.; MARTINS, R. C.; FERREIRA, A. P.; LIMA, M. R. Fragilidades e potencialidades do cuidado de enfermagem em aleitamento materno na atenção primária: revisão integrativa. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 12, p. e36, 2022.

ZIWERT, H. E.; LOPES, A. C.; SOUZA, J. F.; MOURA, K. L.; TEIXEIRA, L. P. Avaliação das ações de assistência ao aleitamento materno desenvolvidas por profissionais da atenção primária às mulheres no puerpério. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 8, p. e15420, 2024.

APÊNDICES

APÊNDICE 1

Artigo de Revisão

CUIDADO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - AÇÕES PROFISSIONAIS BASEADAS NO MODELO ‘NURTURING CARE’: UMA REVISÃO DE ESCOPO.

RESUMO

O objeto deste estudo é mapear, na literatura, as ações educativas e assistenciais de profissionais de saúde para a promoção do cuidado integral à criança na primeira infância, alinhadas ao modelo “Nurturing Care”. O objetivo é analisar os processos e os resultados de intervenções realizadas em contextos comunitários para subsidiar a formulação de políticas públicas e aprimorar a prática profissional. A metodologia foi uma revisão de escopo, seguindo o framework PRISMA-ScR, com busca em bases de dados internacionais que resultou na seleção de 10 artigos para análise. A abordagem teórica baseia-se no framework "Nurturing Care", que integra cinco dimensões essenciais: boa saúde, nutrição adequada, cuidado responsivo, segurança e proteção, e oportunidades de aprendizado precoce. Os resultados revelam que intervenções multifacetadas são eficazes para o desenvolvimento infantil, especialmente as ações focadas em cuidado responsivo e oportunidades de aprendizado precoce. Contudo, a análise demonstrou que a implementação de programas com benefícios simultâneos em todos os cinco eixos do modelo continua sendo um desafio, destacando a necessidade de pesquisas futuras que investiguem abordagens mais integradas e sustentáveis.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Primeira infância; Contexto comunitário; Nurturing Care; Profissionais de saúde.

ABSTRACT

The object of this study is to map, in the literature, the educational and care actions of health professionals for the promotion of comprehensive child care in early childhood, aligned with the “Nurturing Care” model. The objective is to analyze the processes and results of interventions carried out in community contexts to support the formulation of public policies and improve professional practice. The methodology was a scoping review, following the PRISMA-ScR framework, with a search in international databases that resulted in the selection of 10 articles for analysis. The theoretical approach is based on the "Nurturing Care" framework, which integrates five essential dimensions: good health, adequate nutrition, responsive care, safety and protection, and early learning opportunities. The results reveal that multifaceted interventions are effective for child development, especially actions focused on responsive care and early learning opportunities. However, the analysis showed that the implementation of programs with simultaneous benefits across all five axes of the model remains a challenge, highlighting the need for future research to investigate more integrated and sustainable approaches.

Keywords: Child development; Early childhood; Community context; Nurturing Care; Health professionals.

RESUMEN

El objeto de este estudio es mapear, en la literatura, las acciones educativas y asistenciales de profesionales de la salud para la promoción del cuidado integral del niño en la primera infancia, alineadas con el modelo “Nurturing Care”. El objetivo es analizar los procesos y los resultados de intervenciones realizadas en contextos comunitarios para apoyar la formulación de políticas públicas y mejorar la práctica profesional. La metodología fue una revisión de alcance, siguiendo el marco PRISMA-ScR, con una búsqueda en bases de datos internacionales que resultó en la selección de 10 artículos para su análisis. El enfoque teórico se basa en el marco "Nurturing Care", que integra cinco dimensiones esenciales: buena salud, nutrición adecuada, cuidado receptivo, seguridad y protección, y oportunidades de aprendizaje temprano. Los resultados revelan que las intervenciones multifacéticas son efectivas para el desarrollo infantil, especialmente las acciones enfocadas en el cuidado receptivo y las oportunidades de aprendizaje temprano. Sin embargo, el análisis demostró que la implementación de programas con beneficios simultáneos en los cinco ejes del modelo sigue siendo un desafío, destacando la necesidad de futuras investigaciones que exploren enfoques más integrados y sostenibles.

Palabras clave: Desarrollo infantil; Primera infancia; Contexto comunitario; Nurturing Care; Profesionales de la salud.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a primeira infância é definida como o período compreendido nos primeiros seis anos de vida completos¹. Reconhecidamente é o período no qual acontecem as modificações biológicas mais importantes nos domínios motor, afetivo-social e cognitivo, sendo o principal período de transformações e maturação cerebral². Nesse período, é imprescindível possibilitar à criança, espaços para liberdade de movimentos, brincadeira, disponibilidade de brinquedos, vínculos afetivos saudáveis, entre outros fatores³.

Priorizar o desenvolvimento na primeira infância (DPI) é essencial para a construção de uma sociedade saudável, onde as crianças tenham oportunidades para viver e prosperar. De acordo com o Banco Mundial⁴, aproximadamente 250 milhões de crianças com menos de cinco anos em países de média e baixa renda estão em risco de não atingir seu potencial de desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional.

No Brasil, a Constituição Federal⁵, por meio do artigo 227, reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, garantindo-lhes, com prioridade absoluta, proteção integral e condições para seu pleno desenvolvimento, sob responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Esse princípio foi reforçado pelo Marco Legal da Primeira Infância⁶, que estabelece o dever do Estado em formular políticas públicas voltadas às crianças de até seis anos, assegurando seu desenvolvimento integral.

Para que isso seja viável, ações intersetoriais de cuidado à criança fazem-se indispensáveis, pois os riscos ao pleno desenvolvimento infantil não estão associados somente às vulnerabilidades singulares desse ciclo de vida, são determinadas também pelas múltiplas dimensões da pobreza, expressas na ausência de renda, na baixa escolaridade da mãe/cuidador adulto, na falta de acesso aos serviços básicos e no ambiente precário onde vive, constituindo-se barreiras que dificultam ou retardam o desenvolvimento de todo o potencial das crianças^{4, 7, 8}.

Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde, de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, para crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, os profissionais são responsáveis pelo acompanhamento e crescimento⁹. O trabalho intersetorial, no que tange a atenção nas situações de vulnerabilidade e promoção da saúde e prevenção das doenças, sendo que essa última engloba o incentivo ao aleitamento materno e alimentação saudável, atualização do calendário vacinal, prevenção de acidentes domésticos e maus-tratos, e ações educativas para familiares e cuidadores^{10, 11}.

A partir dos indicadores apresentados, um modelo global, o Framework Nuturing Care¹², proposto pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) para promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos,

é utilizado, funcionando como uma rede de cuidados, a partir das suas dimensões que tratam da Nutrição, Segurança e Proteção, Oportunidades de Aprendizagem e Cuidados Responsivos.

Na APS, esse modelo é bastante utilizado, e está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030¹³ no caso dos números 01, 02 e 03, que respectivamente visam a erradicação da pobreza, fome zero melhorar a nutrição e saúde e bem-estar, no contexto da promoção de uma vida saudável para o desenvolvimento infantil, reduzindo a mortalidade infantil e garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade e ambientes saudáveis de seguros¹⁴,
15.

No processo de trabalho no cuidado à criança, especialmente no que tange ao desenvolvimento infantil, existem várias limitações que podem comprometer a qualidade do atendimento¹⁶. Essas incluem a falta de formação específica dos profissionais de saúde, a escassez de recursos materiais e financeiros, e a dificuldade em integrar as diferentes áreas do saber, como a saúde, a educação e o assistencialismo social. Além disso, o foco excessivo em aspectos biológicos do desenvolvimento infantil, em detrimento das dimensões sociais e emocionais, pode prejudicar a compreensão holística do desenvolvimento da criança, impedindo intervenções mais eficazes e integradas¹⁷.

Para que seja possível melhoras nos índices, as práticas dos profissionais são o alicerce do processo, pois são elas as responsáveis pelas mudanças, em conjunto com a adesão da população. Evidências científicas expressam a relevância da vigilância do desenvolvimento infantil no monitoramento das condições que afetam o desenvolvimento humano para a sua identificação precoce e realização de intervenções apropriadas^{18, 19, 20, 21}.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é mapear na literatura os processos e resultados de ações educativas e assistenciais com profissionais de saúde no contexto da atenção primária que

podem promover o cuidado integral à criança a partir do modelo “*Nurturing Care*”.

METODOLOGIA

Esta revisão foi baseada no framework Preferred Reporting Items for *Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR)^{22, 23} e suas etapas estão descritas na figura 1. Foi realizado o registro do projeto da revisão de escopo no *Open Science Framework* (<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TXWSF>).

A busca por artigos pertinentes ao tema ocorreu a partir da utilização dos seguintes descritores para busca em bases de dados internacionais, sem restrição na data de publicação, com o cruzamento de descritores controlados: (*Child Development or Infant Development*) and (*Nurturing Care or Parent-Child Relations or Family Environment or Caregivers*) and (*Health Personnel or Primary Health Care or Community Health Services*). As bases de dados utilizadas foram: *Scopus*, *Pubmed (MEDLINE)*, *Cochrane*, *Embase*, *Web of Science*, *Biblioteca Virtual de Saúde*, em janeiro de 2025. Termos do Medical Subject Headings (Mesh) e Descritores em Ciências da Saúde (Decs) foram selecionados para operacionalizar a estratégia de busca, projetada para o banco de dados PubMed e adaptada para os outros bancos de dados. Para cada site, a estratégia de busca foi adaptada de acordo com os recursos disponíveis e a interface de pesquisa (apêndice).

A seleção dos estudos para revisão se baseou nos critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo (quadro 1):

Quadro 1: Critérios de elegibilidade para os artigos

Inclusão	Exclusão
Artigos que descrevam práticas educativas ou assistenciais realizadas por profissionais de saúde com o objetivo de promover o cuidado integral a crianças de 0 a 6 anos e suas famílias., no contexto comunitário ou de Atenção Primária; Sem restrições de localização geográfica, idiomas ou data de publicação.	Artigos cujo texto completo não está disponível; Artigos em duplicatas; Artigos não pertinentes, isto é, fora do tópico literário primário abordado; Qualquer tese, dissertação ou resumo de conferência.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os trabalhos encontrados foram exportados no formato .ris para o gerenciador de referências Zotero, sendo excluídos inicialmente os trabalhos duplicados e, posteriormente, feita a análise através do abstract, de forma independente, por dois pesquisadores do grupo. As divergências encontradas entre os pesquisadores foram analisadas por um terceiro pesquisador da equipe.

Um total de 829 trabalhos foram selecionados, dos quais 26 foram excluídos por serem duplicados. Dos 803 trabalhos restantes, 733 foram excluídos, após análise do título e resumo por 2 pesquisadores do grupo de pesquisa. Então, ambos os pesquisadores analisaram o texto completo dos 70 artigos restantes, selecionando 7 deles em conjunto e 7 separadamente. As 7 divergências foram analisadas pelo pesquisador 3, resultando na seleção final de 10 artigos para a revisão.

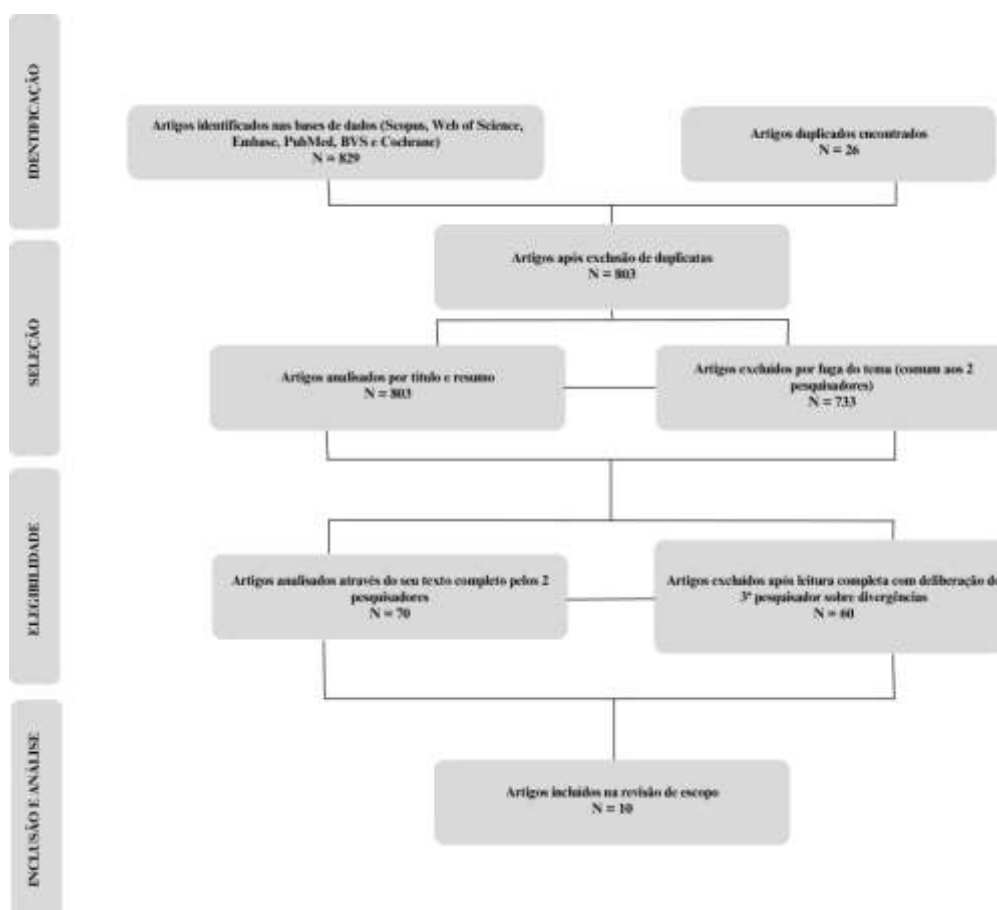


Figura 1. Fluxograma do PRISMA para a inclusão dos artigos (elaboração dos autores)

Para o mapeamento dos dados, as informações dos artigos selecionados foram organizadas para análise utilizando as seguintes categorias: título, local e ano de publicação, autores, estratégias utilizadas, perfil dos profissionais e principais resultados (quadro 2).

RESULTADOS

Os 10 estudos analisados, publicados nos últimos nove anos, focam em intervenções para o desenvolvimento na primeira infância, revelando uma abrangência geográfica e metodológica significativa. As intervenções ocorreram predominantemente em países asiáticos e africanos: três na China, dois em Bangladesh, e um em Lesoto, Indonésia, EUA, Paquistão e Zâmbia, respectivamente.

Um ponto chave dessas intervenções é o envolvimento de uma variedade de profissionais de saúde e membros da comunidade, adaptando-se frequentemente a contextos de recursos limitados. As equipes incluíram enfermeiras, parteiras, agentes comunitários de saúde, e as Ladies Health Workers, que são indivíduos da comunidade treinados por profissionais, uma estratégia comum e eficaz em muitos países da África e Ásia.

Quanto à metodologia, nove dos dez estudos empregaram ensaios controlados randomizados. Desses, dois foram estudos de acompanhamento e um de intervenção direta. Além disso, houve um estudo piloto caso-controle, este último frequentemente utilizado para avaliar a viabilidade inicial de novas abordagens. A seguir, estão organizados os principais resultados dos estudos analisados (figura 2).

Figura 2 – Visão geral dos artigos incluídos na revisão.

Título dos artigos	Autores	Local (ano)	Metodologia empregada	Estratégias utilizadas	Perfil dos profissionais de saúde	Principais resultados
Integrating a Group-Based, Early Childhood Feeding Intervention Into Primary Health Care Services in Rural Bangladesh: A Cluster-Randomized Controlled Trial	Mehrin et al. ¹⁴	Bangladesh (2022)	Ensaios clínicos cluster-randomizados	Sessões quinzenais com 4 idades, em vez de visitas domiciliares individuais, promovendo apoio social.	Agentes Comunitários de Saúde	Melhora significativa no desenvolvimento cognitivo, linguagem e motricidade, sinais de melhora em comportamentos durante o teste, sem efeitos no crescimento.
Promoting Children Growth and Development: A community-based cluster randomized controlled trial in rural areas of Indonesia	Susanto et al. ²¹	Indonésia (2019)	Ensaios controlados randomizados por clusters não cegos, de base comunitária.	Durante o programa PCGD (Promoting Children's Growth and Development) que durou 14 semanas, as mães aprenderam a completar o cardápio alimentar das crianças, base técnica de alimentação para estimular a produção de leite e como estimular o desenvolvimento de seus filhos acompanhando-os sempre durante as visitas e fornecendo brinquedos adequados à idade.	Informantes de saúde pública locais ou parteiros	A proporção de atraso de crescimento, erupção e diarreia no desenvolvimento foi maior no grupo controle em comparação com o grupo de intervenção. A prevalência de desenvolvimento normal entre as crianças foi maior no grupo de intervenção após o PCGD.
Carers' parenting beliefs, practices, and child developmental outcomes: Evidence from randomized controlled trials in rural China	Wang et al. ¹⁸	China (2024)	Dois ensaios controlados randomizados (RCTs)	Durante as sessões de treinamento individualizadas, os treinadores ensinaram os cuidadores a realizar e envolver seus filhos em atividades interativas, incluindo crianças em quatro domínios de habilidades: cognição, linguagem, motor e habilidades socioemocionais.	Profissionais de saúde locais	As intervenções melhoraram significativamente o desenvolvimento cognitivo infantil e tiveram um efeito positivo nas práticas parentais e nas crenças parentais dos cuidadores primários.
Integrating an early child development intervention into an existing primary healthcare platform in rural Lesotho: a prospective case-control study	Nkayatsigye et al. ²²	Lesoto (2022)	Estudo piloto de caso-controle prospectivo	Treinamento de pais para conhecimento sobre desenvolvimento infantil, prática de interação contingente com a criança, apoio social aos pais e encaminhamento. O programa consistia em sete sessões de educação para cuidadores, com 4-6 duplas em cada sessão.	Trabalhadores de Saúde de Aldeia (VFWs) e Informantes de DSP locais	Até final do estudo, crianças no grupo de intervenção tiveram pontuações significativamente mais altas em todos os domínios da EASQ (Questionário de Idades e Escalas Estendidas) em comparação com o grupo controle (comunicação, desenvolvimento social e desenvolvimento motor).
A holistic approach to promoting early child development: A cluster randomized trial of a group-based, multi-component intervention in rural Bangladesh	Pichik et al. ²³	Bangladesh (2021)	Ensaios controlados randomizados por clusters de três braços, paralelo e multicêntrico	As sessões incluíam discussões interativas sobre a importância da brincadeira, revisão de atividades anteriores, introdução de novos jogos com brinquedos de baixo custo feitos de materiais reciclados, música local e atividades com filmes interativos.	Trabalhadores de saúde comunitários (CHWs)	As pontuações de desenvolvimento infantil, avaliadas pelo ASQ e CDI, foram mais altas em ambos os grupos de intervenção em comparação com o controle.
Effects of responsive stimulation and nutrition interventions on children's development and growth at age 4 years in an disadvantaged population in Pakistan: a longitudinal follow-up of a cluster-randomized factorial effectiveness trial	Yousafzai et al. ²⁰	Paquistão (2016)	Estudo de acompanhamento longitudinal de um ensaio de efetividade factorial randomizado por clusters	Os cuidadores discutiam tópicos de desenvolvimento infantil (como apego, etapas e disciplina, bem-estar materno), interagiam com seus filhos, recebiam feedback construtivo e participavam de resolução de problemas entre pares.	Ladies Health Workers (LHW)	A intervenção de estimulação responsiva (RS), isolada ou em combinação com a nutrição aprimorada (EN), teve efeitos pequenos, mas significativos, nas habilidades de função executiva, motricidade grossa e comportamento pró-social de crianças de 4 anos de idade.
Encouraging Parenting Behavior That Promotes Early Childhood Development Among Caregivers From Low-Income Urban Communities: a Randomized Single Group Comparison Trial of a Primary Care-Based Parenting Program	Shah et al. ¹⁶	Índia (2019)	Ensaios randomizados controlados com grupo de comparação estético	A intervenção, denominada "Sit Down and Play" (SDP), foi um programa breve baseado na atenção parental. Após a consulta de saúde da criança aos 2 meses de idade, as duplas pais-criança no grupo de intervenção foram orientadas por um assistente de pesquisa a sentar e brincar com o bebê por 10 minutos, e depois fazer atividades semelhantes em casa.	Assistentes de pesquisa e profissionais de saúde da atenção primária	As crianças no grupo de intervenção, em comparação com o grupo controle, apresentaram um aumento significativamente maior no número de vocalizações (babbling) e no uso de balbucios complexos aos 4 e 6 meses de idade. Isso sugere que a intervenção teve um impacto positivo direto no desenvolvimento da linguagem precoce dos bebês.

The effect of a community-based, integrated and nurturing care intervention on early childhood development in rural China	Zhou et al. ²⁴	China (2019)	Estudo de intervenção comunitária randomizado por clusters de caso-controle	As visitas eram realizadas em casa ou em centros de saúde, com atividades que promoviam o desenvolvimento cognitivo, de linguagem, motor e socioemocional, como uso de livros e brinquedos. A intervenção enfatizava a estimulação psicossocial e a educação nutricional, o que era adaptado culturalmente e para o contexto rural.	Trabalhadores de saúde da linha de frente, incluindo Lady Health Workers e Anganwadi Workers	As crianças no grupo de intervenção tiveram uma redução significativa na prevalência de atraso geral no neurodesenvolvimento (de 43,9% para 34,8%), e uma redução de 7% na prevalência de depressão dos cuidadores, que também é um fator de risco para o desenvolvimento infantil.
The Effectiveness and Cost-effectiveness of a Parenting Intervention Integrated with Primary Health Care on Early Childhood Development: a Cluster-Randomized Controlled Trial	Shi et al. ²⁵	China (2020)	Ensio randomizado controlado por clusters	Os cuidadores no grupo de intervenção receberam um folheto de parentalidade e participaram de duas sessões de treinamento parental durante as visitas de saúde de rotina na clínica. A intervenção se concentrou em estimular o desenvolvimento cognitivo, de linguagem, motor e socioemocional, utilizando abordagens como brincadeiras interativas e socialização.	Profissionais de saúde da atenção primária (enfermeiros, agentes de saúde comunitária, médicos)	Em comparação com os controles, crianças que receberam a intervenção tiveram resultados de desenvolvimento sensíveis, medidos pela versão chinesa dos Questionários de Idade e Estágios (Ages & Stages Questionnaires). O estudo não encontrou efeitos significativos na redução do atraso geral no desenvolvimento infantil ou em outras habilidades importantes.
Two-year impact of community-based health screening and parenting groups on child development in Zambia: follow-up to a cluster-randomized controlled trial	Rodgers et al. ²⁶	Zâmbia (2018)	Estudo de acompanhamento de dois anos de um ensaio controlado randomizado por clusters	Grupos de parentalidade semanais para mães e pais, com 14 sessões que promoviam interações sensíveis e responsivas com seus filhos, ajudando-os a estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional de seus filhos.	Trabalhadores de saúde comunitários (Community Health Workers - CHWs) ou voluntários	Após dois anos de acompanhamento, as crianças nos aldeias de intervenção tiveram escores significativamente mais altos em desenvolvimento cognitivo, linguagem e motor grosso em comparação com as crianças nas aldeias de controle.

Fonte: elaborado pelos autores.

Com a percepção dos estudos selecionados, já é possível perceber a influência e a presença dos eixos do “Nurturing Care” (integração da boa saúde, nutrição adequada, cuidado responsivo, segurança e proteção, oportunidades de aprendizado precoce) no contexto comunitário voltado ao desenvolvimento infantil na primeira infância.

No que tange ao eixo do cuidado responsivo e oportunidades de aprendizado precoce, uma vasta gama de intervenções mostrou resultados promissores. Em Bangladesh, sessões quinzenais facilitadas por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) resultaram em melhorias significativas no desenvolvimento cognitivo, linguagem e motricidade, bem como no comportamento das crianças durante os testes²⁴. De maneira similar, na China, treinamentos individualizados para cuidadores, conduzidos por profissionais de saúde locais, aprimoraram o desenvolvimento cognitivo infantil, as práticas e as crenças parentais²⁶. Também na China, um estudo de intervenção comunitária randomizado por clusters focou na estimulação psicossocial por meio de visitas domiciliares e em centros de saúde, resultando em uma redução no atraso geral no neurodesenvolvimento³¹.

Já em Lesoto, um estudo piloto demonstrou que o treinamento de pais e o apoio social, facilitados por Trabalhadores de Saúde de Aldeia e enfermeiras, levaram a pontuações mais altas em comunicação, desenvolvimento social e motor²⁷. Em Bangladesh, novamente, um

programa multicomponente com discussões interativas e jogos, implementado por Trabalhadores de Saúde Comunitários, também resultou em escores de desenvolvimento infantil significativamente mais altos²⁸. No Paquistão, intervenções com estimulação responsiva, entregues por Lady Health Workers, impactaram positivamente as habilidades de função executiva, inteligência geral e comportamento pró-social²⁹. Nos Estados Unidos, um programa breve na atenção primária, que encorajava a brincadeira interativa, mostrou um aumento no balbúcio e nas vocalizações em bebês³⁰. Por fim, na Zâmbia, grupos de parentalidade semanais, facilitados por Trabalhadores de Saúde Comunitários, tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento cognitivo, linguístico e motor grosso das crianças³³. Contudo, é relevante mencionar que uma intervenção na China, que integrou orientações parentais na atenção primária, não apresentou efeitos significativos na redução do atraso geral no desenvolvimento infantil³².

No que diz respeito à nutrição adequada, frequentemente combinada com outros eixos, o estudo da Indonésia demonstrou que um programa focado em alimentação e estimulação resultou em uma redução significativa nos atrasos de crescimento e desenvolvimento²⁵. No Paquistão, a combinação de estimulação responsiva e nutrição aprimorada também contribuiu para o desenvolvimento infantil²⁹.

O eixo da boa saúde, embora subjacente à maioria das intervenções que utilizam a atenção primária, foi explicitamente abordado em estudos que integraram a educação nutricional e a prevenção de atrasos, como o caso da intervenção comunitária na China que mostrou redução na depressão dos cuidadores, um fator de risco para o desenvolvimento infantil³¹. Quanto ao eixo de segurança e proteção, os estudos mostraram que eles permeiam a concepção de ambientes de cuidado, sendo indiretamente fortalecidos pelo aumento do conhecimento parental e das práticas de cuidado responsivo²⁴⁻³³.

A eficácia dessas intervenções é indissociável do papel vital desempenhado pelos profissionais de saúde e agentes comunitários locais. Sua atuação direta com as famílias e sua capacidade de adaptar as estratégias às realidades de cada comunidade influenciam muito nos resultados desses programas³⁴.

DISCUSSÃO

Os resultados da análise dos 10 estudos demonstram uma clara convergência para a efetividade das intervenções na primeira infância, particularmente aquelas alinhadas com os eixos do "Nurturing Care". A predominância de ensaios controlados randomizados entre as metodologias empregadas, incluindo estudos de acompanhamento e ensaios clínicos cluster randomizados, confere um alto grau de confiabilidade aos achados. Essa robustez metodológica é um ponto forte, especialmente considerando que muitos dos estudos foram conduzidos em contextos de recursos limitados na Ásia e África, o que realça a replicabilidade e a escalabilidade potencial dessas abordagens em ambientes desafiadores³⁵.

A diversidade geográfica dos estudos (China, Bangladesh, Paquistão, Lesoto, Indonésia, EUA e Zâmbia) sublinha a universalidade da necessidade de intervenções para o desenvolvimento infantil e a adaptabilidade das estratégias de "Nurturing Care" a diferentes realidades culturais e socioeconômicas. Essa abordagem, que capacita indivíduos da própria comunidade, como enfermeiras, agentes comunitários de saúde e "Ladies Health Workers", não só otimiza o uso de recursos, mas também garante a contextualização das intervenções, aumentando a aceitação e a sustentabilidade a longo prazo, já que a confiança e o vínculo estabelecidos pelos agentes comunitários são inestimáveis para a adesão das famílias às práticas recomendadas³⁴.

Na prática, as ciências sociais oferecem ferramentas para entender como esses fatores moldam as práticas parentais e o ambiente de cuidado. Por exemplo, a teoria sociocultural de Vygotsky destaca a importância da interação com o adulto e a cultura para o desenvolvimento da criança, justificando a intervenção social e pedagógica, não apenas clínica. A abordagem intersetorial, defendida pela saúde coletiva, busca integrar políticas e serviços básicos para promover a saúde e reduzir desigualdades. Esse enfoque é vital para garantir que as intervenções, como as visitas domiciliares, sejam sensíveis ao contexto cultural e social das famílias, empoderando-as e fortalecendo a comunidade como um todo, em um esforço conjunto para otimizar o potencial de cada criança³⁶.

Em relação ao cuidado responsivo e às oportunidades de aprendizado precoce, os achados são consistentemente positivos. As intervenções que promoveram sessões facilitadas por agentes comunitários de saúde^{24, 28, 33}, treinamentos individualizados para cuidadores²⁶, estimulação psicossocial via visitas domiciliares³¹ e treinamento de pais com apoio social²⁷ demonstraram melhorias significativas em domínios cruciais do desenvolvimento infantil, como cognição, linguagem e motricidade. A influência dessas intervenções se estendeu também às práticas e crenças parentais, o que é fundamental, pois mudanças no comportamento dos cuidadores são preditores de resultados duradouros para as crianças²⁵.

É notável, contudo, que nem todas as intervenções apresentaram o mesmo grau de sucesso. O estudo na China que integrou orientações parentais na atenção primária, mas não mostrou efeitos significativos na redução do atraso no desenvolvimento infantil³², levanta uma questão importante sobre a complexidade da implementação e a necessidade de estratégias mais intensivas ou específicas.

A inclusão da nutrição adequada, frequentemente combinada com outros eixos, reforça a natureza holística do "Nurturing Care". O estudo da Indonésia²⁵ e o estudo paquistanês²⁹

demonstram que a abordagem integrada de alimentação e estimulação ou estimulação responsiva e nutrição aprimorada resulta em impactos mais abrangentes, como a redução de atrasos de crescimento e desenvolvimento. Isso corrobora a compreensão de que o desenvolvimento infantil é um processo multifacetado, no qual a desnutrição pode minar os benefícios de intervenções psicossociais e vice-versa.

O eixo da boa saúde, embora muitas vezes implicitamente presente devido à utilização da atenção primária como plataforma de intervenção, é evidenciado pela redução da depressão em cuidadores, um fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento infantil. Isso destaca a importância de abordar a saúde mental dos cuidadores como um componente integral do cuidado infantil, reconhecendo que o bem-estar da criança é intrinsecamente ligado ao bem-estar de seus cuidadores³¹. Com relação aos eixos de segurança e proteção, não foi possível perceber a sua abordagem direta nos estudos selecionados, embora sua presença possa ser notada de maneira indireta nos resultados das práticas abordadas²⁴⁻³³.

Um exemplo de iniciativa nacional que tem sua abordagem alinhada aos princípios do *Nurturing Care* é a "Unidade Amiga da Primeira Infância" (UAPI), um título concedido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) a serviços de saúde que atendem critérios de excelência no cuidado integral à criança. Essa certificação reconhece a necessidade de uma atenção que vai além da clínica, integrando aspectos de promoção da saúde e prevenção de doenças, e capacitando os profissionais para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, para replicá-lo em outros contextos de atenção primária no Brasil³⁷.

Outra abordagem promissora, como a plataforma *Parenting for Lifelong Health*, desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e utilizada em diversos países, mostra como programas de parentalidade podem ser adaptados culturalmente e oferecidos em diferentes formatos (presenciais ou digitais) para melhorar o desenvolvimento infantil e reduzir

a violência contra crianças³⁸. Essas evidências sugerem que a aplicação de ferramentas tecnológicas pode ser uma forma de superar algumas das limitações de recursos e alcance das intervenções presenciais, ampliando o impacto dos programas de *Nurturing Care* e tornando-os mais acessíveis a populações geograficamente dispersas, um desafio comum tanto em países de baixa renda quanto em nações com grande extensão territorial, como o Brasil.

No entanto, apesar da existência de abordagens semelhantes³⁷⁻³⁸ e da relevância de todos os eixos do "Nurturing Care" para o desenvolvimento infantil integral, nenhum dos artigos analisados demonstrou explicitamente benefícios simultâneos em *todos* os cinco eixos (boa saúde, nutrição adequada, cuidado responsivo, segurança e proteção, e oportunidades de aprendizado precoce) como resultado de uma única intervenção²⁴⁻³³. As intervenções tendem a focar em combinações específicas de eixos, com o cuidado responsivo e as oportunidades de aprendizado precoce sendo os mais frequentemente abordados, seguidos pela nutrição.

A ausência de intervenções que comprovem a melhoria explícita e mensurável em todos os eixos simultaneamente aponta para a complexidade de implementar um programa verdadeiramente abrangente e para a dificuldade de isolar os efeitos de cada componente. Entretanto, a totalidade desses estudos fornece uma evidência de que intervenções em maior escala, alinhadas aos princípios do *Nurturing Care* e integradas aos sistemas de saúde existentes, são não apenas viáveis, mas essenciais para promover o desenvolvimento saudável da primeira infância em diversos contextos socioeconômicos e culturais²⁴⁻³³.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão de escopo abordou os processos e resultados de ações educativas e assistenciais realizadas por profissionais de saúde no contexto da atenção primária, com o objetivo de promover o cuidado integral à criança a partir do modelo "Nurturing Care". Os

resultados obtidos por meio da análise dos dez estudos incluídos fornecem uma base sólida para entender a efetividade e a viabilidade de intervenções direcionadas ao desenvolvimento na primeira infância, especialmente em contextos de recursos limitados.

Ficou evidente que intervenções focadas nos eixos do cuidado responsivo e das oportunidades de aprendizado precoce são altamente eficazes na promoção do desenvolvimento cognitivo, linguístico e motor das crianças. A integração da nutrição adequada a essas abordagens reforça a natureza holística do desenvolvimento infantil, demonstrando que a combinação de fatores biológicos e psicossociais é fundamental. O papel dos profissionais de saúde e, em particular, dos agentes comunitários, emergiu como um pilar essencial para o sucesso das intervenções, dada sua capacidade de contextualizar as ações e estabelecer vínculos com as famílias.

Contudo, a análise também revelou que, embora o *framework* "Nurturing Care" seja um modelo abrangente e inspirador, a implementação prática de intervenções que demonstrem benefícios simultâneos em todos os seus cinco eixos (boa saúde, nutrição adequada, cuidado responsivo, segurança e proteção, e oportunidades de aprendizado precoce) ainda representa um desafio. Os estudos tendem a focar em subconjuntos desses eixos, sugerindo a complexidade de desenhar e avaliar programas que abordem todas as dimensões de forma igualmente explícita e mensurável. Essa observação aponta para a necessidade de pesquisas futuras que explorem abordagens mais integradas e multifacetadas, capazes de capturar o impacto holístico do "Nurturing Care".

As limitações identificadas, como a variabilidade nos desfechos mensurados e a ausência de avaliações de custo-efetividade, indicam áreas para aprimoramento em estudos futuros. É crucial que a pesquisa continue a investigar a sustentabilidade a longo prazo dessas

intervenções e os mecanismos pelos quais elas podem ser escaladas e replicadas em diferentes contextos socioculturais.

Conflito de interesses

Não há conflito de interesses entre os pesquisadores e o tópico da literatura abordado.

APÊNDICE 2

Quadro 2: Estratégias de busca utilizadas para cada base de dados.

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIA DE BUSCA	Quantitativo
PUBMED	((("Child Development"[ti] OR "Child Development"[mh] OR "Infant Development"[ti] OR "Infant Development"[mh]) AND ("Nurturing Care"[ti] OR "Nurturing Care"[mh] OR "Parent-Child Relations"[ti] OR "Parent-Child Relations"[mh] OR "Family Environment"[ti] OR "Family Environment"[mh] OR Caregivers[ti] OR Caregivers[mh]) AND ("Health Personnel"[ti] OR "Health Personnel"[mh] OR "Primary Health Care"[ti] OR "Primary Health Care"[mh] OR "Community Health Services"[ti] OR "Community Health Services"[mh]))	491 artigos
BVS	((("Child Development" OR mh:"Child Development" OR ti:"Infant Development" OR mh:"Infant Development") AND (ti:"Parent-Child Relations" OR mh:"Parent-Child Relations" OR ti:"Family Environment" OR mh:"Family Environment" OR ti:"Caregivers" OR mh:"Caregivers") AND (ti:"Health Personnel" OR mh:"Health Personnel" OR ti:"Primary Health Care" OR mh:"Primary Health Care" OR ti:"Community Health Services" OR mh:"Community Health Services"))	11 artigos
SCOPUS	((("Child Development" OR "Infant Development") AND ("Nurturing Care" OR "Parent-Child Relations" OR "Family Environment" OR Caregivers) AND ("Health Personnel" OR "Primary Health Care" OR "Community Health Services"))	167 artigos
EMBASE	('child development':ti OR 'infant development':ti OR 'child development'/exp) AND ('nurturing care':ti OR 'nurturing care' OR 'parent-child relations':ti OR 'child parent relation'/exp OR 'family environment':ti OR 'family environment'/exp OR 'caregivers':ti OR 'caregiver'/exp) AND ('health personnel':ti OR 'health care personnel'/exp OR 'primary health care':ti OR 'primary health care'/exp OR 'community health services':ti OR 'community care'/exp)	139 artigos

WEB of Science	((("Child Development" OR "Infant Development") AND ("Nurturing Care" OR "Parent-Child Relations" OR "Family Environment" OR Caregivers) AND ("Health Personnel" OR "Primary Health Care" OR "Community Health Services")))	20 artigos
Cochrane	((("Child Development" OR "Infant Development") AND ("Nurturing Care" OR "Parent-Child Relations" OR "Family Environment" OR Caregivers) AND ("Health Personnel" OR "Primary Health Care" OR "Community Health Services")))	1 artigo (uma revisão sistemática abrangendo 36 ensaios clínicos)

Fonte: elaborado pelos autores.

REFERÊNCIAS

1. Soares LG, Tomé SS, Abreu IS, Lentsck MH, Baratieri T, Sauka JM, et al. Adverse childhood experiences among highrisk children living in socially vulnerable areas. *Rev Bras Enferm.* 2025;78(Suppl 2):e20240247. Available from: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2024-0247pt>.
2. Silva EV, Hartwig FP, Yousafzai A, Bertoldi AD, Murray J. The effects of a large-scale home visiting programme for child development on use of health services in Brazil. *Health Policy Plan.* 2024 Apr 10;39(4):344–354. Available from: <https://doi.org/10.1093/heapol/czae015>.
3. Cuartas J, McCoy DC, Sánchez J, Behrman JR, Cappa C, Donati G, et al. Family play, reading, and other stimulation and early childhood development in five low-and-middle-income countries. *Dev Sci.* 2023 Apr;26(6):e13404. Available from: <https://doi.org/10.1111/desc.13404>.

4. World Bank. Early Childhood Development [Internet]. World Bank. 2017. Available from: <https://www.worldbank.org/en/topic/earlychildhooddevelopment>. Acessado em: 25 de junho de 2025.

5. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [Internet]. Planalto.gov.br. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 25 junho de 2025.

6. Brasil. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Diário Oficial da União. 2016 Mar 9;154(46):1. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113257.htm. Acessado em: 25 de junho de 2025.

7. Black MM, Behrman JR, Daelmans B, Prado EL, Richter L, Tomlinson M, et al. The principles of Nurturing Care promote human capital and mitigate adversities from preconception through adolescence. *BMJ Glob Health*. 2021 Apr;6(4):e004436. Available from: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004436>.

8. Rojas CFN, Pio DAM, Nonato AC. Understanding child development and care integrality: Primary Health Care doctors and nurses' view. *Rev Paul Pediatr*. 2023 Dec 25;42:e2023127. Available from: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2024/42/2023127>.

9. Pereira S. O papel da Estratégia de Saúde da Família na redução da mortalidade infantil. REMS [Internet]. 19º de fevereiro de 2025 [citado 25º de junho de 2025];6(1):15-2. Disponível em: <https://www.editoraintegrar.com.br/publish/index.php/rem/article/view/4498>.

10. Moura CS de, Grossi-Milani R, Mendonça F de F, Loch MR. Estratégias de promoção da saúde na primeira infância: tecendo redes locais. *Saúde debate* [Internet]. 2023 Feb 27;46:45–56. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E504>.

11. Chiari A, Senna MI, Gomes V, Freire M, Soares A, Alves C, et al. Intersectoral Collaboration to Promote Child Development: The Contributions of the Actor-Network Theory. *Qual Health Res* [Internet]. 2023 Apr 3;33(5):451–67. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10126467/>.

12. Daelmans B, Manji SA, Raina N. Nurturing Care for Early Childhood Development: Global Perspective and Guidance. *Indian Pediatr*. 2021 Nov 15;58 Suppl 1:S11-S15. PMID: 34687182. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34687182/>.

13. Martins ALJ, Silveira F, Souza AA de, Paes-Sousa R. Potencialidades e desafios do monitoramento da saúde na Agenda 2030 no Brasil. *Cien Saude Colet*. 2022;27(7):2519–29. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022277.18572021>.

14. Elomrani S, Beza R, De Brouwere V, Campbell OMR, L Lange I, Oswald WE et al. Approaching the SDG targets with sustained political commitment: drivers of the notable decline in maternal and neonatal mortality in Morocco. *BMJ Glob Health*. 2024 May 6;9(Suppl 2):e011278. Available from: https://gh.bmj.com/content/9/Suppl_2/e011278.abstract.

15. Kancherla V, Roos N, Walani SR. Relationship between achieving Sustainable Development Goals and promoting optimal care and prevention of birth defects globally. *Birth Defects Res*. 2022 Aug 15;114(14):773-784. Epub 2022 Jul 1. PMID: 35776686. Available from: <https://doi.org/10.1002/bdr2.2055>.

16. Rizzoli-Córdoba A, Campos-Maldonado MC, Vélez-Andrade VH, Delaflor-Wagner CA, Hernández-Trejo LA, Aceves-Villagrán D, et al. Play prescription: intervention delivered at primary health care facilities to promote child development through activities at home. *Bol Med Hosp Infant Mex*. 2025;82(Supl 1):94-100. Available from: https://www.bmhim.com/frame_eng.php?id=487.
17. Cavalcante DFB, Souza MHN, Freitas JLG, Parmejiani EP, Figueiredo E, Vasconcelos B. Avaliação da integralidade na atenção primária à saúde da criança na perspectiva dos cuidadores. *Res Soc Dev*. 2023;12(6):e3012641874. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41874>.
18. Bliznashka L, McCoy DC, Siyal S, Sudfeld CR, Fawzi WW, Yousafzai AK. Child diet and mother-child interactions mediate intervention effects on child growth and development. *Matern Child Nutr*. 2022 Apr;18(2):e13308. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13308>.
19. Miller LC, Neupane S, Joshi N, Lohani M, Shrestha B. Trajectories of child growth, child development, and home child-rearing quality during the Covid pandemic in rural Nepal. *Child Care Health Dev*. 2023 Sep;49(5):800-810. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36355606/>.
20. Murata A, Matsumoto N, Miyaji C, Takao S, Yorifuji T. Childcare and Child Development in Japan. *Acta Med Okayama*. 2023 Oct;77(5):479-490. PMID: 37899259. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37899259/>.
21. Munhoz, T. N., Santos, I. S., Blumenberg, C., Barcelos, R. S., Bortolotto, C. C., Matijasevich, A, et al. Fatores associados ao desenvolvimento infantil em crianças brasileiras: linha de base da avaliação do impacto do Programa Criança Feliz. *Cad*.

- Saúde Pública*, 38, e00316920. 2022 Feb 11;38. Available from: <https://www.scielo.br/j/csp/a/5CYG4C6xR5yQzbfqYsjx5zp/?lang=pt>.
22. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018 Sep 4;169(7):467–73. Available from: <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850>.
23. Aromataris E, Munn Z. JBI Manual for Evidence Synthesis [Internet]. Aromataris E, Munn Z, editors. JBI; 2020. Available from: <https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL>.
24. Mehrin SF, Hasan MI, Tofail F, Shiraji S, Ridout D, Grantham-McGregor S, et al. Integrating a Group-Based, Early Childhood Parenting Intervention Into Primary Health Care Services in Rural Bangladesh: A Cluster-Randomized Controlled Trial. *Front Pediatr*. 2022 Jun 10;10. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35783319/>.
25. Susanto T, Yunanto RA, Rasny H, Susumaningrum LA, Nur KRM. Promoting Children Growth and Development: A community-based cluster randomized controlled trial in rural areas of Indonesia. *Public Health Nurs*. 2019 May 17. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31099133/>.
26. Wang L, Jiang D, Zhang S, Rozelle S. Caregivers' parenting beliefs, practices, and child developmental outcomes: Evidence from randomized controlled trials in rural China. *World Dev*. 2024 Jun;178:106596. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X24000664>.

27. Melino Ndayizigiye, McBain R, Whelley C, Rorisang Lerotholi, Joalane Mabathoana, Carmona M, et al. Integrating an early child development intervention into an existing primary healthcare platform in rural Lesotho: a prospective case-control study. *BMJ Open*. 2022 Feb 1;12(2):e051781-1. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35121599/>.

28. Pitchik HO, Tofail F, Rahman M, Akter F, Sultana J, Shoab AK, et al. A holistic approach to promoting early child development: a cluster randomised trial of a group-based, multicomponent intervention in rural Bangladesh. *BMJ Glob Health* [Internet]. 2021 Mar 1;6(3):e004307. Available from: <https://gh.bmj.com/content/6/3/e004307.info>.

29. Yousafzai AK, Obradović J, Rasheed MA, Rizvi A, Portilla XA, Tirado-Strayer N, et al. Effects of responsive stimulation and nutrition interventions on children's development and growth at age 4 years in a disadvantaged population in Pakistan: a longitudinal follow-up of a cluster-randomised factorial effectiveness trial. *Lancet Glob Health*. 2016 Aug;4(8):e548-58. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27342433/>.

30. Shah R, Isaia A, Schwartz A, Atkins M. Encouraging Parenting Behaviors That Promote Early Childhood Development Among Caregivers From Low-Income Urban Communities: A Randomized Static Group Comparison Trial of a Primary Care-Based Parenting Program. *Matern Child Health J*. 2018 Jul 12;23(1):39-46. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30003519/>.

31. Zhou S, Zhao C, Huang X, Li Z, Ye R, Shi H, et al. The effect of a community-based, integrated and nurturing care intervention on early childhood development in rural

- China. *Public Health* [Internet]. 2019 Feb 1;167:125–35. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30660980/>.
32. Shi H, Li X, Fang H, Zhang J, Wang X. The Effectiveness and Cost-effectiveness of a Parenting Intervention Integrated with Primary Health Care on Early Childhood Development: a Cluster-Randomized Controlled Trial. *Prev Sci*. 2020 May 18. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32419119/>.
33. Rockers PC, Zanolini A, Banda B, Chipili MM, Hughes RC, Hamer DH, et al. Two-year impact of community-based health screening and parenting groups on child development in Zambia: Follow-up to a cluster-randomized controlled trial. Tumwine JK, editor. *PloS Med*. 2018 Apr 24;15(4):e1002555. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29689045/>.
34. Ribeiro AM, Silva RRF da, Puccini RF. Conhecimentos e práticas de profissionais sobre desenvolvimento da criança na atenção básica à saúde. *Rev. Paul. Pediatr*. 2010 Jun;28(2):208–14. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/BWNLn8vYPz4XVg8Z6p7vsxb/>.
35. Rosario-Filho N. Randomized and controlled clinical trials. *Residência Pediátrica*. 2020;10(2). Available from: https://www.residenciapediatria.com.br/Content/pdf/en_v10n1a02.pdf.
36. McLeod S. Vygotsky's sociocultural theory of cognitive development [Internet]. *Simply Psychology*. 2025. Available from: <https://www.simplypsychology.org/vygotsky.html>

37. Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância [Internet]. www.unicef.org. Available from: <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/iniciativa-unidade-amiga-da-primeira-infancia>
38. Parenting for Lifelong Health [Internet]. 2018. Available from: <https://www.parentingforlifelonghealth.org/>.

APÊNDICE 2

Roteiro de Entrevista para profissionais baseado no modelo RE-AIM

Dimensão	Perguntas
Alcance	A - Como você ficou sabendo sobre a Iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI)?
	A - Na sua percepção, as famílias do seu território tiveram acesso às ações dessa iniciativa? Se não, quais barreiras dificultaram esse acesso?
	A - Você percebe alguma diferença no contexto das famílias que participaram da iniciativa em comparação com aquelas que não participaram?
	A - Houve alguma estratégia específica utilizada para engajar e informar as famílias sobre a UAPI?
Efetividade	E - De que forma a certificação (capacitação, plano de trabalho das equipes, ações práticas no território e avaliação dos indicadores) recebida impactou sua prática profissional no dia a dia?
	E - Você percebe mudanças nos indicadores de saúde infantil após a implementação da iniciativa? Se sim, quais?
	E - Houve melhorias na relação dos profissionais com as famílias no cuidado à primeira infância após a implementação da UAPI?
	E - Você identificou algum aspecto da iniciativa que não teve o impacto esperado? Se sim, o que poderia ser melhorado?

Adoção	Ad - O que motivou você a participar da certificação (capacitação, plano de trabalho das equipes, ações práticas no território e avaliação dos indicadores) e a aderir à iniciativa?
	Ad - Quais foram as maiores dificuldades para incorporar as práticas recomendadas pela UAPI no seu trabalho diário?
	Ad - Você sente que os conhecimentos adquiridos na certificação (capacitação, plano de trabalho das equipes, ações práticas no território e avaliação dos indicadores) foram suficientes para sua atuação? O que poderia ser aprimorado?
	Ad - Existe resistência por parte de alguns profissionais da equipe em relação à adoção das ações da UAPI? Se sim, quais os motivos?
Implementação	I - Como as ações da UAPI foram inseridas na rotina da unidade de saúde?
	I - O suporte da gestão e da coordenação foi suficiente para garantir a implementação adequada da iniciativa?
	I - Houve necessidade de adaptar as recomendações da UAPI para a realidade do serviço? Se sim, quais foram as principais adaptações?
	I - Quais os principais desafios que você enfrentou ao implementar as ações da UAPI?
Manutenção	M - Você acredita que essas ações continuarão sendo implementadas a longo prazo? O que poderia facilitar ou dificultar essa continuidade?
	M - Existem políticas ou incentivos institucionais para garantir que a iniciativa se mantenha ao longo do tempo?

	M - O que você sugeriria para tornar a UAPI mais sustentável dentro das unidades de saúde?
	M - Como a equipe pode ser motivada a manter as boas práticas da iniciativa, mesmo após o término do ciclo de capacitação?

APÊNDICE 3

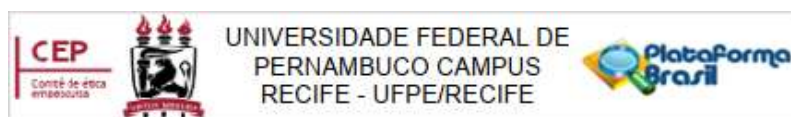
Roteiro de entrevista para gestores baseado no modelo RE-AIM.

Dimensão	Perguntas
Alcance	A - Como foi feita a mobilização dos profissionais para participarem da certificação (capacitação, plano de trabalho das equipes, ações práticas no território e avaliação dos indicadores) da UAPI?
	A - Você percebeu dificuldades em engajar alguns profissionais ou equipes? Se sim, quais estratégias foram usadas para lidar com isso?
Efetividade	E - Quais foram os principais impactos da iniciativa na qualidade dos serviços prestados à primeira infância?
	E - Houve mudanças nos indicadores de saúde infantil após a implementação da UAPI?
	E - Como a gestão avalia o engajamento e o desempenho dos profissionais a partir do processo de certificação (capacitação, plano de trabalho das equipes, ações práticas no território e avaliação dos indicadores)?
Adoção	Ad - Houve desafios para garantir que todos os profissionais aderissem ao processo de certificação (capacitação, plano de trabalho das equipes, ações práticas no território e avaliação dos indicadores)? Se sim, quais?
	Ad - O modelo de certificação utilizado foi adequado para a realidade das equipes? O que poderia ser melhorado?

	Ad - Você acredita que a adesão dos profissionais foi homogênea ou houve diferenças entre as equipes?
Implementação	I - Como a gestão organizou a implementação das ações propostas pela UAPI dentro das unidades?
	I - Foram disponibilizados recursos suficientes para que a iniciativa fosse implementada conforme o planejado?
	I - Quais foram as principais dificuldades enfrentadas no processo de implementação?
	I - Você identificou a necessidade de adaptações na estratégia inicial da UAPI? Se sim, quais foram as adaptações feitas?
Manutenção	M - A gestão tem planos para garantir a continuidade das ações da iniciativa após o ciclo de certificação?
	M - Existem incentivos financeiros, políticos ou institucionais para sustentar a iniciativa a longo prazo?
	M - Quais fatores podem facilitar e dificultar a manutenção das ações da UAPI no longo prazo?
	M - Como a gestão pode reforçar o compromisso dos profissionais para que as boas práticas da iniciativa sejam mantidas de forma permanente?

APÊNDICE 4

Parecer CEP



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PERCEPÇÕES E AÇÕES DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E CUIDADORES DURANTE A IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADES AMIGAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM RECIFE-PE

Pesquisador: MARIA WANDERLEYA DE LAVOR CORIOLANOMARINUS

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 68618123.8.0000.5208

Instituição Proponente: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

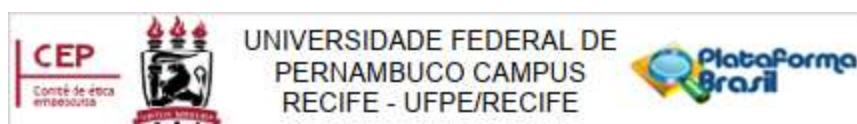
DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.150.202

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do projeto", "Objetivos da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios", foram retirados do arquivo Informações Básicas da Pesquisa (PB_Informações_Básicas_do_Projeto_2115792.pdf de 27/06/2023), e do Projeto Detalhado (de 27/06/2023).

Descrição: Trata-se de um Projeto de pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente (PPGSCA), da Universidade Federal de Pernambuco- UFPE. É uma pesquisa caracterizada como estudo qualitativo, descritivo, que utilizará a metodologia do Estudo de Caso. Diante da proposta da pesquisa será utilizado estudo de casos múltiplos que propicia um novo conjunto de questões dentro do contexto, utilizando a lógica da replicação, considerando-os como experimentos múltiplos. O estudo se fundamentará no modelo Nurturing Care e no Modelo Bioecológico de Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner, e será desenvolvido em duas Unidades de Saúde da Família (USF), participantes da implementação da Iniciativa UAPI (Unidades Amigas da primeira Infância-UNICEF) localizadas no Distrito Sanitário 2 na cidade do Recife. Serão acompanhados/entrevistados 15 trabalhadores e 10 cuidadores primários cadastrados nestas unidades de saúde. Os critérios de inclusão para os profissionais serão: aqueles que trabalham com crianças de zero a seis anos há mais de um ano; realizaram o



Continuação do Parecer: 6.150.202

ciclo de capacitação das UAPIs; trabalham há mais de um ano na USF. Os critérios de exclusão, são: profissionais que estejam de licença médica ou férias, e os envolvidos com a organização da iniciativa UAPI. Para as mães/cuidadores primários, os critérios de inclusão são: maiores de 18 anos; serem comunitários na área adscrita da USF. Os de exclusão, contemplam aqueles (as) que apresentem ou refiram dificuldades cognitivas para compreensão dos questionamentos e cuidadores com transtorno mental, que estejam em situação que impossibilite a realização da interação durante a pesquisa. Para análise dos dados será utilizado como referencial teórico da Metodologia da Quarta Geração.

Objetivo da Pesquisa:

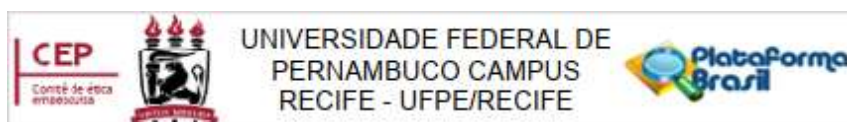
Objetivo Geral: Analisar o processo de implementação da iniciativa UAPI na perspectiva de profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família e cuidadores.

Objetivos Específicos:

1. Caracterizar as Unidades de Saúde UAPI e público alvo;
2. Compreender as percepções dos profissionais da Estratégia Saúde da Família e cuidadores durante a implantação da Unidade Amiga da Primeira Infância;
3. Apresentar as ações dos profissionais de saúde durante a implementação das UAPIS.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: Os riscos para as mães/cuidadores primários são: de constrangimento ao responder algumas questões, além disso, o não conhecimento sobre alguma das questões perguntadas, o tempo do participante dispensado a participar do estudo. Para minimizar o risco de constrangimento será informado que o mesmo poderá não responder alguma das questões caso não se sinta confortável. A entrevista será realizada em local reservado apenas com a presença do pesquisador e do participante, minimizando o risco de exposição, e a previsão de duração será informada ao participante antes do início da entrevista, e caso o mesmo decida, pode desistir de participar ou até mesmo interromper a qualquer momento. Para os profissionais de saúde são de constrangimento ao responder algumas questões, além disso, o não conhecimento sobre alguma das questões perguntadas, o tempo do participante dispensado a participar do estudo. Para minimizar o risco de constrangimento será informado que o mesmo poderá não responder alguma das questões caso não se sinta confortável. A entrevista será realizada em local reservado apenas com a presença do pesquisado e do participante, minimizando o risco de exposição, e a previsão de duração será informada ao participante antes do início da entrevista, e caso o mesmo decida,



Continuação do Parecer: 6.150.202

pode desistir de participar ou até mesmo interromper a qualquer momento.

Benefícios: Os benefícios para as mães e/ou cuidadores primários são: Os benefícios diretos são melhorar o atendimento às crianças no que tange às necessidades dos pais e/ou cuidadores primários, levar informações aos pais sobre como funciona uma Unidade Amiga da Primeira Infância. Os benefícios indiretos são que os dados poderão ser utilizados para melhoria no processo de ampliação da Iniciativa UAPI para outras Equipes do município, a partir de dados científicos e validados. Para os profissionais de saúde são: Os benefícios diretos são aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a primeira infância, promover uma avaliação do processo de implementação das Unidades Amigas da Primeira Infância. Os benefícios indiretos são que os dados poderão ser utilizados para melhoria no processo de ampliação da Iniciativa UAPI para outras Equipes do município, a partir de dados científicos e validados.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Sem comentários

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de inadequações".

Recomendações:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de inadequações".

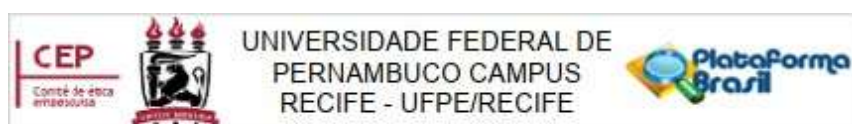
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências

Considerações Finais a critério do CEP:

As exigências foram atendidas e o protocolo está APROVADO, sendo liberado para o início da coleta de dados. Conforme as instruções do Sistema CEP/CONEP, ao término desta pesquisa, o pesquisador tem o dever e a responsabilidade de garantir uma devolutiva acessível e compreensível acerca dos resultados encontrados por meio da coleta de dados a todos os voluntários que participaram deste estudo, uma vez que esses indivíduos têm o direito de tomar conhecimento sobre a aplicabilidade e o desfecho da pesquisa da qual participaram.

Informamos que a aprovação definitiva do projeto só será dada após o envio da NOTIFICAÇÃO COM O RELATÓRIO FINAL da pesquisa. O pesquisador deverá fazer o download do modelo de Relatório Final disponível em www.ufpe.br/cep para enviá-lo via Notificação de Relatório Final, pela Plataforma Brasil. Após apreciação desse relatório, o CEP emitirá novo Parecer Consubstanciado definitivo pelo sistema Plataforma Brasil.



Continuação do Parecer: 8.150.202

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

RECIFE, 29 de Junho de 2023

Assinado por:
LUCIANO TAVARES MONTENEGRO
(Coordenador(a))

APÊNDICE 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa PERCEPÇÕES E AÇÕES DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E CUIDADORES DURANTE A IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADES AMIGAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM RECIFE-PE, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Wanderleya de Lavor Coriolano –Marinus, residente a Rua da Aurora, 1541, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, 50040090, telefone: 81-99449-7508, e-mail: mariawanderleya.coriolano@ufpe.br.

Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Sílvia Wanick Sarinho, Coorientadora, telefone: 81-98602-3948, e-mail: silvia.sarinho@ufpe.br, e Angélica Xavier da Silva, telefone: 81-982340681, e-mail: angélica.xavier@ufpe.br, e está sob a orientação de: Maria Wanderleya de Lavor Coriolano –Marinus, telefone: 81-99449-7508, e-mail: mariawanderleya.coriolano@ufpe.br.

Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.

O (a) senhor (a) estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

O comitê de ética e pesquisa em seres humanos (Resolução 510/2016), diz que a ética em pesquisa protege o respeito pela dignidade humana e proteção dos participantes das pesquisas nas quais pessoas participam, garantindo também a liberdade do participante.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

A presente pesquisa é sobre as percepções e ações de profissionais da estratégia da saúde da família e cuidadores durante a implementação das Unidades Amigas da Primeira Infância em Recife, Pernambuco. Sua realização justifica-se na necessidade de se compreender acerca

das percepções e ações dos profissionais de saúde no que diz respeito às mudanças implementadas nos seus conhecimentos (a partir do ciclo de capacitação), além de ações práticas no processo de trabalho em equipe e na relação direta com cuidadores/famílias. Seu objetivo é analisar o processo de implementação da iniciativa UAPI na perspectiva de profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família e cuidadores. Serão realizadas entrevistas individuais com os profissionais de saúde durante seu horário de trabalho, de maneira presencial, uma única vez, e dura em média 30 minutos, será solicitado aos mesmos que se dirijam a uma sala dentro da unidade de saúde de família, e que o seu telefone esteja no modo silencioso, você responderá treze questões.

Os riscos são de constrangimento ao responder algumas questões, além disso, o não conhecimento sobre alguma das questões perguntadas, o tempo do participante dispensado a participar do estudo. Para minimizar o risco de constrangimento será informado que o mesmo poderá não responder alguma das questões caso não se sinta confortável. A entrevista será realizada em local reservado apenas com a presença do pesquisado e do participante, minimizando o risco de exposição, e a previsão de duração será informada ao participante antes do início da entrevista, e caso o mesmo decida, pode desistir de participar ou até mesmo interromper a qualquer momento.

Os benefícios diretos são aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a primeira infância, promover uma avaliação do processo de implementação das Unidades Amigas da Primeira Infância. Os benefícios indiretos são que os dados poderão ser utilizados para melhoria no processo de ampliação da Iniciativa UAPI para outras Equipes do município, a partir de dados científicos e validados.

Após a finalização da pesquisa, você será convidado a participar de uma reunião, na qual serão apresentados os resultados da pesquisa, esse evento acontecerá na Unidade de Saúde da Família, e será previamente agendado de acordo com a sua disponibilidade.

Esclarecemos que os participantes dessa pesquisa têm plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores. Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa serão gravações e ficarão armazenados em computador pessoal, sob a responsabilidade de Maria Wanderleya de Lavor Coriolano –Marinus, no endereço Rua da Aurora, 1541, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, 50040090 , pelo período de mínimo 5 anos após o término da pesquisa.

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o (a) senhor (a) poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br).

(assinatura do pesquisador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu, _____, CPF _____, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo PERCEPÇÕES E AÇÕES DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E CUIDADORES DURANTE A IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADES AMIGAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM RECIFE-PE, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).

Impressão
digital

(opcional)

Local e data _____

Assinatura do participante: _____

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura:

ANEXOS

ANEXO 1

Lista de códigos, temas e ocorrências encontrados nas entrevistas.

Dimensão	Facilitador/Barreira	Código	Tema emergente	Ocorrências
Alcance	Facilitador	Orientações nas visitas	Visita domiciliar qualificada e orientações precoces	2
Alcance	Facilitador	Acolhimento nas visitas	Acolhimento e vínculo com a família	1
Alcance	Facilitador	Busca ativa de vacinação	Busca ativa e mobilização para imunização	4
Alcance	Facilitador	Parceria Mãe Coruja para mobilização	Parcerias intersetoriais (Mãe Coruja/CRAS/NASF)	1
Alcance	Barreira	Alcance limitado/baixa adesão	Baixa participação comunitária nas ações coletivas	1
Alcance	Facilitador	Repasse de conhecimento às famílias	Educação em saúde nas visitas/ações	1
Alcance	Facilitador	Convites e lanches em ações	Estratégias de engajamento comunitário	1
Alcance	Facilitador	Ações coletivas (palestras/salas de espera)	Ações coletivas e salas de espera/reuniões comunitárias	2

Alcance	Barreira	Alcance limitado/sem acesso	Cobertura/alcance insuficiente	1
Alcance	Barreira	Vacinação condicionada ao Bolsa Família	Condicionamento por programas sociais	2
Alcance	Barreira	Comunicação deficiente/sem devolutiva	Falta de devolutiva/comunicação com gestão	2
Alcance	Facilitador	Integração intersetorial (saúde/educação/assistência)	Integração intersetorial	1
Alcance	Facilitador	Olhar para o território	Territorialização	1
Alcance	Facilitador	Escuta de famílias e crianças	Participação social/escuta	1
Alcance	Facilitador	Organização com ACS e famílias	Engajamento e mobilização territorial	1
Alcance	Facilitador	Equipe 4 em destaque por captação	Captação/expansão de cobertura	1
Alcance	Facilitador	Ampliação de unidades (escala)	Escala e expansão	1
Efetividade	Facilitador	Resultados percebidos com as crianças	Efeitos percebidos nas crianças	1
Efetividade	Facilitador	Sensibilidade e vínculo com famílias	Acolhimento e comunicação empática	1
Efetividade	Facilitador	Melhora de indicadores	Melhoria de indicadores	1
Efetividade	Facilitador	Sentinela/alerta da equipe	Vigilância ativa da equipe	1
Efetividade	Facilitador	Educação em amamentação (técnicas/pega)	Promoção do aleitamento materno	3

Efetividade	Barreira	Baixa adesão/resistência familiar	Resistência/baixa adesão familiar (inclui influência das redes)	4
Efetividade	Barreira	Vulnerabilidade social/violência no território	Vulnerabilidade social e contextos de risco	6
Efetividade	Facilitador	Orientação a mães adolescentes	Apoio a adolescentes e parentalidade	1
Efetividade	Facilitador	Atualização sobre desenvolvimento infantil	Aprimoramento técnico em desenvolvimento infantil	1
Efetividade	Facilitador	Atualização sobre vacinação	Atualização técnica em imunização	1
Efetividade	Facilitador	Orientações sobre telas e brincar	Promoção do brincar e redução de telas	1
Efetividade	Facilitador	Melhora por intensificação e registro	Cultura do registro e melhoria	1
Efetividade	Barreira	Vulnerabilidade social impacta práticas	Determinantes sociais	1
Efetividade	Barreira	Fake news entre profissionais	Desinformação	1
Efetividade	Facilitador	Cobertura vacinal 100%	Resultados em imunização	1
Efetividade	Facilitador	Melhora quadrimestre a quadrimestre	Melhora temporal/monitoramento	1
Adoção	Facilitador	Motivação para capacitação e cuidado	Motivação intrínseca (capacitação/cuidado)	5
Adoção	Facilitador	Colaboração intraequipe	Integração da equipe	2

Adoção	Facilitador	Colaboração multiprofissional/inter setorial	Parcerias intersetoriais	2
Adoção	Facilitador	Adoção na rotina da unidade	Rotinização das práticas	2
Adoção	Barreira	Adesão por obrigação/baixa motivação	Engajamento limitado/obrigatoriedade	4
Adoção	Barreira	Resistência inicial/gestão por resultados	Resistência ao modelo de gestão por resultados	2
Adoção	Barreira	Adoção não homogênea entre equipes	Heterogeneidade de adesão	1
Adoção	Facilitador	Equipe sensibilizada/proativa	Proatividade de equipes	2
Implementação	Facilitador	Implementação na rotina	Aplicação cotidiana no atendimento	1
Implementação	Barreira	Implementação limitada	Inserção parcial das ações	2
Implementação	Barreira	Manutenção limitada (descontinuidade pós-evento)	Descontinuidade pós-evento	2
Implementação	Barreira	Excesso de demanda/queda de acompanhamento	Sobrecarga e tempo insuficiente	2
Implementação	Barreira	Falta de espaço/tempo para curso	Falta de tempo/condições para formação	1
Implementação	Barreira	Deficiência estrutural (balança/salas/auditório)	Infraestrutura e insumos insuficientes	3

Implementação	Barreira	Curso pouco acessível/burocrático (plataforma/login)	Acesso difícil à plataforma de curso	3
Implementação	Barreira	Comunicação/gestão deficiente (PEC/e-SUS/sem diálogo/verticalização)	Gestão e sistemas de informação/comunicação problemáticos	6
Implementação	Facilitador	Educação permanente com ACS	Educação permanente	1
Implementação	Facilitador	Uso de PEC/listas para busca ativa	Uso de sistemas e dados	1
Implementação	Barreira	Falta de material educativo	Materiais didáticos insuficientes	2
Implementação	Barreira	Ações custeadas pelos ACS	Custeio pessoal das ações	1
Implementação	Barreira	Deficiência de recursos físicos/insumos	Infraestrutura e insumos insuficientes	3
Implementação	Barreira	Falta de espaço físico	Espaço físico inadequado	2
Implementação	Barreira	Falta de apoio multiprofissional/integração	Integração multiprofissional frágil	2
Implementação	Barreira	Curso distante/utópico da realidade	Desalinhamento curso–realidade	3
Implementação	Barreira	Sobrecarga pós-pandemia nas equipes	Sobrecarga de trabalho	1
Implementação	Facilitador	Cultura do registro/gestão por resultados	Cultura do registro	1
Implementação	Barreira	Lacuna de registro	Falhas de registro	2

Implementação	Facilitador	Painel de indicadores (online)	Ferramentas de monitoramento	1
Implementação	Facilitador	Metodologia e assistência técnica	Suporte metodológico e técnico	1
Implementação	Barreira	Diferenças entre territórios (equidade)	Equidade territorial	1
Implementação	Facilitador	Planilhas territoriais como suporte	Gestão local de dados	2
Implementação	Barreira	Inconsistências do PEC	Inconsistências sistêmicas (PEC)	1
Implementação	Facilitador	Reuniões fixas (fluxo mensal)	Governança de rotina	1
Implementação	Barreira	Listagens desatualizadas	Dados cadastrais desatualizados	1
Implementação	Facilitador	Facilitadores da casa no território	Facilitadores locais	1
Implementação	Facilitador	Licitação de materiais/formação de tutores	Investimento em insumos e formação	1
Manutenção	Barreira	Falta de monitoramento/apoio para curso	Ausência de monitoramento e suporte	2
Manutenção	Barreira	Falta de materiais/recursos	Materiais didáticos e recursos escassos	1
Manutenção	Facilitador	Educação continuada/atualizações	Educação permanente	3
Manutenção	Facilitador	Manual/cronograma claro	Protocolos e roteiros práticos	1
Manutenção	Facilitador	Curso com parte presencial	Modalidade presencial/híbrida como incentivo	1

Manutenção	Facilitador	Materiais educativos necessários	Materiais didáticos e recursos	1
Manutenção	Facilitador	Continuidade via visitas/ACS	Sustentação via visitas/rotina	3
Manutenção	Barreira	Descontinuidade das ações	Descontinuidade pós-capacitação	1
Manutenção	Barreira	Falta de continuidade/monitoramento pós-capacitações	Ausência de monitoramento	2
Manutenção	Barreira	Dificuldade de manter cronogramas	Planejamento vs execução	2
Manutenção	Barreira	Falta de apoio para manutenção	Insuficiência de suporte	1
Manutenção	Barreira	Tempo/ciclo curto para impacto	Ciclo curto/tempo insuficiente	2
Manutenção	Facilitador	Formações focalizadas e recorrentes	Educação continuada	1
Manutenção	Facilitador	Sustentabilidade institucional (3º ciclo/política de Estado/indicadores MS)	Institucionalização/Política de Estado	3
Manutenção	Barreira	Materiais didáticos insuficientes	Materiais didáticos escassos	1
Manutenção	Facilitador	Devolutivas/feedback para engajar	Feedbacks e devolutivas	1
Manutenção	Facilitador	Escuta protegida/trocas entre equipes	Escuta/rodas de troca	1
TOTAL				148

